Perfil V3 · código por código

Gastroenterología

Los 64 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Gastroenterología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 30 códigos

1.06.1.001 Ascitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa más frecuente: cirrosis con hipertensión portal; otras: carcinomatosis peritoneal, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, TBC.
- Paracentesis diagnóstica a todo paciente con ascitis de reciente inicio o cirrótico con ascitis que se hospitaliza o descompensa: GASA ≥1,1 g/dL = hipertensión portal; albúmina en líquido <1,5 g/dL = alto riesgo de PBE; PMN ≥250/mm³ = PBE.
- Manejo inicial de la no complicada: restricción de sodio (no de agua) + espironolactona ± furosemida; controlar peso, función renal y electrolitos.
- Ascitis a tensión: paracentesis evacuadora con albúmina ~8 g por litro extraído (si >5 L), previa paracentesis diagnóstica para descartar PBE.
- Evitar AINE y aminoglucósidos. Refractaria: paracentesis seriadas con albúmina, TIPS o trasplante.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/hepatología para estudio etiológico y evaluación de trasplante.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con cirrosis por alcohol, en control ambulatorio, consulta por aumento del perímetro abdominal en la última semana y febrículas. Examen: ascitis moderada, sin dolor peritoneal, sin encefalopatía. Hemodinámicamente estable. **¿Cuál es la primera conducta?**

A) Aumentar la dosis de espironolactona y furosemida
B) Paracentesis diagnóstica
C) Paracentesis evacuadora de gran volumen sin estudio del líquido
D) Iniciar lactulosa
E) Derivar para instalación de TIPS

Respuesta B. Cirrótico con ascitis y fiebre: la primera conducta es la paracentesis diagnóstica para descartar PBE, antes de ajustar diuréticos o evacuar. Si hay ≥ 250 PMN/mm³, cefotaxima endovenosa + albúmina. Aunque la fiebre sea baja y no haya dolor, obliga a puncionar.

Pregunta de práctica

Cirrótico con ascitis refractaria a diuréticos que además ha tenido dos episodios de encefalopatía hepática en el último mes. El equipo tratante propone instalar un TIPS para controlar la ascitis. **¿Cuál es la conducta correcta?**

A) Instalar el TIPS: resuelve simultáneamente la ascitis y reduce el riesgo de várices
B) No instalar el TIPS: la encefalopatía es una contraindicación
C) Instalar el TIPS solo si se agrega lactulosa profiláctica
D) Instalar el TIPS y suspender los betabloqueadores
E) Instalar el TIPS con anestesia general para evitar la descompensación

Respuesta B. El TIPS hace que la sangre intestinal "salte" el hígado: alivia la hipertensión portal, pero aumenta el amonio y las toxinas que llegan al cerebro. La encefalopatía, aun leve o recurrente, lo contraindica. Se mantienen paracentesis seriadas con albúmina y se prioriza la evaluación para trasplante.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 125 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente fumador de 20 paquetes-año, que consume cerca de 5 g de alcohol al día los fines de semana, presenta moles8as abdominales inespecíficas y distensión abdominal progresiva desde hace 3 meses, a lo que en el úl8mo 8empo se agregó dolor abdominal. Se observa el paciente enflaquecido, con FC: 70x', PA: 130/80 mmHg y, en el examen abdominal, se constata asci8s a tensión, sin circulación colateral. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT: 48 U/L, GPT: 37 U/L, GGT: 59 U/L, bilirrubina total: 1,3 mg/dL, bilirrubina directa: 0,3 mg/dL, protrombinemia: 80% y albuminemia: 2,9 g/dL. Además, se realiza paracentesis diagnós8ca que muestra líquido ascí8co con 680 células/mm³, 80% mononucleares y 20% polimorfonucleares, glucosa: 116 mg/dL, proteínas: 1,36 g/dL y ADA: 3,4 U/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Peritoni2s bacteriana espontánea
B) Asci2s por hipertensión portal
C) Síndrome nefró2co
D) Tuberculosis peritoneal
E) Carcinomatosis peritoneal

Respuesta E. Parece una carcinomatosis tanto por la clínica de cáncer (fumador, baja de peso, cuadro progresivo) como por el análisis con un exudado mononuclear y ADA baja (se interpreta similar al estudio de líquido pleural). No es una PBE (peritoniGs bacteriana espontánea), ya que requiere más de 250 PMN y predominio PMN.

1.06.1.002 Cáncer de páncreas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto mayor con ictericia progresiva e indolora, baja de peso, dolor epigástrico sordo irradiado al dorso; tumor de cabeza de páncreas es el más frecuente.
- Las '3 D': diabetes de reciente inicio en adulto mayor, depresión inexplicada y dolor sordo; signo de Courvoisier-Terrier (vesícula palpable e indolora con ictericia).
- Laboratorio: patrón colestásico (bilirrubina directa, FA y GGT altas); CA 19-9 sirve para seguimiento, no para diagnóstico.
- Estudio: ecografía primero (vía biliar dilatada, masa) y luego TAC de abdomen con contraste (examen de elección para el páncreas y etapificación).
- Mal pronóstico; solo la resección (Whipple) es potencialmente curativa en tumores resecables; en irresecables, paliación de la ictericia con prótesis por CPRE.
- Seguimiento: derivar a cirugía/oncología.

PREGUNTAS (5)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años con ictericia progresiva de 6 semanas, prurito, coluria y baja de 8 kg. Sin dolor abdominal ni fiebre. Diabetes diagnosticada hace 2 meses. Al examen: ictericia marcada y vesícula palpable, no dolorosa. Laboratorio con patrón colestásico. **Tras la ecografía, que sugiere una masa pancreática, ¿cuál es el examen de elección?**

A) CPRE diagnóstica
B) TAC de abdomen con contraste
C) Colangiorresonancia
D) Biopsia hepática percutánea
E) Anticuerpos antimitocondriales

Respuesta B. Ictericia indolora, baja de peso, diabetes reciente y signo de Courvoisier-Terrier: cáncer de cabeza de páncreas. La ecografía va primero; si sugiere masa pancreática, el examen de elección es el TAC con contraste. La colangiorresonancia es de elección para la vía biliar, no para el páncreas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años consulta por ictericia de dos semanas de evolución, que ha ido en aumento y se ha asociado a orinas oscuras. Como antecedente, es hipertenso y fumador de 5 paquetes-año. Su examen Fsico muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones en el examen abdominal. Se solicitan pruebas hepá8cas que muestran SGOT: 72 U/L, SGPT: 48 U/L, GGT: 115 U/L, fosfatasa alcalina 200: U/L y bilirrubina: 4,9 mg/dL, de predominio directo. Se realiza ecograFa abdominal que muestra vesícula biliar dilatada de 16 × 8 cm y dilatación de la vía biliar intrahepá8ca y extrahepá8ca. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Tumor de páncreas
B) Colangiocarcinoma
C) Colangi2s esclerosante primaria
D) Diveraculo duodenal
E) Colangi2s infecciosa

Respuesta A. Es una pregunta algo difícil. Tiene una ictericia obstructiva, con un patrón colestásico, lo que hace sospechar un cáncer que obstruye la vía biliar. La dilatación de la vesícula (signo de Courvoisier-Terrier) y la dilatación de la vía biliar extrahepática es característica de la obstrucción distal del colédoco, por lo que lo más probable es que sea un cáncer de cabeza de páncreas. El antecedente

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 66 · texto original del banco, sin revisar

Adulto fumador con ictericia, coluria, prurito y acolia, con patrón colestásico. ¿Diagnóstico más probable?

A) Coledocolitiasis
B) Colangitis esclerosante primaria
C) Hepatitis viral colestásica
D) Colangiocarcinoma
E) Cáncer de páncreas

Respuesta E. Diagnóstico: Cáncer de páncreas (opción E). Cáncer de páncreas. Esta clase aborda cómo diferenciar la insuficiencia renal aguda de la crónica en la práctica clínica, dado que el paciente habitualmente no sabe cuánto tiempo lleva con la creatinina elevada. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 147 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 80 años presenta una clínica de 3 semanas de evolución de astenia, prurito e ictericia, asociada a malestar epigástrico. Además, refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Su examen físico muestra ictericia de piel y escleras, IMC: 19, signos vitales dentro de límites normales y examen abdominal que no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina plasmática: 12,4 mg/dl, con bilirrubina directa: 7,7 mg/dl, GOT: 120 UI/L, GPT: 89 UI/L, fosfatasas alcalinas: 870 UI/L y GGT: 688 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Coledocolitiasis
B) Cáncer ampular
C) Cáncer de páncreas
D) Colangiocarcinoma
E) Colangitis aguda

Respuesta C. Diagnóstico: Cáncer de páncreas (opción C). Esta clase aborda cómo diferenciar la insuficiencia renal aguda de la crónica en la práctica clínica, dado que el paciente habitualmente no sabe cuánto tiempo lleva con la creatinina elevada. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 52 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 49 años, fumador, presenta un cuadro de dispepsia postprandial de 4 meses de evolución, asociado a astenia, palidez, ictericia y prurito, que aumenta en las noches. Se solicitan exámenes que muestran hemograma normal y pruebas hepáticas que resultan GOT: 23 UI/L, GPT: 28 UI/L, bilirrubina total: 9,7 mg/dl, bilirrubina directa: 8,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 322 UI/L y GGT: 131 UI/L, con protrombinemia 80% y albúmina: 3,2 g/dl. El examen de elección para el estudio de este paciente es:

A) Endoscopía digestiva alta
B) Ecotomografía abdominal
C) TAC abdominal
D) Colangiografía por RMN
E) Colangiografía endoscópica retrógrada

Respuesta C. Es un probable cáncer con obstrucción de la vía biliar (colestasia silente), probable cáncer de páncreas, por ser fumador. Es una pregunta muy difícil, porque el examen de primera línea de la colestasia silente es la Ecografía abdominal, mientras que el examen de elección, para el cáncer de páncreas en específico, es el TAC abdominal con contraste. Finalmente, el mejor examen para ver las icterici

1.06.1.003 Cáncer de vesícula y vías biliares

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile tiene una de las tasas más altas del mundo de cáncer de vesícula; factor principal: colelitiasis de larga data (más en mujeres, mapuches, obesas).
- Prevención GES: colecistectomía preventiva en personas de 35 a 49 años con colelitiasis; en Chile toda colelitiasis se opera, incluso asintomática.
- Otros factores: vesícula en porcelana o escleroatrófica, pólipos ≥10 mm, colangitis esclerosante primaria.
- Clínica tardía e inespecífica: dolor en hipocondrio derecho, baja de peso, ictericia (por invasión de la vía biliar), masa palpable. Colangiocarcinoma: ictericia indolora progresiva.
- Estudio: ecografía, luego TAC o RM; muchos se descubren en la biopsia de una colecistectomía (si es invasor, reoperación con colecistectomía radical).
- Seguimiento: derivar a cirugía digestiva/oncología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 180

Mujer de 91 años, diabética, con antecedente de cólicos biliares a repetición, consulta por astenia, decaimiento, ictericia marcada y orinas oscuras de 3 semanas de evolución, asociadas a dolor epigástrico moderado. Al examen físico se aprecia ictericia de piel y mucosas y se palpa una masa en el hipocondrio derecho. Las pruebas hepáticas muestran SGOT 60 UI/L, SGPT 56 UI/L, GGT 570 UI/L, FA 755 UI/L, bilirrubina total 21 mg/dL y bilirrubina directa 19 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de la cabeza de páncreas
B) Cáncer de vesícula
C) Colangiocarcinoma
D) Hepatocarcinoma
E) Cáncer de la ampolla de Vater

Respuesta B. Colestasia marcada con masa en hipocondrio derecho en una mujer mayor con cólicos biliares de larga data orienta a cáncer de vesícula, muy frecuente en Chile. La colelitiasis es su principal factor de riesgo, y por eso existe la colecistectomía preventiva GES entre los 35 y 49 años.

1.06.1.004 Cáncer gástrico

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile: 1.ª causa de muerte por cáncer en hombres y 2.ª en mujeres. Causa principal H. pylori; también atrofia y metaplasia intestinal, familiar con cáncer gástrico, sal y ahumados.

- Sospechar: epigastralgia idéntica a la úlcera en ≥40 años, baja de peso, anemia ferropénica, síndrome pilórico (vómitos de retención), masa o ganglio de Virchow.
- Endoscopía digestiva alta con biopsias (GES) a todo paciente ≥40 años con epigastralgia o con signos de alarma; toda úlcera gástrica se biopsia.
- Etapificación con TAC de tórax, abdomen y pelvis; incipiente si no pasa la submucosa (independiente de las adenopatías), avanzado si compromete la muscular propia.
- Tratamiento: incipiente resección endoscópica o gastrectomía; avanzado gastrectomía con linfadenectomía D2 + quimioterapia perioperatoria.
- Seguimiento: derivar a cirugía digestiva/oncología (GES).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 121

Un paciente de 55 años presenta pirosis, mayor postprandial, que inició hace 2 meses y ha ido en aumento. Además tiene baja de 4 kg de peso en ese periodo, dolor abdominal que aumenta al palpar el epigastrio, y en el último tiempo se han agregado vómitos postprandiales. **¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar a este paciente?**

A) Endoscopía digestiva alta
B) pH-metría de 24 horas
C) TAC de abdomen
D) Ecografía abdominal
E) Marcadores tumorales

Respuesta A. Baja de peso, dolor epigástrico y vómitos postprandiales en dos meses es un cuadro sospechoso de cáncer gástrico. Lo primero, siempre, es confirmarlo con endoscopía digestiva alta y biopsia; el TAC y los marcadores vienen después, si el diagnóstico se confirma.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 91

Un hombre de 57 años presenta epigastralgia, inapetencia y baja de peso, de 2 meses de evolución, a lo cual se agrega un episodio de melena, por el que consulta. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer gástrico
B) Úlcera gastroduodenal
C) Cáncer de esófago
D) Linfoma gástrico asociado a mucosa
E) Gastritis erosiva

Respuesta A. Epigastralgia, inapetencia y baja de peso, con melena que confirma una hemorragia digestiva alta, es el cuadro clásico del cáncer gástrico. La úlcera daría dolor urente pero sin baja de peso marcada, y el cáncer de esófago daría disfagia, más que inapetencia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 133

Paciente de 65 años, con antecedente de tabaquismo crónico de 30 paquetes-año, consulta por 3 meses de compromiso del estado general, pirosis y baja de 10 kg de peso. Al examen físico se aprecia decaído, deshidratado y muy enflaquecido, con leve edema simétrico en las extremidades inferiores. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer pulmonar
B) Cáncer gástrico
C) Cáncer de esófago
D) Cáncer de páncreas
E) Cáncer de duodeno

Respuesta B. La pirosis y la gran baja de peso orientan a estómago; no hay disfagia, que es lo clásico del cáncer de esófago. El edema de extremidades inferiores se explica por la desnutrición proteica de un cáncer avanzado, no por el tabaquismo.

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años con 3 meses de plenitud posprandial y vómitos de alimentos ingeridos horas antes, cada vez más frecuentes, y baja de 9 kg. Al examen: chapoteo gástrico de ayuno y una pequeña adenopatía supraclavicular izquierda. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Úlcera duodenal no complicada
B) Cáncer gástrico avanzado con obstrucción de la salida gástrica
C) Acalasia
D) Dispepsia funcional
E) Cáncer de páncreas

Respuesta B. Síndrome pilórico (vómitos de retención en aumento) con baja de peso y ganglio de Virchow: cáncer gástrico avanzado hasta demostrar lo contrario. Se confirma con endoscopía y biopsias y se etapifica con TAC. La adenopatía supraclavicular indica enfermedad metastásica y contraindica la cirugía curativa.

1.06.1.005 Cirrosis hepática

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas: alcohol, hígado graso metabólico (NASH), virus B y C, autoinmunes. Estigmas: arañas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, circulación colateral, esplenomegalia.
- Diagnóstico: clínica + laboratorio (plaquetas bajas, albúmina baja, INR alto, bilirrubina) + ecografía (hígado nodular, esplenomegalia, ascitis); fibrosis por elastografía o biopsia.
- Gravedad con Child-Pugh (bilirrubina, albúmina, INR, ascitis, encefalopatía) y MELD.
- Manejo inicial: tratar la causa (abstinencia de alcohol, antivirales), vacunar contra hepatitis A y B, neumococo e influenza; evitar AINE y sedantes; no restringir proteínas.
- Endoscopía a todo cirrótico para buscar várices (propranolol o carvedilol si nunca sangraron); ecografía ± AFP cada 6 meses para tamizaje de hepatocarcinoma.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología; descompensación (ascitis, HDA, encefalopatía, PBE) obliga a hospitalizar y evaluar trasplante.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Paciente con cirrosis y várices esofágicas medianas encontradas en una endoscopía de tamizaje. Nunca ha presentado hemorragia digestiva. **¿Cuál es la profilaxis indicada?**

A) Ligadura endoscópica de várices + propranolol
B) Propranolol (o carvedilol) por vía oral, titulado por frecuencia cardíaca
C) Instalación electiva de TIPS
D) Terlipresina endovenosa mensual
E) Ácido tranexámico oral permanente

Respuesta B. Profilaxis primaria (nunca sangró): betabloqueo no selectivo, titulado para reducir la frecuencia cardíaca. La ligadura se añade en la profilaxis secundaria o se usa sola si el betabloqueo está contraindicado (asma, EPOC grave, intolerancia).

1.06.1.006 Colelitiasis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Cólico biliar: dolor sordo en epigastrio o hipocondrio derecho de 30–60 min, tras comidas grasas, con náuseas, que cede solo.
- Diagnóstico con ecografía abdominal: imagen hiperecogénica con sombra acústica en la vesícula.
- Manejo agudo: analgesia con dipirona + antiespasmódico (o AINE); régimen hipograso.
- En Chile toda colelitiasis se opera (incluso asintomática) por riesgo de complicaciones y de cáncer de vesícula; GES de colecistectomía preventiva entre 35 y 49 años.

- Sumar síntomas: + fiebre/Murphy = colecistitis; + ictericia = coledocolitiasis; + ictericia + fiebre = colangitis; dolor al dorso con lipasa alta = pancreatitis.
- Seguimiento: derivar a cirugía para colecistectomía laparoscópica electiva.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 146

Paciente de 55 años con 3 días de dolor abdominal, mayor en epigastrio, con vómitos alimentarios. Ecografía: vía biliar de 8 mm, con múltiples cálculos pequeños en la vesícula. Fosfatasas alcalinas 520 U/L, GGT 612 U/L, GOT 102 U/L, GPT 87 U/L, bilirrubina total 6,0 mg/dL (directa 4,6). **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
B) Indicar colangiorresonancia
C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
D) Resolver quirúrgicamente
E) Indicar tratamiento analgésico y antibiótico endovenoso

Respuesta B. Dolor con patrón colestásico y colédoco dilatado, sin fiebre ni compromiso hemodinámico: coledocolitiasis, sin criterios de colangitis. Como la ecografía no vio el cálculo directamente, el paso siguiente es confirmar con colangiorresonancia, y recién si esta lo ve, se hace la CPRE.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 66

Un paciente de 55 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico destacan escleras ictéricas, sensibilidad a la palpación epigástrica. Se realizan exámenes donde destaca leucocitos 13.000/mm³, PCR 50 mg/dL, GOT 120 U/L, GPT 140 U/L, bilirrubina 3 mg/dL, fosfatasas alcalinas 400 U/L, lipasa 100 U/L. Ecografía abdominal con vía biliar extrahepática dilatada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colangitis aguda
B) Pancreatitis aguda
C) Colecistitis aguda
D) Coledocolitiasis
E) Hepatitis aguda

Respuesta D. Tiene una coledocolitiasis: patrón colestásico con vía biliar dilatada. La lipasa está elevada pero no llega a tres veces el límite superior normal, así que no cumple criterio de pancreatitis. Los leucocitos y la PCR llaman la atención, pero la clínica no alcanza para colangitis, que exige la tríada de Charcot completa.

Pregunta de práctica

Mujer de 40 años, sin síntomas, a quien en una ecografía de rutina se le detecta colelitiasis (múltiples cálculos, vesícula de pared normal). **¿Cuál es la conducta?**

A) Observación; operar solo si aparecen síntomas
B) Ácido ursodesoxicólico para disolver los cálculos
C) Colecistectomía laparoscópica electiva
D) Dieta baja en grasas y control ecográfico anual
E) Colecistectomía solo si los cálculos superan los 2 cm

Respuesta C. En Chile, con la incidencia de cáncer de vesícula más alta del mundo, toda colelitiasis, aun asintomática, se trata con colecistectomía laparoscópica electiva. El GES la garantiza entre los 35 y 49 años. La disolución y la observación no protegen del cáncer.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 174 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta dolor intermitente en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org El diagnóstico más probable es:

A) Colelitiasis
B) Coledocolitiasis
C) Colangiocarcinoma
D) Cáncer de vesícula
E) Colecistitis

Respuesta A. Es una imagen clásica de cálculos biliares, con la sombra acústica característica de los cálculos. La clínica son cólicos biliares.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 36 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente presenta hace una semana dolor en el hipocondrio derecho, intenso, asociado a vómitos, que cede espontáneamente. Actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para estudiar a este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) Radiografía de abdomen
C) Amilasa / Lipasa
D) Colangioresonancia
E) TAC de abdomen

Respuesta A. Probablemente tiene una colelitiasis (clínica de cólico biliar). Se estudia con Eco. En agudo sí debió haberse pedido la amilasa/lipasa para descartar pancreatitis, pero ahora solo hay que descartar la colelitiasis.

1.06.1.007 Colestasia

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Ictericia con bilirrubina directa >30 % del total y FA + GGT elevadas (la GGT confirma el origen hepatobiliar; FA alta con GGT normal: hueso).
- Con dolor: coledocolitiasis; con dolor + fiebre + ictericia (Charcot): colangitis, urgencia. Sin dolor en adulto mayor con baja de peso: cáncer (páncreas primero).
- Crónicas autoinmunes: colangitis biliar primaria (mujer 40–60, prurito, AMA +, ácido ursodesoxicólico) y colangitis esclerosante primaria (hombre joven con colitis ulcerosa, p-ANCA).
- Estudio siempre primero con ecografía (vía biliar dilatada, colédoco >6–7 mm, masa); luego colangiorresonancia para la vía biliar o TAC si se sospecha masa pancreática.
- Manejo inicial: analgesia, suspender fármacos colestásicos; colangitis: volumen + antibióticos + CPRE urgente.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología o cirugía según la causa.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 174

Mujer de 54 años se realiza exámenes como parte de un chequeo médico, que muestran GOT 43 UI/L, GPT 70 UI/L, GGT 433 UI/L, FA 531 UI/L, bilirrubina total 3,0 mg/dL, albúmina 3,7 g/dL y protrombinemia 88 %. **¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?**

A) Colestasia por esteatosis hepática
B) Cirrosis biliar primaria
C) Colestasia por compresión externa
D) Colangitis esclerosante primaria
E) Colangitis esclerosante secundaria

Respuesta B. Mujer de edad media con colestasia de laboratorio (FA y GGT muy elevadas, transaminasas casi normales) y función hepática conservada: lo más probable es la cirrosis biliar primaria, hoy llamada colangitis biliar primaria. Se confirma con anticuerpos antimitocondriales. La colangitis esclerosante primaria es más propia de hombres con colitis ulcerosa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 49 años consulta prurito generalizado, que es mayor en las palmas y plantas y que aumenta en la noche. Se realiza pruebas hepáticas que muestran GOT: 48 UI/L, GPT: 50 UI/L, GGT: 710 UI/L, FA: 689 UI/L, bilirrubina total: 2,0 mg/dl y bilirrubina directa: 0,6 mg/dl, albúmina: 4,0 g/dl y protrombinemia 100%. El examen de elección para proseguir el diagnóstico es:

A) Cuantificación de inmunoglobulina E sérica
B) Colangioresonancia
C) Ácidos biliares
D) Anticuerpos antinucleares
E) Anticuerpos antimitocondriales

Respuesta E. Tiene una colestasia clínica (prurito palmoplantar mayor en la noche) y de laboratorio (elevación de la GGT, FA y bilirrubina). Por la edad y por ser mujer, lo más probable es que sea una cirrosis biliar primaria (CBP), por lo que se estudia con los AMA (anticuerpos antimitocondriales) y luego se confirma con la biopsia hepática (se trata con ácido ursodeoxicólico, que ayuda a disminuir los síntom

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 49 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 55 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran GOT: 54 UI/L, GPT: 70 UI/L, GGT: 654 UI/L, FA: 455 UI/L, bilirrubina total: 1,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 90%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A) Coledocolitiasis
B) Cirrosis biliar primaria
C) Colestasia por obstrucción neoplásica
D) Colangitis esclerosante primaria
E) Colangitis esclerosante secundaria

Respuesta B. Tiene colestasia en las pruebas hepáticas, sin hepatitis (por las GOT y GPT mínimamente elevadas) ni falla hepática (protrombinemia y albúmina normales). Por ser mujer y de esa edad lo más probable es una CBP, la que, además, se demora en elevar la bilirrubinemia, afectando mucho más las FA y luego la GGT. La coledocolitiasis tendría dolor y mucha más ictericia. El cáncer produce bastante icterici

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 118 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 40 años presenta marcada astenia y prurito intenso, en particular en las manos, que no ha respondido al tratamiento antihistamínico, indicado por el dermatólogo. En sus exámenes tiene hematocrito: 42%, blancos: 5.000, con 9% de eosinófilos, GOT: 58 UI/L, GPT: 39 UI/L, GGT: 300 UI/L, bilirrubina 2,0 UI/l, FA: 700 UI/L. ¿CUál es el examen para continuar el estudio?

A) Serología de virus hepatitis
B) Anticuerpos antinucleares
C) Ecografía hepática
D) Parasitológico de deposiciones
E) Anticuerpos antimitocondriales

Respuesta E. Cuadro de cirrosis biliar primaria. Se estudia con anticuerpos antimitocondriales (AMA). Luego la Biopsia hepática).

1.06.1.008 Trastornos digestivos funcionales

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable

QUÉ HAY QUE SABER

- Síntomas digestivos crónicos sin lesión estructural (eje cerebro-intestino, hipersensibilidad visceral); diagnóstico positivo, no de descarte.
- Intestino irritable (Roma IV): dolor abdominal ≥1 día/semana en los últimos 3 meses + ≥2 de: relación con la defecación, cambio de frecuencia o de consistencia. Dispepsia funcional: requiere endoscopía normal.
- Descartar alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio reciente del hábito, disfagia, inicio >50 años, familiar con cáncer, hemorragia o síntomas nocturnos; ante alarma, EDA o colonoscopía.
- Exámenes básicos: hemograma, PCR, TSH, serología celíaca; calprotectina si hay diarrea.
- Tratamiento: educación y explicar benignidad, manejo del estrés, dieta baja en FODMAP y fibra soluble; dolor: antiespasmódicos (trimebutino, pinaverio); diarrea: amitriptilina en dosis baja; constipación: polietilenglicol.
- Seguimiento completo en APS; reevaluar si aparecen signos de alarma.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años con 8 meses de dolor en hipogastrio que alivia tras defecar, con períodos alternados de diarrea y constipación. Sin baja de peso, rectorragia ni anemia. Examen físico y hemograma normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Colonoscopía para descartar cáncer de colon
B) TAC de abdomen y pelvis con contraste
C) Diagnosticar SII e iniciar educación y dieta baja en FODMAP
D) Endoscopía digestiva alta con biopsias
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta C. Cumple Roma IV (dolor recurrente relacionado con la defecación, con cambio en la frecuencia y forma de las deposiciones) y no tiene signos de alarma. El diagnóstico de SII es clínico y positivo: no requiere colonoscopía ni imágenes. Manejo: educación, dieta baja en FODMAP y fármacos según el síntoma.

1.06.1.009 Constipación

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Menos de 3 deposiciones a la semana, duras o con esfuerzo; casi siempre funcional (Roma IV) o asociada a fármacos (opioides, anticolinérgicos, calcio, hierro).
- Descartar causas secundarias: hipotiroidismo, hipercalcemia, diabetes, Parkinson, depresión.
- Signos de alarma (inicio >50 años, cambio reciente del hábito, anemia, rectorragia, baja de peso, familiar con cáncer de colon): colonoscopía.
- Tratamiento escalonado: fibra (20–30 g/día) y agua, actividad física, educación del hábito defecatorio; luego laxantes osmóticos (polietilenglicol, lactulosa); estimulantes (bisacodilo, sen) de rescate.
- Impactación fecal: enemas o desimpactación manual, sobre todo en adulto mayor.
- Seguimiento completo en APS; derivar si es refractaria o hay alarma.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 119**
>
> Mujer de 27 años con constipación de 3 años de evolución, con deposiciones caprinas y duras, que evacua una vez a la semana. Se realiza una radiografía de abdomen que muestra dolicocolon, con contenido fecal en toda su extensión.
> **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**
>
> **A)** Laxantes osmóticos
> **B)** Laxantes de contacto
> **C)** Cambios de hábitos
> **D)** Proquinéticos
> **E)** Cirugía
>
> Respuesta C. En una paciente joven sin signos de alarma, la constipación funcional se trata primero con cambios de hábitos: fibra, líquidos, actividad física y horario defecatorio. El dolicocolon es un hallazgo sin relevancia terapéutica y no justifica cirugía. Los laxantes quedan como segunda línea si las medidas fallan.

1.06.1.010 Diarrea asociada a antibióticos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea que aparece durante o hasta 8 semanas después de un antibiótico (clindamicina, cefalosporinas, quinolonas); la mayoría es leve y osmótica.
- Clostridioides difficile: diarrea acuosa con fiebre, dolor y leucocitosis; forma grave con colitis pseudomembranosa o megacolon tóxico.
- Diagnóstico: PCR o toxina de C. difficile en deposiciones diarreicas; no se pide PCR de control tras el tratamiento.
- Manejo: suspender el antibiótico gatillante si es posible, hidratar, evitar antidiarreicos (loperamida).
- C. difficile: metronidazol en casos leves (según la clase) o vancomicina oral 125 mg c/6 h por 10 días (de elección en guías actuales); fidaxomicina alternativa; recurrencias: vancomicina en esquema prolongado o trasplante fecal.
- Seguimiento: control clínico; prevención con uso racional de antibióticos e higiene de manos con agua y jabón.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 110

Puérpera de 5 días, hospitalizada durante el parto, presenta deposiciones líquidas múltiples con moco y sangre, calambres abdominales y fiebre de 38,5 °C. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Infección por Clostridioides difficile
B) Gastroenteritis viral
C) Colitis ulcerosa de novo
D) Salmonelosis
E) Síndrome de intestino irritable postinfeccioso

Respuesta A. La hospitalización y los antibióticos del periparto (profilaxis o cesárea) son el principal factor de riesgo de Clostridioides difficile, que causa diarrea con fiebre, dolor cólico y a veces sangre. Se confirma con toxinas o PCR en deposiciones y se trata con vancomicina o fidaxomicina oral. Una gastroenteritis viral rara vez es disentérica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 107 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 31 años, con antecedente de parto hace 3 meses, consulta por un cuadro de diarrea de dos meses de evolución de tipo acuoso que ha empeorado en los últimos días, no ha presentado fiebre ni sangre en sus deposiciones. En su examen físi- co presenta dolor difuso a la palpación abdominal y meteorismo. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad celiaca
B) Colitis ulcerosa
C) Diarrea nosocomial
D) Enteroparasitosis
E) Diarrea crónica funcional

Respuesta C. En el parto recibió antibióticos y la diarrea por clostridium puede aparecer hasta 2 meses después de haber terminado el uso de antibióticos. Eso sí, se debe ser cuidado- so, porque hay quienes definen a la diarrea nosocomial en términos más estrictos, que no calzan con el del caso clínico.

1.06.1.011 Diarrea crónica

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea de 4 semanas o más; prolongada si dura 2–4 semanas.
- Orientar por la clínica: funcional (SII, sin alarma), malabsorción (esteatorrea, baja de peso con ingesta conservada, carencias), inflamatoria (sangre, fiebre, calprotectina alta) o secretora.
- Estudio inicial: hemograma, PCR, TSH, anti-transglutaminasa IgA con IgA total, coprocultivo y parasitológico seriado (Giardia), Sudán; D-xilosa localiza (pared vs enzimas).
- Signos de alarma (sangre, baja de peso, anemia, edad >50, síntomas nocturnos): colonoscopía con biopsias.
- Manejo inicial: hidratación, tratar causas evidentes (suspender fármacos, lactosa, parásitos).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología si no se aclara la causa o hay alarma.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años con 4 meses de diarrea acuosa, 4 a 5 veces al día, que la despierta en la noche, con baja de 6 kg. No ha viajado. Al examen hay palidez leve. Hemoglobina 10,5 g/dL y VCM 76 fL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Diagnosticar síndrome de intestino irritable e indicar dieta baja en FODMAP
B) Loperamida y control en 3 meses
C) Coprocultivo como único examen
D) Estudio de diarrea crónica orgánica, con exámenes de laboratorio y colonoscopía con biopsias
E) Metronidazol empírico por 7 días

Respuesta D. Diarrea de más de 4 semanas con signos de alarma —nocturna, baja de peso y anemia— es orgánica hasta demostrar lo contrario. Se estudia con laboratorio (hemograma, PCR, serología celíaca, parasitológico) y colonoscopía con biopsias. El intestino irritable no despierta en la noche ni produce anemia.

1.06.1.012 Diarrea en inmunosuprimidos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- En VIH con CD4 bajos, trasplantados o quimioterapia: diarrea crónica, profusa, con baja de peso; el agente depende del grado de inmunosupresión.
- Agentes oportunistas: Cryptosporidium, Cystoisospora, microsporidios, Giardia; CMV (colitis con CD4 <50, úlceras en colonoscopía) y complejo Mycobacterium avium; también C. difficile y bacterias habituales.
- Estudio: coprocultivo, parasitológico con tinción de Ziehl-Neelsen modificada (Cryptosporidium, Cystoisospora), toxina C. difficile; colonoscopía con biopsias si es persistente.
- Manejo inicial: hidratación, corrección de electrolitos y soporte nutricional; tratamiento dirigido (cotrimoxazol para Cystoisospora, ganciclovir para CMV).
- La terapia antirretroviral con recuperación de CD4 es clave en la criptosporidiosis.
- Seguimiento: derivar a infectología.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 34 años con infección por VIH sin tratamiento, con CD4 de 45 células/mm3, consulta por diarrea acuosa abundante de 6 semanas, sin sangre, y baja de peso de 7 kg. El coprocultivo y el examen parasitológico seriado habitual de deposiciones son negativos. **¿Cuál es el examen más útil para continuar el estudio?**
>
> **A)** Elastasa fecal
> **B)** Test de hidrógeno espirado
> **C)** Anticuerpos antitransglutaminasa
> **D)** Sangre oculta en deposiciones
> **E)** Tinción de Ziehl-Neelsen modificada en deposiciones
>
> Respuesta E. Con CD4 bajo 100, la diarrea crónica acuosa sugiere protozoos oportunistas (Cryptosporidium, Cystoisospora, Cyclospora), que no se ven en el parasitológico habitual y requieren tinción de Ziehl-Neelsen modificada. El tratamiento clave es iniciar TARV. Si el estudio es negativo, sigue la colonoscopía con biopsias buscando citomegalovirus o micobacterias.

1.06.1.013 Disfagia

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfagia lógica (sólidos → líquidos, progresiva): obstrucción; con baja de peso, cáncer de esófago hasta demostrar lo contrario (escamoso en fumador/alcohólico, adenocarcinoma en ERGE/Barrett).
- Disfagia ilógica (líquidos desde el inicio, fluctuante): trastorno motor, como acalasia (regurgitación no ácida, neumonías aspirativas) o esclerodermia (pirosis grave + Raynaud).
- Disfagia alta con halitosis y regurgitación de comida no digerida: divertículo de Zenker (esofagograma con bario).
- Examen de elección según patrón: lógica → endoscopía con biopsia; ilógica → manometría (acalasia: EEI que no relaja; esofagograma 'pico de pájaro').
- Manejo inicial: asegurar nutrición e hidratación, evaluar riesgo de aspiración; disfagia orofaríngea en ACV: evaluar deglución antes de dar alimento.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía; acalasia se trata con miotomía del EEI.

PREGUNTAS (6)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 22**
>
> Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulinodependiente con mal control metabólico y epigastralgia en tratamiento crónico con omeprazol, consulta por cuadro de disfagia lógica asociado a odinofagia de un mes de evolución. Al examen físico no se encuentran alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Cáncer esofágico
> **B)** Reflujo gastroesofágico
> **C)** Acalasia
> **D)** Candidiasis esofágica
> **E)** Divertículo esofágico
>
> Respuesta A. La disfagia es lógica, y eso ya apunta a una obstrucción que crece, no a un trastorno motor: cae la acalasia. El uso crónico de omeprazol sugiere un reflujo de base, y a los ochenta años, con este patrón progresivo, hay que descartar cáncer de esófago antes que quedarse con el reflujo. La candidiasis esofágica es el distractor, porque el paciente es diabético mal controlado y tiene odinofagia, pero no da una disfagia lógica progresiva como esta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 112

Un paciente de 80 años consulta por dificultades para comer, caracterizada por disfagia alta intermitente, tanto para alimentos sólidos como líquidos. Refiere, además, regurgitación frecuente de alimentos, halitosis y una pérdida de peso de 4 kg en los últimos meses. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Acalasia esofágica
B) Cáncer de esófago
C) Divertículo de Zenker
D) Esclerosis sistémica con compromiso esofágico
E) Reflujo gastroesofágico

Respuesta C. La disfagia es alta, no baja, y viene con halitosis marcada porque el alimento retenido en el saco fermenta: divertículo de Zenker. El distractor es la acalasia, que también da disfagia ilógica y regurgitación de comida sin digerir, pero es baja y no explica una halitosis tan marcada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 38

Una paciente de 56 años, con antecedente de haber vivido en Brasil hasta hace 6 meses, consulta por disfagia lógica y progresiva, asociada a baja de peso de 6 kilogramos. Su examen físico no tiene alteraciones. Tiene antecedente de pirosis y regurgitación de larga data. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de esófago
B) Estenosis péptica
C) Esofagitis eosinofílica
D) Acalasia esofágica
E) Cáncer gástrico

Respuesta A. El antecedente de vivir en Brasil sugiere Chagas, que también da un trastorno motor esofágico, pero la clínica es de disfagia lógica: progresiva, primero sólidos y luego líquidos. Chagas, esclerodermia y acalasia suelen dar disfagia ilógica. El patrón manda sobre el antecedente epidemiológico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 150

Hombre de 70 años, desdentado, con disfagia alta para sólidos de inicio súbito tras comer. En la endoscopía se encuentra un cuerpo extraño, un trozo de carne, impactado en el esófago superior, y ya se realizó la endoscopía de extracción, con éxito. **¿Cuál es el estudio de seguimiento más importante?**

A) Nueva endoscopía para evaluar la mucosa esofágica subyacente y descartar estenosis o tumor
B) Radiografía de tórax de control
C) TAC de cuello y tórax
D) Alta directa sin más estudio
E) Esofagografía con bario

Respuesta A. Toda impactación de alimento en el esófago, sobre todo en el adulto mayor, obliga a estudiar el esófago después de resuelto el episodio: puede haber una estenosis péptica, un anillo de Schatzki o incluso un tumor detrás. El estudio es una nueva endoscopía, que ve la mucosa directamente y permite biopsiar si hace falta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 43 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años consulta por dificultad para tragar de 2 años de evolución, que se presenta tanto al ingerir alimentos sólidos como líquidos. Además, presenta pirosis y regurgitación frecuente postprandial. Ha bajado un total de 20 kilogramos desde el inicio de sus síntomas y su IMC actual es de 22,2. Al examen físico, tiene un abdomen excavado, sin palpación de masas, con ruidos hidroaéreos presentes y sin signos peritoneales. El resto de su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome pilórico
B) Acalasia esofágica
C) Esclerodermia sistémica
D) Cáncer gástrico
E) Divertículo esofágico

Respuesta B. Disfagia en Adulto Mayor: Aunque la disfagia en un adulto mayor puede indicar cáncer de esófago, en este caso se observa una disfagia ilógica que afecta tanto a sólidos como a líquidos. La radiografía muestra la imagen clásica de acalasia esofágica con obstrucción distal y sin irregularidades en la pared del esófago, a diferencia del cáncer.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 30 años consulta por disfagia ilógica intermitente, asociada a pirosis, regurgitación de alimentos y en ocasiones, dolor retroesternal. Es usuaria de omeprazol, de manera intermitent

E) Su examen físico muestra signos vitales normales y el examen abdominal también es normal. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en esta paciente?

A) Manometría esofágica
B) Radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno
C) Monitorización de pH esofágico de 24 horas
D) TAC de abdomen y pelvis

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Manometría esofágica). Clase sobre disfagia (dificultad para tragar), diferenciando la disfagia lógica (progresiva, primero sólidos luego líquidos, obstrucción, típica del cáncer de esófago) de la ilógica (fluctuante, afecta líquidos desde el inicio, trastorno motor, típica de acalasia y esclerodermia). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativ

1.06.1.014 Dispepsia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

QUÉ HAY QUE SABER

- Dolor o ardor epigástrico, plenitud postprandial o saciedad precoz. Causas: úlcera péptica, AINE, cáncer gástrico y dispepsia funcional (la más frecuente).
- Endoscopía con biopsias de entrada si tiene ≥40 años o signos de alarma (baja de peso, anemia, vómitos, hemorragia, disfagia), por riesgo de cáncer gástrico (GES).
- Menor de 40 sin alarma: buscar H. pylori (test de aire espirado o antígeno fecal) y erradicar si es positivo, o prueba con IBP 4–8 semanas.
- Erradicación de primera línea: IBP + amoxicilina 1 g + claritromicina 500 mg c/12 h por 14 días; si falla, cuádruple con bismuto.
- Dispepsia funcional (endoscopía normal): IBP, proquinéticos o antidepresivos tricíclicos en dosis bajas; suspender AINE, tabaco y alcohol.
- Seguimiento completo en APS; endoscopía si persisten los síntomas o aparecen signos de alarma.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 160

Mujer de 74 años con epigastralgia de 3 semanas de evolución, sin irradiación y sin baja de peso. Tiene antecedente de dispepsia tratada hace 10 años, y usa antiinflamatorios no esteroidales de forma ocasional. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Endoscopía digestiva alta para descartar lesión orgánica, por criterio de alarma según la edad
B) Iniciar inhibidor de la bomba de protones y controlar en 4 semanas
C) Test no invasivo de Helicobacter pylori y tratar si es positivo
D) Radiografía de abdomen
E) Ecografía abdominal

Respuesta A. La dispepsia en un mayor de 60 años es, por sí sola, un signo de alarma por la edad: obliga a endoscopía digestiva alta para descartar cáncer gástrico, úlcera péptica u otra lesión orgánica, sin ensayar antes tratamiento empírico. No es necesario que además haya baja de peso u otro signo de alarma.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 28 años, con cuadro de 2 meses de dolor epigástrico urente, que aumenta en ayuno y al beber café, asociado a pirosis y reflujo ocasional. Al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Iniciar omeprazol
B) Iniciar amoxicilina y claritromicina
C) Solicitar ecografía
D) Solicitar test de ureasa
E) Solicitar endoscopía digestiva alta

Respuesta E. Puede ser una úlcera u otra cosa, pero las epigastralgias se estudian con EDA. Que aumente con el café y con ayuno orienta a úlcera.

1.06.1.015 Enfermedad celiaca

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Enteropatía inmune al gluten (trigo, cebada, centeno). Clínica: malabsorción, distensión, o formas oligosintomáticas; dermatitis herpetiforme.
- Pensar en anemia ferropénica refractaria (con o sin diarrea), osteoporosis precoz, hipertransaminasemia, DM1 o tiroiditis autoinmune.
- Diagnóstico comiendo gluten: anti-transglutaminasa IgA (con IgA total, por falso negativo en déficit de IgA) y biopsia duodenal (atrofia vellositaria, hiperplasia de criptas, linfocitos intraepiteliales).
- Tratamiento: dieta sin gluten estricta y de por vida; corregir déficits (hierro, folato, calcio, vitamina D) y densitometría.
- Seguimiento: anticuerpos negativos habitualmente al año; si no responde, la causa más frecuente es la transgresión (contaminación cruzada); con anticuerpos negativos y malabsorción persistente, sospechar linfoma T de enteropatía.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 60

Ca normal PTH elevada vitamina D baja P bajo, calcio urinario bajo + anemia Ferritina 5. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hiperparatiroidismo Terciario
C) Enfermedad celiaca
D) Osteoporosis
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta C. Calcio normal, PTH alta, P bajo y vitamina D baja: hiperparatiroidismo secundario por déficit de vitamina D. La ferropenia severa asociada orienta a malabsorción: enfermedad celíaca.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 25

Una paciente de 24 años presenta un cuadro de amenorrea y baja de peso, asociado a náuseas y dolor abdominal de varios meses de evolución. Tiene antecedente de una hermana gemela con hipotiroidismo. Sus exámenes muestran hematocrito de 28 %, blancos 9.600 por mm3, plaquetas 340.000 por mm3, bilirrubina 1,1 mg/dL, GOT 155 UI/L y GPT 120 UI/L. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A) Solicitar IgM para virus hepatitis A
B) Realizar biopsia hepática
C) Solicitar colonoscopía
D) Solicitar ecografía abdominal
E) Solicitar anticuerpos antitransglutaminasa

Respuesta E. Amenorrea, baja de peso, dolor abdominal y anemia en una mujer joven con antecedente familiar de enfermedad autoinmune (hipotiroidismo) orientan a enfermedad celíaca, que puede oligosintomática y elevar discretamente las transaminasas. El estudio inicial son los anticuerpos antitransglutaminasa; la hepatitis es un distractor que no explica el resto del cuadro.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 98

Una paciente de 30 años, con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento, consulta por diarrea de 3 meses de evolución, no disentérica, asociada a baja de peso y artralgias. Al examen físico destacan lesiones pruriginosas y vesiculares en el tronco y las extremidades. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colitis ulcerosa
B) Enfermedad celíaca
C) Enfermedad de Crohn
D) Lupus eritematoso sistémico
E) Trastorno digestivo funcional

Respuesta B. La diarrea crónica con baja de peso es compatible con celíaca, Crohn o colitis ulcerosa, pero las lesiones cutáneas pruriginosas y vesiculares son una dermatitis herpetiforme, que se asocia específicamente a la enfermedad celíaca; las enfermedades inflamatorias intestinales dan eritema nodoso o pioderma gangrenoso, no este tipo de lesión.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 111

Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Además, trae exámenes, entre los que destaca anemia microcítica e hipoalbuminemia. Su examen físico no aporta mayor información. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Parasitosis intestinal
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis ulcerosa
D) Enfermedad de Cröhn
E) Enteropatía perdedora de proteínas

Respuesta B. Diarrea crónica, baja de peso, anemia microcítica e hipoalbuminemia: malabsorción. La ferropenia por falla de absorción duodenal sugiere enfermedad celíaca. Ser vegetariana aumenta el riesgo de déficit de B12, que daría macrocitosis, no microcitosis.

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años con diarrea crónica, distensión y baja de 6 kg en un año. Tiene una anemia ferropénica que no ha respondido a 4 meses de hierro oral bien tolerado. El test de D-xilosa resulta alterado. **¿Cuál es el siguiente paso más adecuado?**

A) Anticuerpos anti-transglutaminasa IgA con IgA total, manteniendo el gluten
B) Iniciar dieta sin gluten y controlar en 3 meses
C) Medir elastasa fecal por sospecha de insuficiencia pancreática
D) Test de hidrógeno espirado
E) Cambiar a hierro endovenoso

Respuesta A. D-xilosa alterada = problema de la pared. Con anemia ferropénica refractaria, la primera sospecha es celíaca (el duodeno, donde se absorbe el hierro, es la zona más afectada). Se piden anti-transglutaminasa IgA con IgA total, y luego biopsia duodenal, con el paciente consumiendo gluten.

Pregunta de práctica

Paciente con enfermedad celíaca que lleva 1 año con dieta sin gluten. Refiere seguirla de forma estricta, pero persiste con diarrea y baja de peso. Los anticuerpos anti-transglutaminasa están negativos. **¿Cuál es la sospecha diagnóstica?**

A) Transgresión oculta de la dieta
B) Linfoma T asociado a enteropatía (linfoma MALT)
C) Intolerancia a la lactosa secundaria
D) Síndrome de intestino irritable sobreagregado
E) Giardiasis crónica

Respuesta B. La causa más frecuente de falta de respuesta es la transgresión, pero en ese caso los anticuerpos suelen seguir elevados. Con anticuerpos negativos (buena adherencia) y malabsorción persistente, hay que descartar un linfoma T asociado a enteropatía, con imágenes y biopsias repetidas.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 73 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con hipotiroidismo, diarrea acuosa de meses y palidez. ¿Diagnóstico más probable?

A) Enfermedad celíaca
B) Colitis microscópica
C) Hipotiroidismo como causa directa de diarrea
D) Síndrome de intestino irritable
E) Gastroenteritis crónica eosinofílica

Respuesta A. Diagnóstico: Enfermedad celíaca (opción A). Enfermedad celíaca. Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 125 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 18 años, diabética tipo 1 en tratamiento con insulina glargina e insulina cristalina en esquema intensificado, consulta por un cuadro, que inició hace 2 meses, caracterizado por deposiciones líquidas frecuentes, sin mucosidad, asociadas a malestar abdominal y baja de peso de 4 kilogramos. Al examen físico, se aprecia pálida, tiene signos vitales normales y su abdomen es blando, depresible, sensible a la palpación profunda, sin irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad celíaca
B) Síndrome de intestino irritable, asociado a diarrea
C) Enteropatía perdedora de proteínas
D) Enfermedad inflamatoria intestinal
E) Diarrea viral

Respuesta A. Diagnóstico: Enfermedad celíaca (opción A). Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

1.06.1.016 Enfermedad diverticular complicada

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Diverticulitis: adulto mayor con dolor en fosa ilíaca izquierda de días, fiebre, masa palpable y cambio del hábito ('apendicitis izquierda').
- Diagnóstico y etapificación con TAC de abdomen y pelvis con contraste (Hinchey). Colonoscopía contraindicada en el episodio agudo.
- Hinchey I–II (flemón o absceso): antibióticos (ciprofloxacino + metronidazol VO o ceftriaxona + metronidazol EV) y drenaje percutáneo si el absceso mide ≥4 cm.
- Hinchey III–IV (peritonitis purulenta o fecal): cirugía de urgencia, operación de Hartmann.
- Otras complicaciones: fístula colovesical (neumaturia, ITU recurrente), obstrucción, hemorragia digestiva baja masiva.
- Seguimiento: derivar a cirugía; colonoscopía a las 6–8 semanas para descartar cáncer.

PREGUNTAS (10)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 34

Un paciente se realiza una colonoscopía para la resección de unos pólipos intestinales. Algunas horas después presenta dolor abdominal bajo, asociado a hematoquezia escasa y malestar general. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa ilíaca izquierda. **¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?**

A) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
B) Ecografía abdominal y pélvica
C) Colonoscopía
D) Radiografía de abdomen y pelvis
E) TAC de abdomen y pelvis

Respuesta E. Diverticulitis aguda post-colonoscópica: el dolor en la fosa ilíaca izquierda que aparece horas después de una colonoscopía con manipulación de pólipos orienta a una perforación diverticular iatrogénica. El TAC de abdomen y pelvis es el examen de elección; repetir la colonoscopía está absolutamente contraindicado en este contexto agudo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 169

Un paciente de 68 años consulta por dolor abdominal bajo, asociado a fiebre, mayor en el cuadrante inferior izquierdo. Temperatura 37,7 grados, frecuencia cardíaca 94, presión arterial 110/76. Abdomen doloroso a la palpación, con marcada resistencia muscular en la fosa ilíaca izquierda y disminución de los ruidos hidroaéreos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Diverticulitis aguda
B) Colitis isquémica
C) Apendicitis aguda
D) Vólvulo de sigmoides
E) Cáncer de colon complicado

Respuesta A. Dolor y fiebre localizados en la fosa ilíaca izquierda, con resistencia muscular y ruidos hidroaéreos disminuidos por el íleo reflejo local, en un adulto mayor: presentación clásica de diverticulitis aguda, la "apendicitis izquierda".

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 33

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 15/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad central con forma de estrella. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinopatía diabética
B) Edema macular
C) Catarata
D) Glaucoma
E) Hemorragia vítrea

Respuesta C. Disminución progresiva de la agudeza visual con una opacidad en el rojo pupilar: catarata. La retinopatía diabética no da síntomas hasta sus complicaciones; el edema macular no altera el rojo pupilar; la hemorragia vítrea es súbita y lo abole por completo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 171

Una paciente de 70 años, al tercer día después de una colonoscopía con resección de un pólipo, acude al servicio de urgencia por dolor abdominal muy intenso, en la zona inferior izquierda, asociada a sensación febril y deposiciones con sangre, en una oportunidad. Al examen físico tiene abdomen doloroso a la palpación profunda, mayor en la fosa ilíaca izquierda y signo de Blumberg en dicha zona. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?**

A) Radiografía de abdomen simple
B) Ecotomografía abdominal
C) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
D) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
E) Colonoscopía

Respuesta C. Dolor en la fosa ilíaca izquierda con fiebre y Blumberg en una paciente mayor: el examen que continúa el estudio es el TAC de abdomen y pelvis, para caracterizar la diverticulitis y clasificarla por Hinchey. La colonoscopía queda contraindicada en el episodio agudo por el riesgo de perforar un colon ya inflamado.

Pregunta de práctica

Mujer de 63 años con diverticulitis aguda. El TAC muestra abundante líquido y aire libre intraperitoneal, con signos de peritonitis fecal difusa. Está febril, taquicárdica e hipotensa. **¿Cuál es la conducta?**

A) Antibióticos endovenosos y reevaluar en 48 horas
B) Drenaje percutáneo guiado por TAC
C) Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)
D) Colonoscopía para localizar la perforación
E) Resección sigmoidea laparoscópica con anastomosis primaria diferida

Respuesta C. Aire y líquido libre con peritonitis fecal: Hinchey IV. Junto con el Hinchey III es indicación de cirugía de urgencia: resección del sigmoides con colostomía terminal y cierre del muñón rectal (Hartmann). El manejo médico o percutáneo solo sirve en los abscesos (Hinchey I–II).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 24 horas de evolución, mayor en la fosa ilíaca izquierda, que se ha asociado a tres episodios de diarrea acuosa sin sangre. Al examen Fsico, sus signos vitales muestran presión arterial 132/85 mmHg, frecuencia cardíaca 85 por minuto y temperatura 37,5 °C. En la exploración abdominal presenta dolor a la palpación abdominal, especialmente intenso en la fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Gastroenteri2s aguda
B) Diver2culi2s aguda
C) Apendici2s aguda
D) Endometri2s aguda
E) Coli2s isquémica

Respuesta B. Es una diverGculiGs aguda clásica. Se estudia con TAC. El manejo depende de la clasificación de Hinchey: - Ia (flegmón/inflamación pericólica): antibióticos VO. - Ib (absceso pericólico < 5 cm): antibióticos VO o EV. - II (absceso distante o > 5 cm): drenaje x punción + antibióticos EV. - III (peritoniGs purulenta generalizada): cirugía (ej. Hartmann). - IV (peritoniGs fecaloidea): cirugía (Hartmann)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 57 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con metformina, glibenclamida y enalapril, consulta por dolor abdominal, de 2 días evolución, mayor en el flanco izquierdo y en la fosa iliaca izquierda, asociado a sensación febril. Al examen físico presenta T°: 38°C, PA: 100/60 mmHg, FC: 88x', abdomen doloroso a la palpación, mayor en la zona, con signos peritoneales localizados en dicha área y disminución de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infarto del ciego
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Colitis isquémica
D) Obstrucción intestinal
E) Diverticulitis aguda

Respuesta E. Diagnóstico: Diverticulitis aguda (opción E). Es una diverticulitis clásica.. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 91 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 60 años presenta dolor abdominal de 2 días de evolución, mayor en el abdomen bajo. Al examen físico tiene dolor a la palpación abdominal, especialmente en la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad inflamatoria pélvica
B) Diverticulitis aguda
C) Colitis isquémica
D) Apendicitis aguda
E) Enfermedad de Cröhn

Respuesta B. Diagnóstico: Diverticulitis aguda (opción B). Es una diverticulitis aguda clásica.. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 157 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 88 años de edad, quien presenta clínica un día de evolución caracterizada por fiebre, diarrea y dolor en hipogastrio. Refiere evacuaciones sin otras alteraciones. Al examen físico presenta temperatura en 38,5 grados, presión arterial de 90/50 mmHg y al examen abdominal presenta dolor y sensibilidad a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

A) Diverticulitis aguda
B) Colitis isquémica
C) Pielonefritis aguda
D) Enfermedad inflamatoria intestinal
E) Rectocolitis bacteriana

Respuesta A. Es una diverticulitis aguda clásica, aunque aún no tenga signos peritoneales. El dolor en la FII y la fiebre lo sugieren fuertemente. Por el buen estado general, seguro es Hinchey I.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 130 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 70 años acude por cuadro clínico de doce horas de evolución caracterizada por dolor en hemiabdomen inferior, que ha ido en aumento, siendo mayor en el hemiabdomen izquierdo. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca de 96 lpm, PA: 90/60 mmHg, temperatura 38,5 grados, sudoración y palidez, y examen abdominal con abdomen doloroso a la palpación, con Blumberg (+) y signos de irritación peritoneal en la fosa iliaca izquierda. El diagnóstico más probable es:

A) Diverticulitis aguda
B) Cáncer colorectal complicado
C) Vólvulo sigmoideo
D) Obstrucción intestinal
E) Cáncer de ovario complicado

Respuesta A. Diagnóstico: Diverticulitis aguda (opción A). Es una diverticulitis clásica, con irritación peritoneal en la FII (fosa iliaca izquierda).. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada)

1.06.1.017 Enfermedad diverticular no complicada

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.3 Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

QUÉ HAY QUE SABER

- Diverticulosis: herniaciones de la mucosa en puntos débiles del sigmoides; muy frecuente en adultos mayores y casi siempre asintomática (hallazgo en colonoscopía).
- Factores de riesgo: dieta baja en fibra, carnes rojas y grasas, obesidad, tabaco, AINE.
- Diverticulitis aguda no complicada (Hinchey 0–Ia): dolor en fosa ilíaca izquierda con fiebre; manejo ambulatorio si es joven, estable y tolera la vía oral (ciprofloxacino + metronidazol 7–10 días).
- Hospitalizar si hay comorbilidad, inmunosupresión o mala tolerancia oral; repetir TAC si no mejora en 48–72 h.
- Prevención de recurrencias: dieta rica en fibra, actividad física y bajar de peso.
- Seguimiento completo: colonoscopía a las 6–8 semanas tras un episodio de diverticulitis para descartar cáncer.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 62 años, asintomática, se realiza colonoscopía de tamizaje que muestra múltiples divertículos en el colon sigmoides, sin signos inflamatorios ni pólipos. Nunca ha tenido dolor abdominal ni sangrado. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A) Mesalazina oral de mantención
B) Evitar semillas, nueces y maíz
C) Dieta rica en fibra y actividad física
D) Ciprofloxacino y metronidazol en ciclos mensuales
E) Sigmoidectomía electiva

Respuesta C. La diverticulosis asintomática no requiere tratamiento específico: se recomienda dieta rica en fibra, actividad física y evitar tabaquismo y obesidad. La restricción de semillas y nueces no tiene respaldo. Mesalazina y antibióticos cíclicos no previenen la diverticulitis, y la cirugía electiva no está indicada en la enfermedad no complicada.

1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn · Tema 9.18 Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto joven con diarrea crónica con sangre, mucosidad o pus en brotes, dolor abdominal, fiebre y baja de peso.
- Colitis ulcerosa: solo colon, continua desde el recto, mucosa; Crohn: boca a ano (típico íleon terminal), en parches, transmural, con fístulas y enfermedad perianal. Basta una característica de Crohn para clasificarla como Crohn.

- Manifestaciones extraintestinales: artritis periférica (curso paralelo al intestino), espondilitis, uveítis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, colangitis esclerosante primaria (CU).
- Estudio: calprotectina fecal, colonoscopía total con ileoscopía y biopsias; descartar infecciones (coprocultivo, C. difficile). p-ANCA (CU) y ASCA (Crohn) solo apoyan.
- Manejo inicial: hidratación; complicaciones graves (megacolon tóxico >6 cm + sepsis, obstrucción, absceso) se hospitalizan. Corticoides solo para el brote, nunca de mantención.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología (5-ASA, inmunomoduladores, biológicos; vigilancia de cáncer colorrectal tras 8–10 años).

PREGUNTAS (23)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 176

Un paciente de 31 años consulta por 2 meses de evolución de dolor abdominal y deposiciones diarreicas, inicialmente 3 veces al día, con aumento a 7 veces al día en las últimas 2 semanas. Examen físico: FC 88 por minuto, PA 130/82, T° 36,0 °C, abdomen blando, depresible, con meteorismo, sin masas ni visceromegalias, con ruidos hidroaéreos presentes y sin signos de irritación peritoneal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Crohn
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis ulcerosa
D) Colitis parasitaria
E) Síndrome de intestino irritable

Respuesta C. Diarrea crónica que empeora recientemente, subiendo de 3 a 7 deposiciones diarias en 2 semanas: es un cambio reciente del patrón, señal de alarma (la "C" de ABCDEFH) que descarta el intestino irritable y obliga a estudio orgánico; con esa evolución, la colitis ulcerosa es el diagnóstico más probable.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 26

Hombre de 25 años con 1 mes de diarrea, dolor abdominal y malestar general; ha tenido disentería en algunas ocasiones y bajó 4 kg. La colonoscopía muestra signos de inflamación en el colon, con zonas de mucosa indemne y sin afectación del recto. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colitis ulcerosa
B) Enfermedad de Crohn
C) Colitis isquémica
D) Parasitosis intestinal
E) Colitis por Clostridioides difficile

Respuesta B. La colonoscopía define el caso: inflamación en parches, con zonas de mucosa indemne, y respeto del recto. Cualquiera de esas dos características, por sí sola, descarta la colitis ulcerosa, que es continua y siempre rectal, y establece el diagnóstico de enfermedad de Crohn.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 21

Paciente de 45 años con colitis ulcerosa diagnosticada a los 20 años, inactiva hace 10 años. Desde hace una semana presenta deposiciones blandas con escasa sangre. El examen físico no aporta información. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar rectosigmoidoscopía
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar parasitológico de deposiciones
D) Solicitar colonoscopía
E) Iniciar corticoides orales

Respuesta D. La CU de larga data aumenta el riesgo de cáncer colorrectal, sobre todo rectal, y todo sangrado digestivo bajo nuevo en un adulto exige colonoscopía completa: la rectosigmoidoscopía no explora el colon proximal. No se asume un brote ni se inician corticoides antes de descartar neoplasia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 164

Mujer de 35 años con diarrea crónica mucosanguinolenta de 6 meses, urgencia defecatoria, pujo y tenesmo. Colonoscopía: mucosa eritematosa, granular, con pseudopólipos, desde el recto en forma continua hasta el ángulo esplénico, sin mucosa sana intercalada. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Colitis isquémica
B) Colitis ulcerosa
C) Síndrome de intestino irritable
D) Colitis infecciosa
E) Enfermedad de Crohn

Respuesta B. Compromiso mucoso continuo desde el recto hacia proximal, sin mucosa sana intercalada, con pseudopólipos y clínica de pujo y tenesmo: es una colitis ulcerosa. La ausencia de parches, de compromiso ileal y de lesiones perianales descarta el Crohn.

Pregunta real · EUNACOM 2021 · Pregunta 20

Mujer de 32 años con antecedente de Colitis Ulcerosa de 4 años de evolución presenta un brote intestinal agudo con diarrea sanguinolenta (6 deposiciones al día con pujo y tenesmo). De forma simultánea inicia dolor y derrame articular en rodilla derecha y tobillo izquierdo. ¿Cuál es el comportamiento clínico esperado de esta artritis periférica con relación a la evolución de su enfermedad intestinal?

A) La artritis progresará de forma independiente requiriendo cirugía protésica precoz
B) La artritis remitirá completamente al resolverse el brote inflamatorio de la colitis
C) La artritis transformará la enfermedad en espondilitis anquilosante irreversible
D) La artritis indica degeneración neoplásica colónica maligna inmediata
E) La artritis persistirá de forma crónica sin responder a corticoides

Respuesta B. La artropatía periférica asociada a Enfermedad Inflamatoria Intestinal de tipo pauciarticular (Tipo 1, que afecta rodillas y tobillos en menos de 5 articulaciones) sigue un curso estrictamente paralelo a la actividad de la mucosa colónica. Al tratar el brote de colitis ulcerosa con corticoides o aminosalicilatos y remitir la inflamación intestinal, la artritis periférica cede de forma completa sin dejar daño articular residual.

Pregunta de práctica

Hombre de 25 años con 3 meses de diarrea con sangre y mucosidad, dolor abdominal, fiebre vespertina y baja de 5 kg. Al examen: masa dolorosa mal definida en la fosa ilíaca derecha y una úlcera aftosa en la mucosa oral. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colitis ulcerosa
B) Síndrome de intestino irritable
C) Enfermedad de Crohn
D) Cáncer de colon derecho
E) Colitis infecciosa aguda

Respuesta C. Diarrea disentérica crónica con síntomas sistémicos en un joven: EII. La masa en fosa ilíaca derecha (plastrón ileal) y las aftas orales son características de Crohn; basta una. La CU es solo colónica, continua y mucosa: no da masa ni compromiso ileal. Conducta: colonoscopía con ileoscopía y biopsias.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 163 · texto original del banco, sin revisar

Joven de 25 años con diarrea crónica de 8 meses, 5-6 deposiciones al día sin sangre, pérdida de peso de 7 kg, úlceras orales recurrentes, dolor abdominal periumbilical y fístula perianal. Colonoscopía: úlceras aftosas con mucosa normal entre ellas (patrón en empedrado). ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de intestino irritable
B) Colitis ulcerosa
C) Enfermedad de Crohn
D) Tuberculosis intestinal
E) Linfoma intestinal

Respuesta C. Enfermedad de Crohn: compromiso transmural + patrón en empedrado + úlceras aftosas con mucosa intercalada normal + fístula perianal + úlceras orales + localización que puede ser cualquier tramo del tubo digestivo. La CU no tiene fístulas ni compromiso ileal típico ni úlceras orales.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 25 años presenta un cuadro de 3 semanas de dolor abdominal tipo cólico y diarrea acuosa, que en ocasiones es sanguinolenta. Además, ha presentado úlceras orales recidivantes y ha bajado de peso. Al examen físico tiene abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda y sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos conservados. Hace 4 semanas se realizó manejo quirúrgico de una fístula anorrectal. El diagnóstico más probable es:

A) Colitis parasitaria
B) Enfermedad de Cröhn
C) Enfermedad celíaca
D) Colitis ulcerosa
E) Colitis pseudomembranosa

Respuesta B. Tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Las úlceras orales se ven tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Cróhn. La fístula anorrectal orienta fuertemente a enfermedad de Cróhn.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 16 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 35 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y diarrea de 3 meses de evolución, con 8 a 10 deposiciones líquidas al día, tanto diurnas como nocturnas. Presenta dolor abdominal 8po cólico con exacerbación en el hemiabdomen derecho. Además, al interrogatorio, refiere visión borrosa con enrojecimiento del ojo derecho y ajas orales recurrentes. También, relata baja de peso y presencia ocasional de sangre en las deposiciones. Al examen Fsico se observa pálido, con frecuencia cardíaca 90 lpm, presión arterial 125/72 mmHg y temperatura 37,2 °C. El abdomen está blando y sensible de forma difusa, con dolor más intenso en la fosa ilíaca derecha, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Coli2s ulcerosa
B) Coli2s infecciosa
C) Cáncer de colon
D) Enfermedad de Crohn
E) Síndrome de intes2no irritable con predominio de diarrea Mortalidad Mortalidad proporcional Mortalidad Mortalidad proporcional Patología cardiovascular 60/1000 50% 150/1000 71,4% Cáncer 30/1000 25% 30/1000 14,3% Otras causas de muerte 30/1000 25% 30/1000 14,3% Total 120/1000 100% 210/1000 100% Periodo inicial Periodo tardío

Respuesta D. Tiene clínica de una enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Entre ellas, parece más enfermedad de Crohn, por el dolor en el lado derecho (la zona ileocecal es lo más frecuentemente afectado), las amas (el compromiso oral también se puede ver en la coliGs ulcerosa, pero orienta a Crohn) y el compromiso ocular (más frecuente en enfermedad de Crohn que en coliGs ulcerosa).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 103 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 26 años consulta por dolor abdominal de 3 meses de evolución, asociado a diarrea acuosa, que en ocasiones ha presentado hematoquecia. Hace una semana se agrega marcado pujo y tenesmo, más aumento de la intensidad del dolor abdominal. Al examen físico tiene signos vitales normales y su abdomen es sensible a la palpación, con dolor a la palpación de la fosa iliaca y el flaco izquierdos, sin signos peritoneales. Los ruidos hidroaéreos se auscultan conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Cröhn
B) Enfermedad celiaca
C) Colitis ulcerosa
D) Megacolon amebiano
E) Cáncer de colon

Respuesta C. Diagnóstico: Colitis ulcerosa (opción C). Es una colitis ulcerosa clásica. No tiene elementos que hagan elegir a la enfermedad de Cröhn.. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 123 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 29 años, sin antecedentes, con cuadro de tres semanas de dolor abdominal intermitente, de intensidad moderada, asociado a deposiciones con sangre en ocasiones y disentería. Al examen físico se aprecia levemente deshidratada, con dolor a la palpación abdominal profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

A) Colitis ulcerosa
B) Giardiasis
C) Divertículo de Meckel
D) Colitis isquémica
E) Enfermedad de Crohn

Respuesta A. Es una EII. No tiene ninguno de los elementos que orientan a Cröhn, por lo que hay que elegir CU. Si tuviera algo de Cröhn (abscesos perianales, malabsorción intestinal, fístulas, úlceras orales, ASCA+, compromiso de intestino delgado, compromiso en parches o discontinuo, masa, perforación, etc) sería Cröhn.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de un mes de evolución, asociado a diarrea y baja de peso de 6 kg. En algún momento, presentó deposiciones sanguinolentas. Se solicita una tomografía axial computarizada (TAC), que muestra engrosamiento del íleon distal y del ciego, sin masas. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio diagnóstico?

A) Parasitológico de deposiciones
B) Endoscopía digestiva alta
C) Colonoscopía
D) Enteroscopía
E) Enteroclisis por TAC

Respuesta C. Enfermedad de Crohn: La clínica de la paciente es compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal. Además, la TAC muestra un compromiso del intestino delgado, lo que sugiere una enfermedad de Crohn. En las enfermedades inflamatorias intestinales, el diagnóstico definitivo se realiza mediante una colonoscopía.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 17 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor abdominal tipo cólico, que se ha exacerbado en las últimas 3 semanas y que está asociado a deposiciones diarreicas intermitentes, las que dice haber tenido desde los 15 años, con aumento de la frecuencia en el último mes. Al examen físico presenta inyección ciliar bilateral, sus signos vitales se encuentran dentro de los parámetros normales; al examen abdominal presenta dolor leve a la palpación abdominal sin signos peritoneales y se detecta una masa palpable en el flanco derecho. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 31%, hemoglobina: 10.2 g/dL, VCM: 76 fL, HCM: 27 pg, glóbulos blancos: 10.000 por mm3, plaquetas: 320.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Crohn
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis parasitaria
D) Colitis ulcerosa
E) Cáncer de colon

Respuesta A. Enfermedad de Cröhn: El cuadro clínico es compatible con enfermedad inflamatoria intestinal con síntomas extraintestinales (oculares). La presencia de una masa sugiere fuertemente enfermedad de Cröhn. Si hubiese sido un adulto mayor, se hubiese sospechado un cáncer de colon.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 23 años, consulta por un cuadro de diarrea de tres meses de evo- lución asociada a sensación febril y fiebre cuantificada hasta 38,0°C. Además, ha pre- sentado disentería en algunas oportunidades y refiere entre otros síntomas, dolor arti- cular migratorio en las cuatro extremidades. Al examen físico se aprecian aftas orales y nódulos eritematosos dolorosos en la cara anterior de las piernas. Su examen abdomi- nal muestra un abdomen blando, doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad celiaca
B) Infección por salmonella
C) Déficit de IgA
D) Colitis ulcerosa
E) Lupus eritematoso sistémico

Respuesta D. Es una mala pregunta, porque la clínica orienta a enfermedad de Cröhn, que no aparecía en las enfermedades. Solo quedaba marcar la colitis ulcerosa, pero las úlceras orales no son complatibles.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 50 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 35 años consulta por deposiciones abundantes y líquidas, que iniciaron hace 2 semanas y se presentan hasta 5 veces al día. Además, refiere malestar general y sensación febril. Dos meses atrás fue operado por una fístula perianal. Al examen físico tiene T°: 37,7°C, FC: 88x', PA. 120/80 mmHg, examen oral con tres úlceras; el examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda, con negatividad de los signos peritoneales y presencia de ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infección por Shigella
B) Colitis ulcerosa
C) Enfermedad de Cröhn
D) Colitis pseudomembranosa
E) Infección por Entamoeba histolytica

Respuesta C. Diagnóstico: Enfermedad de Cröhn (opción C). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Paciente joven con diarrea de larga data, sin mucosidad ni sangre, TAC con engrosamiento íleon distal, diagnóstico, *calprotectina fecal elevada (1500 creo): cáncer/Crohn/CU? (Es Crohn) Tenia mas pinta de cancer<—- no porque tenia 20 y tantos. Tenia 48 era viejo. Pero por el nivel de calprotectina y el compromiso de intestino delgado es Crohn…

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta A. Diagnóstico: Hemograma y VHS (opción A). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 27 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 23 años presenta dolor abdominal de 2 meses de evolución, asociado a deposiciones acuosas, que han ido en aumento, hasta presentar diarrea varias veces al día. Además ha tenido sensación de fiebre, y ha perdido 3 kilos de peso. Refiere también que en la última semana presentó un cuadro de hematoquezia abundante, con coágulos. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?

A) TAC de abdomen y pelvis
B) Colonoscopía
C) Coprocultivo y leucocitos fecales
D) Examen parasitológico seriado de deposiciones
E) Toxinas de Clostridium difficile en deposiciones

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Colonoscopía). Es una enfermedad inflamatoria intestinal, que se estudia con colonoscopía.. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 142 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años consulta por diarrea de un mes de evolución, asociada a dolor abdominal tipo cólico y algunos episodios de hematoquecia. Además, tiene artralgias de las manos y rodillas, con artritis de la rodilla derecha. Al examen físico se observan úlceras orales y lesiones nodulares en la cara anterior de las piernas. El examen abdominal muestra abdomen blando sensible, sin masas. El diagnóstico más probable es:

A) Lupus eritematosos sistémico
B) Enfermedad de Behcet
C) Colitis ulcerosa
D) Artritis reumatoide
E) Colitis por Clostridium difficile

Respuesta C. Si bien las úlceras orales sugieren más una enfermedad de Cröhn que una colitis ulcerosa, el cuadro clínico es compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal, con la artritis secundaria y eritema nodoso. El LES sí tiene úlceras orales, pero es rara la afectación digestiva. La enfermedad de Behcet sí tiene úlceras orales y genitales, más artritis, pero con afectación del SNC y SNP y sin afec

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 25 años consulta por diarrea, que inició hace 3 meses, que en ocasiones es sanguinolenta. Además presenta pujo y tenesmo frecuente y ha bajado 6 kilogramos de peso. Al examen físico, presenta dolor abdominal a la palpación del flanco izquierdo, ruidos hidroaéreos aumentados y úlceras orales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar endoscopía digestiva y anticuerpos antitransglutaminasa
B) Iniciar antibióticos orales
C) Solicitar colonoscopía
D) Solicitar ecografía abdominal
E) Pedir un TAC de abdomen y pelvis

Respuesta C. Probablemente tiene una enfermedad de Cröhn (por las úlceras orales no es colitis ulcerosa). Se estudia con colonoscopía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 12 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 23 años consulta por dolor abdominal de 2 meses de evolución, que ha ido en aumento y se asocia a diarrea acuosa. Al examen físico se palpa abdomen sensible, con ruidos hidroaéreos conservados. Hace 2 días aumenta el dolor y la diarrea, por lo que se solicita una TAC de abdomen y pelvis, que muestra engrosamiento del íleon distal y del ciego, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Endoscopía digestiva alta
B) Resonancia magnética de abdomen
C) Ecografía abdominal
D) Colonoscopía
E) Parasitológico de deposiciones y coprocultivo

Respuesta D. No queda claro cuál es el diagnóstico, pero parece una enfermedad de Cröhn, por lo que se estudia con colonoscopía. También podría ser un linfoma MALT, que se estudia igual.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

Hombre con diarrea disentérica, aftas bucales y antecedente de fístula perianal tratada. ¿Diagnóstico más probable?

A) Colitis ulcerosa
B) Síndrome de intestino irritable
C) Colitis infecciosa por Shigella
D) Enfermedad de Crohn
E) Colitis isquémica

Respuesta D. Diagnóstico: Enfermedad de Crohn (opción D). Enfermedad de Crohn. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 103 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años consulta por diarrea de 3 meses de evolución asociada a dolor abdominal, con deposiciones frecuentes de 5 a 6 veces durante el día y 1 a 2 veces en la noche. En ocasiones ha presentado escasos restos de sangre y ha bajado 17 kg de peso desde el inicio de los síntomas. Al examen Fsico presenta signos vitales normales. Se constata IMC de 41,8 y se palpa abdomen blando, sensible de manera difusa, sin signos peritoneales, masas, ni visceromegalias. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) An2cuerpos an2-transglutaminasa
B) Endoscopía diges2va alta
C) Ecogra:a abdominal
D) Coprocul2vo y parasitológico de deposiciones
E) Colonoscopía

Respuesta E. Ya sea que se sospeche una enfermedad inflamatoria intestinal (lo más probable) o un cáncer de colon, se debe estudiar con colonoscopía completa.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 127 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años consulta por deposiciones diarreicas de 3 semanas de evolución, asociadas a mucho pujo y tenesmo rectal. Refiere rectorragia ocasional escasa. Su examen físico muestra T°: 37°C, PA: 122/78 mmHg, FC: 72x', abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación hipogástrica y fosa iliaca izquierda. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Test de sangre oculta en deposiciones
B) Parasitológico de deposiciones
C) Colonoscopía
D) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
E) PCR para Clostridioides difficile

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Colonoscopía). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

1.06.1.019 Hepatitis aguda A no complicada

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Transmisión fecal-oral (agua, alimentos, jardines infantiles); en niños suele ser anictérica. Notificación obligatoria inmediata.
- Clínica: pródromo (fiebre, náuseas, malestar), luego ictericia, coluria y acolia; transaminasas muy elevadas.
- Diagnóstico: IgM anti-VHA, primer examen en toda hepatitis aguda.
- Tratamiento de soporte: reposo relativo, hidratación, evitar alcohol, paracetamol en dosis altas y fármacos hepatotóxicos; no requiere dieta especial.
- Vigilar gravedad con tiempo de protrombina/INR (no con bilirrubina ni transaminasas). Formas atípicas: colestásica, recurrente, fulminante (~0,1 %).
- Seguimiento completo: control clínico y de laboratorio hasta normalizar. Contactos: convivientes inmunoglobulina + vacuna; extradomiciliarios vacuna.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 127

Hombre de 32 años regresa de un viaje a un país vecino. A los pocos días presenta un cuadro de 5 días de fiebre, asociado a malestar general, seguido luego de dolor abdominal, ictericia y orinas oscuras. Al examen físico está ictérico, con dolor a la palpación del hipocondrio derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis alcohólica
D) Coledocolitiasis
E) Fiebre tifoidea

Respuesta A. Pródromo febril e inespecífico seguido de ictericia, coluria y dolor en hipocondrio derecho, después de un viaje, es la hepatitis A clásica, de transmisión fecal-oral. Se confirma con IgM anti-VHA y el manejo es de soporte. La hepatitis B tiene una incubación más larga, de 1 a 6 meses, y transmisión parenteral o sexual.

1.06.1.020 Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatitis B aguda: AgHBs + con IgM anti-HBc +; período de ventana con AgHBs – e IgM anti-HBc +. En adultos 90 % cura; en RN >90 % cronifica. Fulminante ~1 %.
- Hepatitis C: parenteral (drogas EV, transfusiones antes de 1996); rara vez cuadro agudo, cronifica 80–90 %. Tamizaje anti-VHC y confirmar con ARN-VHC por PCR.
- Hepatitis E: igual a la A, salvo en embarazadas (letalidad de hasta 20 %). Otras virales: CMV, VEB, herpes.
- Alcohólica: AST/ALT >2 (ambas <300–400), GGT y VCM altos; grave (Maddrey) con prednisolona. Fármacos: suspender siempre; paracetamol con N-acetilcisteína; antituberculosos: suspender todos.

- Manejo inicial: soporte y monitoreo de TP/INR; encefalopatía o INR prolongado = hepatitis fulminante, derivar a centro de trasplante. Profilaxis post exposición a VHB: IgHB + vacuna.
- Seguimiento: derivar; B y C crónicas son GES (VHC curable con antivirales de acción directa 8–12 semanas).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 83

Mujer de 20 años en tratamiento con isotretinoína hace 10 días por acné, con dolor abdominal, astenia, ictericia y orinas oscuras. Hígado palpable 3 cm bajo el reborde. GOT 328 U/L, GPT 459 U/L, bilirrubina 1,8 mg/dL, FA 80, GGT 92, protrombinemia 80 %. IgG anti-VHA (+), IgM anti-VHA (–), AgHBs (–), anti-HBc totales (+); anti-VHC y autoinmunidad pendientes. **El diagnóstico más probable es:**

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por fármacos
E) Hepatitis autoinmune

Respuesta D. IgM anti-VHA negativa descarta hepatitis A aguda (la IgG solo marca contacto previo). AgHBs negativo descarta infección B activa; anti-HBc sin AgHBs indica exposición pasada. Por descarte y por la relación temporal con isotretinoína: hepatitis por fármacos. Conducta: suspender el fármaco de inmediato.

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años, bebedor habitual, consulta por ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Al examen: hepatomegalia dolorosa. Laboratorio: AST 260 U/L, ALT 100 U/L, GGT muy elevada, VCM 104 fL. IgM anti-VHA y AgHBs negativos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis A aguda
B) Hepatitis alcohólica
C) Esteatohepatitis metabólica (NASH)
D) Hepatitis autoinmune
E) Hepatitis B en período de ventana

Respuesta B. Ictericia y hepatomegalia dolorosa en un bebedor, con AST/ALT > 2, transaminasas bajo 300–400, GGT y VCM elevados: hepatitis alcohólica. La NASH tiene AST/ALT < 1. El período de ventana requiere IgM anti-HBc positiva, que no se informa.

1.06.1.021 Hepatitis crónica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Inflamación hepática de más de 6 meses; causas: hígado graso metabólico (la más frecuente), VHB, VHC, alcohol, autoinmune, hemocromatosis, Wilson.
- Hepatitis B crónica: AgHBs + con IgM anti-HBc negativa. Hepatitis C: anti-VHC + confirmado con ARN-VHC por PCR (anticuerpo + con PCR – = infección resuelta).
- Autoinmunes: hepatitis autoinmune (mujer, ANA, ASMA, anti-LKM1; corticoides + azatioprina), colangitis biliar primaria (AMA +, ursodesoxicólico), colangitis esclerosante (colitis ulcerosa, p-ANCA).
- Evaluar fibrosis (elastografía o biopsia): grado = actividad inflamatoria, estadio = fibrosis acumulada; mata lento por cirrosis y hepatocarcinoma.
- Manejo inicial: suspender alcohol, vacunar hepatitis A/B, bajar 7–10 % del peso en NASH, estudiar contactos de VHB.
- Seguimiento: derivar (VHB y VHC crónicas son GES; VHC curable >95 % con antivirales de acción directa); con cirrosis, ecografía semestral.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 38 años con astenia. Sus exámenes muestran GPT 180 U/L y GOT 140 U/L, elevadas en forma persistente por 8 meses, con bilirrubina normal. AgHBs y anticuerpos anti-VHC negativos; no consume alcohol ni fármacos. Tiene IgG sérica elevada y anticuerpos antinucleares y anti-músculo liso positivos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?**

A) Hepatitis C crónica; antivirales de acción directa
B) Hepatitis autoinmune; prednisona con o sin azatioprina
C) Esteatohepatitis metabólica; baja de peso
D) Enfermedad de Wilson; penicilamina
E) Hepatitis A prolongada; manejo de soporte

Respuesta B. Hepatitis de más de 6 meses en una mujer, con hipergammaglobulinemia IgG y anticuerpos antinucleares y anti-músculo liso positivos, es una hepatitis autoinmune tipo 1. Se confirma con biopsia hepática y se trata con corticoides, solos o con azatioprina. La serología negativa descarta virus B y C.

1.06.1.022 Insuficiencia hepática crónica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Falla de las funciones del hígado en un cirrótico: ictericia, hipoalbuminemia, coagulopatía (INR alto), encefalopatía; asociada a hipertensión portal (ascitis, várices, esplenomegalia).
- Gravedad por Child-Pugh (A/B/C) y MELD (bilirrubina, INR, creatinina, sodio), que define prioridad de trasplante.
- Buscar el factor descompensante: infección (PBE), HDA, alcohol, fármacos, constipación, trastornos electrolíticos, hepatocarcinoma.
- Manejo inicial: tratar la descompensación (lactulosa en encefalopatía, diuréticos y paracentesis en ascitis, antibióticos en PBE); no corregir el INR de rutina, solo si sangra o hay procedimiento.
- Nutrición con proteínas 1,2–1,5 g/kg/día y colación nocturna; abstinencia de alcohol; evitar AINE, aminoglucósidos y benzodiacepinas.
- Seguimiento: derivar a hepatología para evaluar trasplante hepático.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 59 años con cirrosis hepática alcohólica, en control en policlínico. Se desea estimar su pronóstico mediante la clasificación de Child-Pugh. **¿Cuál de los siguientes parámetros NO forma parte de la clasificación de Child-Pugh?**

A) Bilirrubina total
B) Creatinina plasmática
C) Tiempo de protrombina o INR
D) Albúmina plasmática
E) Presencia y grado de ascitis

Respuesta B. Child-Pugh incluye bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina o INR, ascitis y encefalopatía. La creatinina no forma parte de Child-Pugh: está en el MELD (bilirrubina, INR, creatinina y sodio en el MELD-Na), que se usa para priorizar el trasplante hepático.

1.06.1.023 Intolerancia a la lactosa

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Déficit de lactasa (primario del adulto, o secundario a gastroenteritis, celíaca o Crohn): distensión, flatulencia, dolor y diarrea osmótica tras los lácteos, sin esteatorrea.
- Diagnóstico: clínico con prueba de exclusión de lactosa 2 semanas, o test de hidrógeno espirado.
- Tratamiento: reducir la lactosa según tolerancia (yogur y quesos maduros suelen tolerarse), leche sin lactosa o lactasa exógena.
- Asegurar aporte de calcio y vitamina D.

- No confundir con galactosemia del recién nacido (ictericia, daño hepático, cataratas): fórmula de soya; en ella la lactancia y la leche sin lactosa están prohibidas.
- Seguimiento completo en APS; si hay baja de peso o anemia, descartar celíaca o EII.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 24 años con distensión, meteorismo, dolor cólico y deposiciones líquidas que aparecen 1 a 2 horas después de tomar leche o comer helado. No tiene baja de peso, sangre en las deposiciones ni anemia. Los anticuerpos anti-transglutaminasa son negativos. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**
> **A)** Test de D-xilosa
> **B)** Biopsia duodenal
> **C)** Colonoscopía con biopsias
> **D)** Elastasa fecal
> **E)** Test de hidrógeno espirado con carga de lactosa
> Respuesta E. Síntomas osmóticos y fermentativos ligados a los lácteos, sin signos de alarma, sugieren intolerancia a la lactosa por hipolactasia. Se confirma con el test de hidrógeno espirado tras una carga de lactosa, o con la exclusión y reintroducción de lácteos. Se trata reduciendo la lactosa o con lactasa, sin eliminar todo el calcio.

1.06.1.024 Masa hepática

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer examen: ecografía abdominal; la palabra clave del informe y el contexto orientan.
- Benignas que se observan: quiste simple (anecogénico, pared fina), hemangioma (hiperecogénico homogéneo), hiperplasia nodular focal (cicatriz central).
- Adenoma: hipoecogénico único en mujer con anticonceptivos o anabólicos; suspender estrógenos y resecar si >5 cm o da síntomas.
- Quiste hidatídico (rural, perros; membranas, tabiques, vesículas hijas): albendazol + cirugía, nunca punción libre. Absceso con fiebre: amebiano (metronidazol) o piógeno (antibióticos + drenaje).
- Lesión heterogénea en cirrótico con AFP alta: hepatocarcinoma, confirmar con TAC o RM trifásica (realce arterial y lavado). Lesiones múltiples hipoecogénicas: metástasis, buscar el primario.
- Seguimiento: derivar lesiones sólidas indeterminadas o sospechosas a gastroenterología/cirugía.

PREGUNTAS (10)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 93**
> Paciente de 70 años, con cirrosis hepática, sin hábito alcohólico actual, AgHBs negativo y anticuerpos anti-VHC negativos, Child Pugh clase A. Ecografía abdominal: lesión sólida en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm, de aspecto hipoecogénico. Alfafetoproteína 5,3 ng/mL (VN 0–7). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
> **A)** Metástasis hepática
> **B)** Adenoma hepático
> **C)** Carcinoma hepatocelular
> **D)** Quiste hepático
> **E)** Hemangioma hepático
> Respuesta B. Lesión sólida, hipoecogénica, homogénea, con alfafetoproteína normal: adenoma hepático. La cirrosis eleva el riesgo tanto de adenoma como de hepatocarcinoma, pero aquí la AFP no está elevada, lo que aleja el hepatocarcinoma. Las metástasis serían múltiples; el hemangioma sería hiperecogénico; el quiste sería anecogénico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 24

Paciente con daño hepático crónico por consumo de alcohol, en TAC abdominal de control: tumor sólido en el lóbulo hepático derecho, de 3 cm, hipervascular en la fase arterial. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nódulo de regeneración
B) Hepatocarcinoma
C) Hemangioma hepático
D) Hiperplasia nodular
E) Adenoma hepático

Respuesta B. El daño hepático crónico se asocia tanto a adenoma como a hepatocarcinoma, pero la hipervascularización en fase arterial —el realce arterial que después lava— orienta a hepatocarcinoma. Es exactamente el patrón que se busca con el TAC o la RM trifásico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 54

Paciente de 39 años, con obesidad, en quien una ecografía abdominal muestra hígado graso leve, un quiste hepático simple de 1,0 cm y un pólipo vesicular de 0,5 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Biopsia por punción del pólipo
B) Controlar con una nueva ecografía en 6 meses
C) Laparotomía exploradora
D) Colecistectomía laparoscópica
E) Punción del quiste hepático

Respuesta B. Pólipo vesicular bajo 10 mm, en un hallazgo de rutina: colesterolínico, se sigue con ecografía. El quiste hepático simple menor a 1 cm tampoco requiere intervención. Ni la colecistectomía ni la punción tienen indicación aquí: el corte para operar un pólipo es 1 cm o más.

Pregunta de práctica

Mujer de 34 años, usuaria de anticonceptivos orales hace 8 años, con dolor vago en hipocondrio derecho. Ecografía: lesión hepática sólida, hipoecogénica, homogénea, única, de 6 cm. Sin daño hepático crónico; alfa-fetoproteína normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Observación con ecografía anual
B) Suspender anticonceptivos y resecar la lesión
C) Punción biopsia percutánea
D) Albendazol y cirugía
E) Evaluar trasplante hepático según criterios de Milán

Respuesta B. Lesión sólida hipoecogénica, homogénea y única en mujer joven usuaria de ACO, sin cirrosis: adenoma hepático. Por su tamaño (> 5 cm) y el riesgo de hemorragia y malignización, se suspenden los estrógenos y se reseca. El hemangioma sería hiperecogénico; el hepatocarcinoma, en hígado dañado con AFP alta.

Pregunta de práctica

En una ecografía solicitada por dispepsia se informa una lesión hepática de 3 cm, hiperecogénica, homogénea y de bordes bien definidos, en un paciente de 40 años sin antecedentes hepáticos ni baja de peso. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?**

A) Metástasis hepática; TAC de tórax-abdomen-pelvis
B) Hemangioma hepático; observación
C) Hepatocarcinoma; derivar para resección
D) Absceso hepático; antibióticos y drenaje
E) Quiste hidatídico; albendazol

Respuesta B. Lesión hiperecogénica, homogénea y bien delimitada en un hígado sano: hemangioma, la lesión hepática benigna más frecuente. Se observa; si hay dudas, se confirma con RM. La cirugía solo en hemangiomas gigantes y sintomáticos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 89 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 55 años, con antecedente de esteatohepatitis no alcohólica y obesidad, se realiza ecografía abdominal como parte de chequeo donde se aprecia lesión levemente hipoecogénica, redondeada, sin sombra acústica ni refuerzo posterior. El diagnóstico más probable es:

A) Hiperplasia nodular focal
B) Hepatocarcinoma
C) Adenoma
D) Hemangioma
E) Hidatidosis hepática

Respuesta B. En un paciente de 55 años con esteatohepatitis no alcohólica, que puede evolucionar a cirrosis, una lesión sólida hipoecogénica sin sombra ni refuerzo posterior debe considerarse hepatocarcinoma hasta demostrar lo contrario y estudiarse con TAC o RM trifásica y alfafetoproteína. El adenoma y la hiperplasia nodular focal son propios de mujeres jóvenes, el hemangioma suele ser hiperecogénico y la hi

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 44 · texto original del banco, sin revisar

Nódulo hepático sólido: Estudio con ecografía abdominal > con que continuar el estudio

A) TAC Trifasico
B) Biopsia
C) RNM
D) Eco
E) Hemograma y VHS

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (TAC Trifasico). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Biopsia, RNM) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 92 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 62 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo dos y de daño he- pático crónico secundario a una esteatohepatitis no alcohólica, ha presentado hospitali- zaciones por cuadros de hemorragia digestiva alta en el último año, actualmente con- trolado. Se realizan exámenes de control en que se demuestra fosfatasas alcalinas de 565 UI/L, GOT: 186 UI/L GPT: 172 UI7L, bilirrubina total 4,2mg/dL, alfafetoproteina: 119 ng/mL. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

A) Endoscopía digestiva alta
B) Ecografía abdominal
C) TAC abdominal
D) Gammaglutamil transferasa
E) Colangioresonancia

Respuesta B. La sospecha es un cáncer hepático, dada la alfafetoproteína de 119. Se inicia el es- tudio con una Ecografía.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 84 · texto original del banco, sin revisar

3) Una paciente de 72 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, suspendido hace 5 años acude a control médico. Trae VHBsAg (-) y Anticuerpos anti- VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico, que en la tomografía se aprecia sólido e hipervascular en la fase arterial. El diagnóstico más probable es:

A) Colangiocarcinoma
B) Adenoma hepático
C) Carcinoma hepatocelular
D) Quiste hepático
E) Hemangioma hepático

Respuesta C. El antecedente de DHC y el aspecto hipervascular orientan fuertemente a que es un hepatocarcinoma. Los adenomas también son bien delimitados e hipoecogénico, pero suelen verse principalmente en mujeres en edad fértil, que usan ACO o en hombres que usan anabólicos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 164 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 69 años, con daño hepático crónico, por consumo de alcohol, score de Child Pugh B, acude a control. Al examen físico tiene ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas, sin encefalopatía. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina: 3,1 mg/dl, SGOT: 50 UI/L, SGPT: 39 UI/L, albúmina: 3,0 g/dl, FA: 110 UI/L. Se solicita una ecografía abdominal que, además de la ascitis, muestra dos lesiones hepáticas hipoecogénicas de 2,2 cm y 1,6 cm, respectivamente. En una imagen anterior, realizada hace 6 meses, se veían las mismas lesiones, pero de menor tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nódulos de regeneración
B) Adenomas hepáticos
C) Hemangiomas hepáticos
D) Hepatocarcinomas
E) Quistes simples hepáticos

Respuesta D. Diagnóstico: Hepatocarcinomas (opción D). Clase sobre el enfoque global de la ictericia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Nódulos de regeneración, Adenomas hepáticos) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la pr

1.06.1.025 Pancreatitis crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Inflamación crónica con fibrosis irreversible del páncreas; causa principal el alcohol (también tabaco, obstrucción ductal, genética, autoinmune).
- Sospechar ante dolor epigástrico recurrente irradiado al dorso, que empeora con la comida, más esteatorrea, baja de peso y diabetes (insuficiencia exocrina y endocrina).
- Malabsorción con test de Sudán positivo y D-xilosa normal (la pared está sana, faltan enzimas); elastasa fecal baja.
- Imagen: calcificaciones pancreáticas en radiografía o TAC (examen de elección), conducto pancreático dilatado e irregular.
- Manejo inicial: suspender alcohol y tabaco, analgesia escalonada, enzimas pancreáticas con las comidas, dieta fraccionada; tratar la diabetes (habitualmente insulina).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología (riesgo de seudoquistes, estenosis biliar y cáncer de páncreas).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 140

Hombre de 55 años, alcohólico crónico y fumador, con dolor epigástrico irradiado a la espalda, que aparece con la ingesta de alimentos y se calma al inclinarse hacia adelante. Ha bajado 8 kg de peso. Transaminasas y amilasa levemente elevadas. La radiografía muestra calcificaciones en el epigastrio. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Úlcera gástrica perforada
B) Obstrucción intestinal
C) Pancreatitis crónica
D) Colecistitis aguda
E) Hepatitis alcohólica

Respuesta C. Dolor epigástrico posprandial irradiado al dorso, alivio en flexión, baja de peso y calcificaciones pancreáticas en un alcohólico son típicos de pancreatitis crónica. La amilasa puede ser normal o levemente elevada por pérdida de parénquima. Se confirma con TAC. La úlcera perforada da abdomen agudo con neumoperitoneo, no calcificaciones.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 138 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años, gran fumador y con antecedentes de consumo excesivo de alcohol, hasta hace 6 meses en que suspendió el cigarrillo y la ingesta de alcohol, consulta por episodios de dolor abdominal epigástrico intenso, asociado a vómitos alimentarios. Refiere también episodios de diarrea abundante, que han ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que muestra hemograma con hematocrito: 39%, blancos: 9.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3; glicemia de ayuno: 122 mg/dL, lipasa plasmática: 210 UI/L, amilasa plasmática: 90 UI/L, fosfatasa alcalina: 210 UI/L, GOT: 32 UI/L, GPT: 40 U/L y GGT: 70 UI/L. Se realiza ecografía abdominal, que se describe como "ventana ecográfica insuficiente por meteorismo". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pancreatitis aguda
B) Colecistitis aguda
C) Cáncer de páncreas
D) Coledocolitiasis
E) Pancreatitis crónica

Respuesta E. Pancreatitis Crónica: El caso describe una pancreatitis crónica con complicaciones típicas como diabetes (tien glicemia de ayuno alterada y no aún diabetes) y síndrome de mala absorción. Se caracteriza por dolor abdominal, generalmente después de ingerir alimentos o alcohol. La causa más frecuente es el alcoholismo.

1.06.1.026 Parasitosis intestinales

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Giardiasis: diarrea crónica, flatulencia, dolor cólico y malabsorción en preescolar rural o varios familiares; descartarla antes de diagnosticar celíaca. Tratamiento: tinidazol o metronidazol.
- Oxiuriasis (Enterobius): prurito anal nocturno en niños; test de Graham. Mebendazol 100 mg dosis única repetida a las 2 semanas, tratando a todo el grupo familiar.
- Ascariasis: dolor abdominal, puede obstruir intestino o vía biliar; Taenia (carne cruda) y teniasis: eliminación de proglótidas; praziquantel o albendazol. Amebiasis: disentería o absceso hepático, metronidazol.
- Diagnóstico: parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras); test de Graham para oxiuros.
- Prevención: lavado de manos, agua potable, lavado de verduras, cocción adecuada de carnes, eliminación sanitaria de excretas.
- Seguimiento completo en APS; control parasitológico post tratamiento en casos persistentes.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niña de 5 años que asiste a jardín infantil presenta prurito anal de predominio nocturno hace 3 semanas, con sueño intranquilo. Al examen se observan lesiones por grataje perianal. El test de Graham es positivo. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Metronidazol a la paciente por 7 días
B) Crema de corticoide perianal
C) Praziquantel en dosis única a la paciente
D) Mebendazol a la paciente y a todo el grupo familiar, repitiendo la dosis a las 2 semanas
E) Nitazoxanida solo a la paciente

Respuesta D. El test de Graham positivo confirma oxiuriasis por Enterobius vermicularis. Se trata a todo el grupo familiar con mebendazol o albendazol, repitiendo a las 2 semanas por el ciclo de autoinfección, junto con medidas de higiene como uñas cortas y lavado de ropa de cama. Metronidazol es para protozoos y praziquantel para teniasis.

1.06.1.027 Reflujo gastroesofágico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

QUÉ HAY QUE SABER

- Pirosis retroesternal y regurgitación ácida, peor al acostarse y tras comidas abundantes; causa: falla de la barrera (relajaciones transitorias del EEI, hernia hiatal), no exceso de ácido.
- Presentación atípica: tos crónica, asma difícil, disfonía, erosiones dentales, dolor torácico no cardíaco (descartar primero el corazón).

- Típico, menor de 50 y sin alarma: diagnóstico clínico + prueba con IBP 4–8 semanas. Alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, inicio >50, pirosis >5 años): endoscopía con biopsias. Duda o atípico: pH-metría de 24 h.
- Tratamiento: medidas generales (elevar cabecera, bajar de peso, fraccionar, evitar comidas tardías, tabaco y alcohol) + omeprazol en ayunas 30–60 min antes del desayuno. No se erradica H. pylori por reflujo.
- Cirugía (funduplicatura de Nissen): joven dependiente de IBP, reflujo grave o hernia hiatal voluminosa sintomática.
- Seguimiento completo: Barrett (metaplasia intestinal en biopsia) sin displasia = IBP + vigilancia endoscópica; con displasia, derivar para ablación o resección.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 65

Paciente con pirosis y regurgitación. La endoscopía digestiva alta muestra la línea Z a 20 cm y la impresión diafragmática a 30 cm de la arcada dentaria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esófago de Barrett
B) Hernia hiatal por deslizamiento (tipo I)
C) Hernia hiatal paraesofágica (tipo II)
D) Acalasia
E) Esofagitis erosiva grado B

Respuesta B. La línea Z debería coincidir con la impresión diafragmática. Aquí está 10 cm por encima: la unión gastroesofágica subió al tórax, lo que define la hernia hiatal por deslizamiento. El Barrett es un diagnóstico de biopsia, no de centímetros.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 120

Un paciente de 26 años consulta por pirosis y regurgitación de varios meses de evolución. Su examen físico no aporta mayor información. Se realiza una endoscopía digestiva alta que muestra mucosa de aspecto normal, línea Z a 28 cm de la arcada dentaria e impresión hiatal diafragmática a 37 cm de la arcada dentaria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Acalasia esofágica
B) Hernia hiatal directa
C) Hernia paraesofágica
D) Esófago de Barrett
E) Divertículo esofágico

Respuesta B. La línea Z (unión gastroesofágica) está más arriba que la impresión diafragmática: es una hernia por deslizamiento, tipo I o "directa". Se maneja con observación, tratando el reflujo solo si aparece. La paraesofágica, en cambio, sí se opera por el riesgo de complicaciones.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 65

Un paciente de 36 años consulta por disfonía de varios meses de evolución, de predominio matinal, que mejora durante el día y que se intercala con periodos de tiempo en los cuales no tiene alteraciones de la voz. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar esomeprazol
B) Iniciar prednisona oral
C) Solicitar endoscopía digestiva alta
D) Solicitar radiografías contrastadas de esófago-estómago-duodeno
E) Solicitar TAC de cuello

Respuesta A. Parece una disfonía por reflujo, de predominio matinal. Se puede hacer una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones, aunque lo mejor suele ser una pHmetría para confirmar.

Pregunta de práctica

Hombre de 32 años, oficinista, consulta por 4 meses de ardor retroesternal ascendente que empeora tras el almuerzo y al acostarse, con regurgitación ácida. Niega disfagia, odinofagia, vómitos, baja de peso o anemia. Examen físico normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar omeprazol 20 mg al día en ayunas por 4 a 8 semanas
B) Solicitar endoscopía digestiva alta con biopsias
C) Solicitar pH-impedanciometría esofágica de 24 horas
D) Indicar ranitidina 150 mg cada 12 horas y medidas posturales
E) Solicitar radiografía de esófago, estómago y duodeno con bario

Respuesta A. Joven, clínica típica y sin alarma: el diagnóstico es clínico y se indica prueba con IBP por 4–8 semanas. La endoscopía se reserva para la alarma o el inicio después de los 50 años; la pH-metría, para la duda o la clínica atípica; los antagonistas H2 están desplazados.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 84 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 30 años presenta pirosis frecuente, por lo que se solicita una endoscopía digestiva alta, que muestra una esofagitis por reflujo, grado A. Se inician inhibidores de la bomba de protones por 6 meses. Al control refiere buena respuesta, sin embargo, los síntomas recurren al suspender el tratamiento. La conducta más adecuada es:

A) Repetir la endoscopía digestiva alta
B) Solicitar pH-metría esofágica
C) Indicar inhibidores de la bomba de protones
D) Solicitar manometría esofágica
E) Cambiar a antihistamínicos H2

Respuesta C. Tiene reflujo clínico y por endoscopía. El tratamiento es IBP (ej. omeprazol) a permanencia. Que los síntomas hayan recurrido, solo hace que con mayor razón sea reflujo y se deban reiniciar los IBP.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 38 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 27 años, con historia de pirosis y regurgitación de algunos meses de evolución, siendo diagnosticado de reflujo gastroesofágico. Se indican cambios en los hábitos alimentarios y omeprazol a razón de 20 mg al día y se controla un mes después con endoscopía digestiva alta que demuestra esofagitis distal severa y test de ureasa (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar prokinéticos
B) Agregar antiácidos
C) Duplicar la dosis de omeprazol
D) Erradicar Helicobacter Pilory
E) Tratamiento quirúrgico

Respuesta E. Es un RGE grave, en un paciente joven, con respuesta incompleta al omeprazol: Es la principal indicación de cirugía, además del esófago de Barret.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 34 años consulta por disfonía intermitente, principalmente en la mañana, asociada a carraspera. Su examen físico es normal. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

A) Azitromicina oral 500 mg/día por 5 días
B) Prednisona oral 20 mg/día
C) Lanzoprazol oral 20 mg/día por 30 días
D) Amoxicilina oral 500 mg/8 horas por 7 días
E) Ibuprofeno 400 mg/8 horas por 7 días

Respuesta C. Es una pregunta rara, pero se trata de un caso de RGE con síntomas atípicos: disfonía matinal. Otros son caries y asma de difícil manejo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 41 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 59 años inicia un cuadro de 3 semanas de evolución de pirosis y dolor epigástrico, con episodios diurnos y nocturnos. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar endoscopía digestiva alta
B) Solicitar ecografía abdominal
C) Solicitar TAC de abdomen
D) Iniciar omeprazol oral
E) Medir pH esofágico de 24 horas

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Medir pH esofágico de 24 horas (opción E). La diarrea aguda pediátrica es mayoritariamente viral (rotavirus); el manejo fundamental es la hidratación según grado de deshidratación De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.06.1.028 Síndrome de malabsorción

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante diarrea crónica con baja de peso pese a ingesta conservada, esteatorrea y signos carenciales (anemia ferropénica o megaloblástica, hipocalcemia, osteomalacia, glositis, coagulopatía).
- Test de Sudán confirma esteatorrea; D-xilosa localiza: alterada = pared (celíaca, Crohn, intestino corto); normal = enzimas (pancreatitis crónica, fibrosis quística).
- Estudio dirigido: anti-transglutaminasa IgA con IgA total, parasitológico (Giardia), elastasa fecal, imagen pancreática, endoscopía con biopsia duodenal.
- Manejo inicial: corregir déficits (hierro, folato, B12, calcio, vitamina D, K) y soporte nutricional; tratar la causa identificada.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología para completar el estudio etiológico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 17

Mujer de 40 años consulta por deposiciones frecuentes y diarrea de 3 meses de evolución. Presenta urgencia defecatoria, especialmente tras ingerir alimentos ricos en grasa, y nota gotas de grasa flotando en el inodoro luego de defecar. Además refiere baja de peso no cuantificada. Su examen físico muestra signos vitales normales y un abdomen blando, depresible, sin signos peritoneales ni masas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad celíaca
B) Insuficiencia pancreática exocrina
C) Sobrecrecimiento bacteriano
D) Colitis ulcerosa
E) Giardiasis

Respuesta B. Es un síndrome de malabsorción con esteatorrea franca, que empeora con las grasas: lo clásico de la insuficiencia pancreática exocrina, es decir, una maldigestión. La celíaca también da malabsorción, pero suele predominar la anemia ferropénica sin una esteatorrea tan marcada; la colitis ulcerosa da diarrea con sangre.

1.06.1.029 Tumores de colon

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Pólipos: hiperplásico no premaligno; adenomatoso (tubular, tubulovelloso, velloso: el de mayor riesgo) progresa a cáncer en ~10 años; polipectomía y colonoscopía en 1–3 años.
- Clínica del cáncer según ubicación: colon derecho anemia ferropénica y masa; izquierdo constipación progresiva, cambio del hábito, rectorragia y obstrucción (1.ª causa de obstrucción de colon en el adulto); recto hematoquecia, tenesmo.
- Diagnóstico: colonoscopía total con biopsia (sintomático o con alarma: colonoscopía directa, no sangre oculta). Etapificación con TAC de tórax, abdomen y pelvis; recto: RM de pelvis.
- CEA solo para seguimiento postoperatorio, no diagnostica.

- Síndromes hereditarios: poliposis adenomatosa familiar (cientos de pólipos, 100 % maligniza: colectomía profiláctica); Lynch (pocos pólipos: vigilancia colonoscópica intensiva).
- Seguimiento: derivar a cirugía (hemicolectomía; quimioterapia; radioterapia en recto). GES de cáncer colorrectal.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 50

Un paciente de 70 años consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación, alternado con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes destaca hematocrito de 36 % y hemoglobina de 12 g/dL.
¿Qué examen debe solicitarse a continuación?

A) Test de sangre oculta en deposiciones
B) Ecografía abdominal
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Colonoscopía
E) Rectosigmoidoscopía

Respuesta D. Constipación que alterna con diarrea (cambio del hábito intestinal) en un adulto mayor de 50 años es una señal de alarma que obliga a descartar cáncer de colon con colonoscopía, aunque los exámenes básicos aún estén casi normales.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 175

Paciente mayor de 50 años con pólipo resecado en la colonoscopía: adenoma velloso con displasia de bajo grado. **¿Cuál es la conducta?**

A) Colonoscopía de control en 1 año
B) Colonoscopía de control en 3 años
C) Colonoscopía de control en 5 años
D) Hemicolectomía profiláctica
E) Colonoscopía de control en 10 años

Respuesta B. El adenoma resecado, cualquiera sea su histología o su grado de displasia, se controla con una nueva colonoscopía en 1 a 3 años. No corresponde cirugía por un solo pólipo resecado por completo en la endoscopía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 28

Un paciente de 64 años presenta dolor abdominal desde hace un mes, asociado a cambio en el hábito intestinal. Su examen físico no aporta mayor información. Se había realizado un hemograma que muestra una anemia microcítica.
¿Qué examen se debe solicitar?

A) Colonoscopía
B) Radiografía simple de abdomen y pelvis
C) Ecografía abdominal
D) Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta A. Hombre de 64 años con cambio del hábito intestinal y anemia microcítica: la sospecha es un cáncer de colon, y el examen es la colonoscopía. La sangre oculta no aporta: la anemia ferropénica ya es la evidencia de la pérdida.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 31 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 45 años nota cambio en el hábito intestinal desde hace dos meses, requiriendo mayor esfuerzo defecatorio. Además, ha notado presencia ocasional de mucosidad y sangre en las deposiciones. Su examen físico muestra signos vitales normales y la exploración abdominal no presenta alteraciones ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada para iniciar su estudio?

A) Ecografía abdominal
B) TAC abdominal
C) Colonoscopía
D) Rectosigmoidoscopía
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta C. Cáncer colorrectal: La sospecha diagnóstica es un cáncer colorrectal. Si bien se puede iniciar el estudio con una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía, se recomienda la exploración de todo el colon, por lo que la colonoscopía es la respuesta correcta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 1 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 92 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer por lo que está institucionalizada, presenta un cuadro de astenia, debilidad, baja de peso de 6 kilos en los últimos dos meses, asociado a hematoquesia intermitente en algunas oportunida- des, que los familiares atribuyen a hemorroides externos. Al examen físico presenta un abdomen blando, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes. Su piel se aprecia algo pálida y sus signos vitales son normales. ¿Con que examen debe iniciarse el estudio en esta paciente?

A) Ecografía abdominal
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Resonancia magnética de abdomen y pelvis
D) Colonoscopía corta
E) Colonoscopía completa

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Colonoscopía completa). Se sospecha un cáncer de colon, que se estudia con colonoscopía completa. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 14 · texto original del banco, sin revisar

Paciente 50 años aprox con cambio de hábito intestinal y baja de peso 8 kilos: a. colonoscopía

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciale

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 54 años presenta cambio en el hábito intestinal, asociada a distensión abdominal. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra un pólipo de 5 mm en la vesícula biliar, de aspecto homogéneo y delimitado. La conducta más adecuada es:

A) Indicar dieta baja en grasas
B) Realizar colecistectomía
C) Solicitar PCR ultrasensible
D) Realizar TAC de abdomen
E) Realizar colonoscopía

Respuesta E. El pólipo vesicular no tiene importancia, por tener aspecto benigno. En cambio, el cambio en el hábito intestinal es algo que sugiere cáncer de colon y obliga a hacer una colonoscopía completa.

1.06.1.030 Úlcera péptica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.5 Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo) · Tema 1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori · Tema 1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas: H. pylori (90 % de las duodenales, 70 % de las gástricas) y AINE; tabaco y corticoides potencian. Epigastralgia urente, peor en ayunas (duodenal).
- Endoscopía si ≥40 años o alarma. Duodenal: no se maligniza, erradicar siempre; gástrica: biopsia del borde siempre y endoscopía de control para documentar cicatrización.
- H. pylori por test de ureasa en biopsia, aire espirado o antígeno fecal (falsos negativos con IBP previo o sangrado reciente).
- Tratamiento: IBP 4–8 semanas + erradicación (IBP + amoxicilina 1 g + claritromicina 500 mg c/12 h por 14 días; segunda línea cuádruple con bismuto); suspender AINE.
- Control de erradicación con aire espirado o antígeno fecal a las 4 semanas post antibióticos y 2 semanas sin IBP.
- Complicaciones: HDA (IBP EV + endoscopía urgente) y perforación (Rx de tórax de pie, cirugía; endoscopía contraindicada). Seguimiento completo en APS.

PREGUNTAS (10)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 129

Hombre de 42 años con 5 días de dolor epigástrico intenso y fluctuante, con náuseas, que empeora con el ayuno y tras usar antiinflamatorios. FC 85 lpm, PA 130/82 mmHg. Dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales, masas ni visceromegalia. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Gastritis erosiva
B) Úlcera péptica
C) Reflujo gastroesofágico
D) Pancreatitis aguda leve
E) Colecistitis aguda

Respuesta B. Epigastralgia que empeora en ayunas y se gatilla con AINE: síndrome ulceroso. Sin dolor en faja ni signos peritoneales no es pancreatitis; sin dolor en hipocondrio derecho no es colecistitis; el reflujo da pirosis y regurgitación.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 12

Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos de ayuno y estrés, asociado ocasionalmente a pirosis. Se realiza endoscopía digestiva alta que objetiva úlcera duodenal activa y se realiza test de ureasa que resulta negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?**

A) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina
B) Indicar omeprazol y controlar con nueva endoscopía en 6 semanas
C) Solicitar nueva endoscopía digestiva alta con test de ureasa
D) Iniciar omeprazol, bismuto y metronidazol
E) Iniciar medidas antirreflujo y omeprazol a permanencia

Respuesta A. Úlcera duodenal activa en un paciente que no usa AINEs: se asume Helicobacter pylori, que explica cerca del 90% de estos casos, aunque el test de ureasa sea negativo, porque este tiene falsos negativos. Se erradica con terapia triple: omeprazol, amoxicilina y claritromicina.

Pregunta de práctica

Hombre de 27 años, sin antecedentes ni uso de antiinflamatorios, con 3 meses de dolor epigástrico urente que aumenta con el ayuno y calma al comer. La endoscopía muestra una úlcera duodenal activa de 1 cm; el test de ureasa es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar esquema erradicador de Helicobacter pylori por 14 días
B) Indicar omeprazol 20 mg al día por 8 semanas, sin antibióticos
C) Solicitar tomografía computarizada de abdomen y pelvis
D) Repetir la endoscopía en 4 semanas para nuevo test de ureasa
E) Solicitar gastrina sérica para descartar gastrinoma

Respuesta A. Úlcera duodenal sin AINE: se erradica siempre, aunque el test sea negativo (los falsos negativos son frecuentes). Solo con IBP la úlcera cicatriza pero recidiva en cerca del 90 %; repetir estudios retrasa el tratamiento.

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con epigastralgia de meses consulta por dolor epigástrico súbito, "como una puñalada", que en 1 hora se extendió a todo el abdomen. Está pálido y taquicárdico, con abdomen rígido, doloroso en forma difusa y sin ruidos hidroaéreos. La radiografía de tórax de pie muestra aire bajo el hemidiafragma derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Endoscopía digestiva alta urgente
B) Suero, IBP endovenoso y antibióticos, y observar
C) Cirugía de urgencia
D) TAC de abdomen con contraste
E) Sonda nasogástrica y régimen cero por 48 horas

Respuesta C. Síndrome ulceroso + dolor en puñalada que se generaliza + abdomen en tabla + neumoperitoneo = úlcera perforada. El tratamiento es la cirugía de urgencia (sutura + parche de epiplón). Suero, IBP y antibióticos acompañan pero no reemplazan la cirugía; la endoscopía está contraindicada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 163 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 40 años, con antecedente de artritis reumatoide, tratada con naproxeno oral, presenta un episodio de hemorragia digestiva alta, con melena. Se realiza una endoscopía digestiva alta, que muestra una úlcera duodenal activa; no se realizó el test de ureasa. La conducta más adecuada es:

A) Cambiar el naproxeno por otro AINE
B) Solicitar serología para Helicobacter pylori
C) Solicitar nueva endoscopía con test de ureasa
D) Realizar erradicación de Helicobacter pylori
E) Iniciar inhibidores de la bomba de protones

Respuesta D. Las úlceras gástricas se erradican solo si tienen HP positivo (a menos que no haya consumo de AINEs y exista algo que genere falsos positivos, como el uso de antibióticos o de omeprazol) y se controlan con una EDA, de modo de descartar que haya un cáncer debajo. Las úlceras duodenales (este caso) se erradican siempre, ya sea con HP positivo o negativo y se controlan con pruebas no invasivas, como

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 124 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente es diagnosticado de úlcera gástrica, con test de ureasa positiva, por lo que se inicia tratamiento con amoxicilina 1g cada 12 horas, claritromicina 500mg cada 12 horas y omeprazol 20mg cada 12 horas, por 10 días. Luego queda con omeprazol por 4 semanas más. Se controla posteriormente con antígeno de H. pylori en heces, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el tratamiento, pero por 14 días
B) Realizar endoscopía digestiva alta y biopsia
C) Indicar tratamiento erradicador de segunda línea
D) Realizar test de ureasa
E) Observar evolución

Respuesta C. Si bien la recomendación del Minsal es 14 días de tratamiento, hay suficiente evidencia que dicen que los tratamientos de 7 a 10 días son buenos. Si falla la erradicación, se debe dejar tratamiento erradicador de segunda línea. Otro problema con esta pregunta es que solo la úlcera duodenal se controla con antígeno en heces, mientras que la ulcera gástrica debería controlarse con EDA y biosia, para

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 71 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con antecedente de úlcera gastroduodenal y anemia ferropénica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar hierro oral y controlar hemograma
B) Solicitar estudio de deposiciones para sangre oculta
C) Biopsias gástricas y test de ureasa
D) Erradicar H. pylori empíricamente
E) Solicitar endoscopía digestiva alta

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar endoscopía digestiva alta (opción E). Solicitar endoscopía digestiva alta. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 15 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente masculino, de 34 años, consulta por dolor abdominal epigástrico, de dos meses de evolución, mayor postprandial y que cede con antiácidos. En el último tiempo se agregan vómitos postprandiales. Hace pocos días presentó un episodio de dolor nocturno, de moderada intensidad. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) pH esofágico de 24 horas
C) Radiografías baritadas de esófago, estómago y duodeno
D) Endoscopía digestiva alta
E) TAC de abdomen y pelvis

Respuesta D. Se sospecha una úlcera gastroduodenal (aunque el dolor suele ser más intenso en ayunas). Se estudia con EDA.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 36 años se hace una endoscopía digestiva alta, que muestra test de ureasa positiva para Helicobacter pylori. Como antecedente, tuvo una hemorragia digestiva alta hace 2 años, por una úlcera duodenal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la endoscopía digestiva alta
B) Erradicar Helicobacter pylori
C) Solicitar el test del aliento con úrea-C14
D) Iniciar antihistamínicos H2
E) Indicar omeprazol por 6 meses

Respuesta B. Se erradican los pacientes con antecedente de úlcera y los con factores de riesgo para úlcera (uso de AINEs, dispepsia) y cáncer (displasia, metaplasia, antecedentes familiares marcados).

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con artritis reumatoide en tratamiento con AINEs, presenta melena. ¿Diagnóstico más probable?

A) Cáncer gástrico
B) Úlcera gastroduodenal
C) Angiodisplasia gástrica
D) Esofagitis erosiva
E) Síndrome de Mallory-Weiss

Respuesta B. Diagnóstico: Úlcera gastroduodenal (opción B). Úlcera gastroduodenal. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Situaciones clínicas de urgencia 12 códigos

1.06.2.001 Abdomen agudo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis · Tema 5.2 Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Dolor abdominal agudo que puede requerir resolución urgente; el diagnóstico es clínico. Signos peritoneales: resistencia, Blumberg, abdomen en tabla con silencio abdominal.
- Mujer en edad fértil con dolor abdominal bajo: test de embarazo y evaluación ginecológica primero (embarazo ectópico).
- Apendicitis: dolor periumbilical que migra a fosa ilíaca derecha, anorexia, McBurney; diagnóstico clínico (eco en niños y mujeres fértiles, TAC si hay duda). Diverticulitis: fosa ilíaca izquierda, TAC.
- Perforación de víscera hueca: dolor en puñalada, abdomen en tabla; Rx de tórax de pie con neumoperitoneo. Isquemia mesentérica: FA + dolor desproporcionado con abdomen blando, angio-TAC, heparina.
- Manejo inicial: régimen cero, vía venosa e hidratación, analgesia (no retrasa el diagnóstico), exámenes (hemograma, PCR, lipasa, orina, ECG, β-hCG), antibióticos si hay peritonitis.
- Derivar a cirugía; no todos son quirúrgicos (pancreatitis, CAD, IAM inferior, PBE).

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 72 años, fumador e hipertenso, consulta por dolor abdominal y lumbar súbito e intenso de 1 hora de evolución. Está pálido y sudoroso, con PA 80/50 mmHg y FC 125 por minuto. Se palpa una masa pulsátil periumbilical. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reanimación con hipotensión permisiva y traslado inmediato a pabellón
B) TAC de abdomen con contraste antes de decidir
C) Pielografía por sospecha de cólico renal
D) Analgesia y observación
E) Ecografía renal y urocultivo

Respuesta A. Dolor abdominal o lumbar súbito, shock y masa pulsátil es un aneurisma aórtico abdominal roto hasta demostrar lo contrario. En el paciente inestable no se espera la TAC: se reanima con hipotensión permisiva y se lleva de inmediato a pabellón. Confundirlo con un cólico renal es el error clásico.

Pregunta de práctica

Mujer de 68 años, con antecedente de histerectomía, consulta por 24 horas de dolor abdominal cólico, vómitos y ausencia de eliminación de gases. Abdomen distendido y timpánico, con ruidos de lucha, sin signos peritoneales. Afebril, FC 92 por minuto, leucocitos y lactato normales. Radiografía: asas de intestino delgado dilatadas con niveles hidroaéreos. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Laparotomía de urgencia inmediata
B) Régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y reevaluación seriada
C) Enema evacuante y proquinéticos
D) Colonoscopía descompresiva
E) Alta con analgesia y control en 48 horas

Respuesta B. Es una obstrucción de intestino delgado por bridas sin signos de estrangulación. El manejo inicial es régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación y corrección electrolítica, con reevaluación seriada. Se opera si aparecen fiebre, peritonismo, leucocitosis o lactato elevado, o si no resuelve en 48 a 72 horas. Los proquinéticos están contraindicados.

1.06.2.002 Afagia aguda

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Cuerpo Extraño Digestivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Imposibilidad de tragar, incluso la saliva (sialorrea), habitualmente por cuerpo extraño o bolo alimentario impactado en el esófago.
- Radiografía de cuello, tórax y abdomen para localizar el objeto (plástico y espinas pueden no verse). Dolor torácico, fiebre o enfisema: sospechar perforación.
- Todo cuerpo extraño en el esófago se retira por endoscopía; urgente si hay obstrucción completa, pila de botón (necrosis en horas, extracción inmediata), objeto afilado o >24 h.
- Bolo alimentario: si tolera líquidos y no hay dolor puede observarse hasta 24 h; si no traga o duele, endoscopía para desimpactar y luego estudiar la causa (esofagitis eosinofílica, estenosis, anillo, cáncer).
- No inducir el vómito ni usar maniobra de Heimlich (solo para obstrucción de vía aérea).
- Seguimiento: derivar a endoscopía de urgencia.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 50

Disfagia a nivel de la apófisis xifoides luego de comer pollo, que no permitía el paso ni siquiera del agua. **¿Cuál es la conducta?**

A) Endoscopía digestiva alta
B) Radiografía
C) Nasolaringoscopia
D) Manometría esofágica
E) Derrame pleural

Respuesta A. Un trozo de comida que se impacta y bloquea por completo el esófago, incluso para el agua, es una urgencia: la conducta es la endoscopía digestiva alta, que retira el bolo y de paso muestra si hay una causa de base, como un anillo de Schatzki o una estenosis péptica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 50

Paciente con disfagia a nivel de la apófisis xifoides luego de comer pollo, que no permite el paso ni siquiera de agua. **¿Cuál es la conducta?**

A) Endoscopía digestiva alta
B) Radiografía
C) Nasolaringoscopia
D) Manometría esofágica
E) Derrame pleural

Respuesta A. Comida impactada en el esófago (probablemente un hueso de pollo) que no deja pasar ni siquiera agua: es una obstrucción completa. La conducta es la endoscopía digestiva alta, sin demora, para desimpactar y por el riesgo de perforación. No se observa, porque no tolera ni líquidos.

1.06.2.003 Colangitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Infección de la vía biliar obstruida (coledocolitiasis, estenosis, tumor). Tríada de Charcot: dolor + ictericia + fiebre; péntada de Reynolds: + hipotensión + compromiso de conciencia.
- Laboratorio: leucocitosis, PCR alta, patrón colestásico (bilirrubina directa, FA y GGT); hemocultivos.
- Ecografía: vía biliar dilatada (colédoco >6–7 mm), cálculos.
- Manejo inicial: reposición de volumen, antibióticos de amplio espectro (ceftriaxona + metronidazol) y analgesia.
- Lo esencial es drenar: CPRE urgente; colecistectomía electiva después, cuando el paciente esté estable.
- Seguimiento: derivar de urgencia a centro con CPRE/cirugía.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 145

Mujer de 70 años con dolor abdominal intenso de 24 horas, fiebre hasta 38,5 grados, marcado malestar general y vómitos alimentarios en múltiples ocasiones. Al examen: presión arterial 90/60, frecuencia cardíaca 105 por minuto, ictericia de piel y mucosas, abdomen doloroso de forma difusa, con resistencia muscular, mayor en el hemiabdomen superior. Bilirrubina total 6,8 mg/dL, directa 6,1 mg/dL, fosfatasas alcalinas y GGT elevadas, transaminasas también altas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colecistitis enfisematosa
B) Plastrón vesicular
C) Hepatitis aguda
D) Colangitis aguda
E) Coledocolitiasis

Respuesta D. Dolor, ictericia y fiebre, con compromiso hemodinámico: es la tríada de Charcot que define la colangitis aguda, una urgencia que requiere drenaje de la vía biliar y antibióticos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 97

Paciente de 52 años, con 12 horas de dolor epigástrico intenso irradiado a los flancos, vómitos y orinas oscuras, con fiebre hasta 39 °C. Al examen: ictericia de escleras, piel y mucosas, PA 90/60 mmHg, FC 110/min. Ecografía: colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis múltiple en la vesícula. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar colecistectomía laparoscópica
B) Realizar colecistectomía abierta más coledocostomía
C) Solicitar colangiorresonancia
D) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E) Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar

Respuesta E. Dolor, ictericia y fiebre con compromiso hemodinámico: colangitis aguda grave, con un colédoco ya dilatado en la ecografía. La conducta prioritaria es el drenaje endoscópico de la vía biliar por CPRE, junto con volumen y antibióticos. La colecistectomía se hace después, cuando el paciente esté estable.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 101 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 70 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y sensación febril, de 6 horas de evolución, a lo que se ha agregado ictericia. Al examen físico pre- senta FC: 87x', PA. 90/60 mmHg, temperatura: 38,5 grados Celsius. Al examen abdominal tiene intenso dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diag- nóstico más probable?

A) Coledocolitiasis
B) Colangitis aguda
C) Pancreatitis aguda
D) Colecistitis aguda
E) Hepatitis aguda

Respuesta B. Tiene la triada de Charcot: fiebre, ictericia y dolor, más la hiptensión arterial. Es una colangitis clínica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 96 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso y asociado a vómitos. Además ha presentado fiebre hasta 38,8 grados y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 116x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar colecistectomía laparoscópica
B) Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar
C) Solicitar colangioresonancia magnética nuclear
D) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E) Realizar colecistectomía más coledocostomía

Respuesta B. Tiene criterios de colangitis aguda (dolor, fiebre, ictericia y compromiso hemodinámico), por lo que se debe proceder al drenaje por CPRE.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 23 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años, con antecedente de colecistectomía hace varios años, presenta desde hace dos días cuadro de dolor epigástrico, ictericia fluctuante, orinas oscuras y fiebre. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, presión arterial de 80/50 mm de Hg, dolor a la palpación epigástrica, blumberg (+), ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita ecografía abdominal que muestra vía biliar de 10mm. La conducta más adecuada en esta paciente es:

A) Realizar colangioresonancia
B) Realizar tomografía axial computada de abdomen
C) Realizar laparotomía abierta
D) Indicar antibióticos de amplio espectro y reevaluar en 48 horas
E) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta E. Tiene un diagnóstico de colangitis aguda clínica. Se debe hacer drenaje endoscópico de la vía biliar, lo que no aparece en las alternativas. De las opciones, la más aceptable es la CPRE (aunque en realidad lo que se hará es una papilotomía y drenaje). La presencia de Blumberg confunde, ya que podría indicarnos una Cirugía, pero el manejo de elección sigue siendo en drenaje endoscópico. De todos mo

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 152 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 60 años con fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho (tríada de Charcot). Ecografía: vía biliar dilatada, cálculo en colédoco. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

A) Colangitis aguda: ATB EV + CPRE urgente para drenaje biliar
B) Hepatitis aguda: manejo conservador
C) Colecistitis aguda: colecistectomía laparoscópica
D) Absceso hepático: drenaje percutáneo
E) Pancreatitis aguda: reposo y fluidos

Respuesta A. Tríada de Charcot (fiebre + ictericia + dolor en HD) + coledocolitiasis = colangitis aguda. Emergencia: ATB de amplio espectro + drenaje biliar endoscópico urgente (CPRE) para descompresión.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con dolor en HCD, fiebre, ictericia y coluria, con patrón colestásico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecografía abdominal
B) CPRE de urgencia
C) Colecistectomía laparoscópica inmediata
D) Colangiografía intraoperatoria
E) Antibióticos y drenaje percutáneo

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar ecografía abdominal (opción A). Solicitar ecografía abdominal. Bilirrubina >1.1 es alta; ictericia clínica aparece sobre 2.5-3 mg/dL De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.06.2.004 Colecistitis aguda

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Dolor persistente (>6 h) en hipocondrio derecho con fiebre, signo de Murphy y leucocitosis; casi siempre por cálculo enclavado en el bacinete o cístico.

- Ecografía confirma: cálculo enclavado, Murphy ecográfico, pared >4 mm y líquido perivesicular.
- Manejo inicial: hospitalizar, régimen cero, hidratación, analgesia y antibióticos (ceftriaxona + metronidazol).
- Es la única del grupo que se opera de urgencia: colecistectomía laparoscópica precoz (<72 h).
- Paciente muy frágil o de alto riesgo quirúrgico: colecistostomía percutánea transitoria.
- Seguimiento: derivar a cirugía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años con 8 horas de dolor intenso y continuo en hipocondrio derecho, fiebre de 38,5 °C y vómitos. Murphy positivo. Leucocitos 15.000/mm³, PCR elevada, bilirrubina normal. Ecografía: colelitiasis, pared vesicular de 6 mm y líquido perivesicular. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Analgesia y colecistectomía electiva en 6 semanas
B) Colangiorresonancia y luego CPRE
C) Hospitalizar, antibióticos y colecistectomía laparoscópica precoz
D) CPRE urgente para drenaje biliar
E) Ácido ursodesoxicólico y control ecográfico

Respuesta C. Dolor persistente + fiebre + Murphy + pared engrosada y líquido perivesicular: colecistitis aguda. La bilirrubina normal la separa de la coledocolitiasis y la colangitis. Es la única patología biliar que se opera de urgencia: colecistectomía laparoscópica en las primeras 72 horas.

1.06.2.005 Diarrea aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Más de 3 deposiciones al día de menor consistencia por <2 semanas; casi siempre infecciosa y viral, diagnóstico clínico.
- Evaluar deshidratación: plan A (<5 %) SRO 100–200 mL tras cada deposición en casa; B (5–10 %) SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h; C (>10 % o shock) cristaloides EV (SF 20 mL/kg en bolo en niños).
- No usar loperamida en disentería ni en niños; sí antieméticos si vomita.
- Antibiótico solo si disentería (Shigella, E. coli enteroinvasora), diarrea del viajero, fiebre alta >2–3 días o sepsis: ciprofloxacino oral (ceftriaxona EV si es grave); cólera o Campylobacter: azitromicina. Salmonella no complicada: sin antibiótico.
- Coprocultivo si hay disentería, inmunosupresión, brote o persiste; tras antibióticos, C. difficile.
- Seguimiento completo: control según evolución; si dura >2 semanas estudiar (coprocultivo, parasitológico seriado).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 30

Un paciente de 34 años lleva 48 horas con dolor abdominal tipo cólico, que ha ido en aumento, asociado a deposiciones líquidas abundantes y sensación febril. Al examen físico tiene temperatura axilar de 37,1 °C, frecuencia cardíaca de 80, presión arterial 120/80, dolor a la palpación del abdomen, mayor en la fosa ilíaca derecha, sin signo de Blumberg. Una ecografía abdominal muestra inflamación del íleon distal y del colon derecho, y el apéndice con leve edema de la pared y un coprolito en su base. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda
B) Enteritis infecciosa
C) Diverticulitis aguda
D) Enfermedad de Crohn
E) Colitis isquémica

Respuesta B. El dolor en fosa ilíaca derecha con diarrea, fiebre baja y sin signo de Blumberg, con inflamación difusa del íleon y del colon derecho en la ecografía (no solo del apéndice), orienta a una enteritis infecciosa que compromete la zona ileocecal; el edema leve del apéndice y el coprolito son un hallazgo acompañante, no el foco principal.

Pregunta de práctica

Hombre de 34 años con 2 días de diarrea con sangre, dolor cólico y fiebre de 39 °C. Hemodinámicamente estable, tolera líquidos por boca, sin signos de deshidratación. **Además de la hidratación oral, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Loperamida oral
B) Ciprofloxacino oral
C) Solo sales de rehidratación, sin otros fármacos
D) Colonoscopía urgente
E) Vancomicina oral

Respuesta B. Disentería (sangre en las deposiciones) es una de las indicaciones de antibiótico en la diarrea aguda: ciprofloxacino oral, o ceftriaxona endovenosa si es grave. La loperamida está contraindicada. La vancomicina es para C. difficile, que exige uso previo de antibióticos.

1.06.2.006 Encefalopatía hepática

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome neuropsiquiátrico del cirrótico: desde alteraciones del sueño y desorientación hasta coma; asterixis (temblor en aleteo) es el signo clásico. Diagnóstico clínico.
- Buscar siempre el precipitante: infección (el más frecuente, incluida PBE), HDA, constipación, sedantes, diuréticos, hipokalemia, deshidratación.
- Estudio: hemograma, electrolitos, función renal, glicemia, paracentesis diagnóstica si hay ascitis, hemocultivos; el amonio no es indispensable.
- Tratamiento: corregir el precipitante y lactulosa titulada a 2–3 deposiciones blandas al día (oral o enemas); agregar rifaximina en recurrencias.
- Proteger la vía aérea si hay compromiso de conciencia grave; no restringir proteínas. El TIPS está contraindicado en encefalopatía.
- Seguimiento: derivar a hepatología para evaluar trasplante.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 123

Paciente con antecedente de daño hepático crónico por alcohol presenta desorientación, lenguaje incoherente y tendencia a la somnolencia. Al examen físico tiene ictericia, arañas vasculares en la cara y el pecho, asterixis y compromiso cualitativo de conciencia. **¿Qué fármaco es el más adecuado para su tratamiento?**

A) Amonio
B) N-acetilcisteína
C) Risperidona
D) Donepezilo
E) Lactulosa

Respuesta E. Compromiso de conciencia con asterixis en un cirrótico es una encefalopatía hepática. Se trata con lactulosa, buscando 2 a 3 deposiciones blandas al día, y corrigiendo el factor desencadenante: infección, hemorragia digestiva, trastorno electrolítico o constipación. La amonemia orienta el diagnóstico; no es un tratamiento.

1.06.2.007 Hemorragia digestiva alta y baja

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Alta (proximal al ángulo de Treitz): hematemesis y melena. Baja: hematoquecia o rectorragia; una HDA masiva también puede dar hematoquecia.
- La gravedad la marca la hemodinamia (taquicardia, ortostatismo, hipotensión), no el hematocrito, que cae horas después.
- Manejo inicial: dos vías venosas gruesas, cristaloides, régimen cero; transfundir si hay anemia persistente tras reponer o sangrado masivo (meta Hb ~7). Endoscopía cuando el paciente esté estable.

- Úlcera péptica (causa más frecuente de HDA): IBP EV en dosis altas + endoscopía con hemostasia según Forrest; luego erradicar H. pylori.
- Várices (cirrótico): terlipresina + ceftriaxona (profilaxis de PBE) + ligadura endoscópica en <12 h; tiamina si es alcohólico.
- HDB: estable colonoscopía en 24 h; inestable endoscopía alta (10 % son altas), angio-TAC o angiografía. Causas: divertículos, angiodisplasia, cáncer, colitis isquémica. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 156

Un paciente de 45 años, luego de una transgresión alcohólica y alimentaria, presenta múltiples episodios de vómitos alimentarios, seguidos de hematemesis en una oportunidad. Su hemograma muestra hemoglobina de 9 gramos por decilitro. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Várices esofágicas
B) Gastropatía erosiva
C) Úlcera péptica activa
D) Síndrome de Mallory-Weiss
E) Gastritis isquémica

Respuesta D. Vómitos alimentarios intensos seguidos de hematemesis, sin enfisema ni sepsis, es el síndrome de Mallory-Weiss: un desgarro de la mucosa esofágica por el esfuerzo del vómito. No lo confundas con el síndrome de Boerhaave, que es una perforación transmural con mediastinitis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 148

Paciente de 55 años con múltiples episodios de hematemesis, cerca de un litro, en la última hora. Al examen: palidez de piel y mucosas, FC 120/min, PA 80/60 mmHg, estigmas de daño hepático crónico, abdomen blando y sensible. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Administrar terlipresina endovenosa
B) Administrar cristaloides endovenosos
C) Instalar balón de Sengstaken
D) Realizar endoscopía digestiva alta
E) Transfundir glóbulos rojos

Respuesta B. Hemorragia digestiva alta variceal masiva, con hipotensión y taquicardia: la conducta inicial, antes que cualquier otra cosa, es reponer volumen con cristaloides. La terlipresina y la endoscopía se dan de inmediato después, pero primero se estabiliza al paciente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 40

Una paciente de 19 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de rectorragia de dos días de evolución, que el día de hoy se volvió mucho más abundante. Al examen físico tiene FC 117x', PA 90/60 mmHg, palidez de piel y mucosas y examen abdominal con dolor difuso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Al preguntar dirigidamente, refiere antecedente de varios episodios de dolor periumbilical recurrente, de tipo urente, que había cedido de manera espontánea. Se solicita hemograma, que muestra hematocrito 27 %, hemoglobina 8,1 g/dL, blancos 5.000/mm³ y plaquetas 230.000/mm³. También se realiza colonoscopía de urgencia que muestra abundante sangre en todo el trayecto colónico, que fluye, además, por la válvula ileocecal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Crohn
B) Pólipo juvenil
C) Infección por Shigella
D) Divertículo de Meckel
E) Adenitis mesentérica

Respuesta D. Paciente joven con rectorragia masiva y la colonoscopía muestra que la sangre viene desde el intestino delgado, por la válvula ileocecal, no del colon: eso aleja el colon como origen y apunta al divertículo de Meckel, la causa clásica de hemorragia baja masiva en el paciente joven.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 14

Un paciente de 52 años presenta hematoquecia de 2 días de evolución, sin otros síntomas. Sus signos vitales muestran PA 120/80 mmHg, FC 75x' y temperatura 36 °C. Al examen físico, tiene leve palidez de mucosas y su abdomen es blando y depresible, sin masas ni visceromegalia y con preservación de los ruidos hidroaéreos. Se solicita una colonoscopía, que es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
B) Endoscopía digestiva alta
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Angiografía mesentérica
E) Enteroscopía

Respuesta B. Hematoquecia con una colonoscopía normal: el paso siguiente es la endoscopía digestiva alta, por la regla del 10 por ciento, ya que un sangrado alto con tránsito acelerado puede manifestarse como sangre roja y hacer creer que el origen es bajo cuando en realidad no lo es.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 40

Paciente de 19 años que acude al servicio de urgencia por un cuadro de rectorragia de 2 días de evolución, que el día de hoy se volvió mucho más abundante. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca de 117 por minuto, presión arterial de 90/60 mm Hg, palidez de piel y mucosas, y examen abdominal con dolor difuso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Al preguntar dirigidamente, refiere antecedente de varios episodios de dolor periumbilical recurrente, de tipo urente, que había cedido de manera espontánea. El hemograma muestra hematocrito 27 por ciento y hemoglobina 8,1 gramos por decilitro. La colonoscopía de urgencia muestra abundante sangre en todo el trayecto colónico, que fluye, además, por la válvula ileocecal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Crohn
B) Pólipo juvenil
C) Infección por Shigella
D) Divertículo de Meckel
E) Adenitis mesentérica

Respuesta D. Hemorragia digestiva baja masiva, con sangre que fluye desde el íleon a través de la válvula ileocecal, en un paciente con episodios previos de dolor periumbilical urente que cedían solos (la diverticulitis que imita apendicitis, ya resuelta espontáneamente): divertículo de Meckel. El examen que lo confirma es la cintigrafía con pertecnetato de Tc-99m, que capta la mucosa gástrica ectópica que sangra.

Pregunta de práctica

Hombre de 55 años con cirrosis por alcohol llega por vómito de abundante sangre roja. Pálido y sudoroso, FC 120/min, PA 85/50 mmHg. El hematocrito informado es de 38 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Esperar un hematocrito de control antes de decidir, ya que el actual es normal
B) Transfundir glóbulos rojos como primera medida de reanimación
C) Dos vías gruesas y cristaloides, terlipresina, antibióticos, tiamina y endoscopía con ligadura
D) IBP endovenoso y endoscopía electiva en 72 horas
E) Colonoscopía urgente

Respuesta C. HDA con compromiso hemodinámico (taquicardia e hipotensión) en un cirrótico: hemorragia variceal. La gravedad la define la hemodinamia; el hematocrito inicial es normal porque se pierde sangre completa. Reanimación con cristaloides, terlipresina, antibióticos (profilaxis de PBE), tiamina y ligadura endoscópica en las primeras 12 horas.

Pregunta de práctica

Al momento de la presentación de una hemorragia digestiva alta. **¿Cuál de los siguientes parámetros determina mejor la gravedad del cuadro?**

A) El hematocrito
B) La hemoglobina
C) La frecuencia cardíaca y la presión arterial
D) El volumen estimado de la hematemesis
E) El recuento de plaquetas

Respuesta C. En el sangrado agudo se pierde sangre completa, por lo que el hematocrito inicial suele ser normal y cae horas después, cuando el líquido intersticial diluye la masa eritrocitaria. La gravedad la marca el compromiso hemodinámico: taquicardia (lo más precoz), ortostatismo y, finalmente, hipotensión.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 147 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 61 años, con antecedente de haberse realizado una colonoscopía, hace un mes, la que estaba normal, consulta por una hemorragia digestiva baja abundante, con compromiso hemodinámico. Su frecuencia cardiaca es 120x' y su presión arterial, 90/60 mmHg. Se realiza endoscopía digestiva alta, que resulta normal y su hemograma muestra hematocrito de 19%, con hemoglobina: 6,3 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
D) Colonoscopía
E) Angiografía mesentérica

Respuesta D. La colonoscopía es el examen de elección para enfrentar la HDB. La EDA se hizo, porque tenía hemodinamia inestable (siempre se debe hacer en ese caso). No importa que hace un mes tuviese una colonoscopía normal. Si no localiza, se procede a la cintigrafía con GR marcados o a la angiografía mesentérica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 31 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente diabética, presenta hematemesis en 3 oportunidades. Su frecuencia cardíaca es 117x', su presión arterial es 90/60 mmHg. Al examen físico presenta arañas vasculares en la cara, ictericia en las escleras, abdomen blando depresivo e indoloro, con signos de ascitis. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina total: 4,3 mg/dl, hematocrito: 39%, INR: 1,8. La causa más probable de su hemorragia digestiva es:

A) Várices esofágicos
B) Úlcera gastroduodenal
C) Gastriris erosiva
D) Síndrome de Mallory Weiss
E) Esofagitis erosiva

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Várices esofágicos). Tiene clínica y exámenes de DHC, además de una HDA masiva, lo que orienta a várices esofágicos.. Clase sobre el enfoque global de la ictericia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 84 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 55 años, con antecedente de diabetes mellitus 2, consulta por un cuadro de hematemesis, seguida de malestar general. Al examen físico está pálido, con FC:110x', PA: 100/60 mmHg, constatándose obesidad. En sus exámenes destaca álbúmina: 3,0 g/dl; INR: 1,3; hematocrito: 30%, plaquetas: 77.000 por mm3, VCM: 105 fl y VHS: 20 mm/h. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Mallory Weiss
B) Úlcera gástrica
C) Úlcera duodenal
D) Várices esofágicas
E) Gastriris crónica atrófica

Respuesta D. Son várices porque se presenta como hematemesis grave y los exámenes sugieren consumo de alcohol (VCM elevado) y daño hepático crónico (albúmina baja e INR levemente aumentado).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 114 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 43 años acude al servicio de urgencia, luego de 7 días de ingesta alcohólica, porque presentó vómitos alimentarios intensos, seguidos de hematemesis. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor a la palpación epigástrica y en sus exámenes destaca hematocrito: 32%, GOT: 180UI/L, GPT: 130 UI/L, protrombinemia: 78%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Úlcera gástrica
B) Úlcera duodenal
C) Síndrome de Mallory Weiss
D) Gastritis erosiva
E) Várices esofágicas

Respuesta C. Parece una hepatitis por consumo de alcohol (aunque la relación GOT/GPT no alcanza a ser mayor a 2), que luego vomitó y siguió con un Mallory Weiss clásico (desgarro esofágico por vómitos).

1.06.2.008 Hepatitis aguda A complicada

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Formas atípicas de la hepatitis A: colestásica prolongada, recurrente (bifásica) y fulminante (~0,1 %, más en adultos mayores y hepatópatas crónicos).
- Hepatitis fulminante: encefalopatía dentro de 8 semanas desde la ictericia en hígado previamente sano; marcador de gravedad TP/INR prolongado (INR >1,5), no la bilirrubina ni las transaminasas.
- Signos de alarma: compromiso de conciencia, asterixis, hipoglicemia, vómitos persistentes, ictericia progresiva con TP en descenso.
- Manejo inicial: hospitalizar, controlar glicemia, TP, función renal y conciencia seriados; soporte, evitar sedantes y hepatotóxicos.
- Seguimiento: derivar precozmente a centro con trasplante hepático; notificar y manejar contactos (inmunoglobulina + vacuna en convivientes).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 26

Mujer de 30 años con 10 días de astenia, fiebre, malestar y dolor epigástrico; hace 2 días ictericia y hoy orinas oscuras. FC 96/min, PA 100/60, ictericia franca, sin compromiso de conciencia, sin signos peritoneales. GOT 2.640 U/L, GPT 2.860 U/L, GGT 180, FA 412, protrombinemia 52 %, bilirrubina total 9,2 mg/dL (directa 6,6), albúmina 3,4 g/dL. IgM anti-VHA 5,5 U (VN < 0,2). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dieta blanda y reposo en domicilio
B) Hospitalizar
C) Solicitar ecografía abdominal y controlar de forma ambulatoria
D) Solicitar colangiopancreatografía por resonancia magnética
E) Indicar N-acetilcisteína oral

Respuesta B. Hepatitis A aguda con protrombinemia de 52 %. Sin encefalopatía aún no es fulminante, pero la caída del tiempo de protrombina es el marcador de gravedad y riesgo de progresión: obliga a hospitalizar. El manejo ambulatorio es para la hepatitis A no complicada con protrombina normal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 26

Una paciente de 30 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por astenia, fiebre, malestar general y dolor epigástrico. Hace 2 días se agregó ictericia de piel y escleras, y hoy presentó orinas oscuras. Al examen físico tiene FC 96/min, PA 100/60 mmHg, ictericia franca de escleras y piel, sin alteraciones de conciencia. El abdomen es doloroso en epigastrio e hipocondrio derecho, sin signos peritoneales ni visceromegalia, con ruidos hidroaéreos conservados. Exámenes: GOT 2.640 UI/L, GPT 2.860 UI/L, GGT 180 UI/L, FA 412 UI/L, protrombinemia 52%, bilirrubina total 9,2 mg/dL, directa 6,6 mg/dL, albúmina 3,4 g/dL. IgM para virus hepatitis A: 5,5 UI (VN menor a 0,2). **¿Cuál es la conducta más adecuada con esta paciente?**

A) Dieta blanda y reposo en domicilio
B) Hospitalizar
C) Solicitar ecografía abdominal y controlar ambulatoriamente
D) Solicitar una colangiopancreatografía por resonancia magnética
E) Indicar N-acetilcisteína oral

Respuesta B. Hepatitis A con protrombina de 52% es una hepatitis aguda grave: aun sin encefalopatía, tiene riesgo de progresar a insuficiencia hepática aguda, por lo que se hospitaliza para vigilar protrombina, glicemia y conciencia. La N-acetilcisteína es específica para paracetamol y la colangiorresonancia no aporta ante un patrón hepatocelular.

1.06.2.009 Insuficiencia hepática aguda

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Falla hepática aguda: coagulopatía (INR ≥1,5) + encefalopatía en paciente sin hepatopatía previa, dentro de las 26 semanas del inicio.
- Causas: paracetamol (la principal en países desarrollados), virus (A, B, E en embarazadas), fármacos (antituberculosos), Amanita, hepatitis autoinmune, Wilson, isquemia, hígado graso agudo del embarazo.
- Sospechar ante hepatitis aguda con compromiso de conciencia, asterixis, ictericia progresiva, hipoglicemia o TP/INR en aumento.
- Manejo inicial: hospitalizar en UPC, glicemia y TP seriados, corregir hipoglicemia, evitar sedantes; N-acetilcisteína en intoxicación por paracetamol (útil incluso tarde) y suspender todo fármaco hepatotóxico.

- El TP/INR es también el criterio de derivación a trasplante.
- Seguimiento: derivar de inmediato a centro con trasplante hepático.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 28 años sin enfermedad hepática previa presenta ictericia de 10 días. Hoy su familia la nota somnolienta y desorientada, con asterixis. Exámenes: GPT 3.200 UI/L, bilirrubina total 12 mg/dL, INR 2,8, glicemia 62 mg/dL. HBsAg e IgM anti-core positivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Manejo ambulatorio con control de pruebas hepáticas en 48 horas
> **B)** Hospitalizar en sala y administrar vitamina K hasta normalizar el INR
> **C)** Ingreso a UCI y contacto precoz con un centro de trasplante hepático
> **D)** Plasma fresco congelado para normalizar el INR antes de cualquier evaluación
> **E)** Corticoides en dosis altas
> Respuesta C. Encefalopatía más INR de 1,5 o más en una paciente sin hepatopatía previa define insuficiencia hepática aguda, aquí por virus hepatitis B. Requiere UCI y contacto precoz con un centro de trasplante, además de antiviral. El plasma no se usa para corregir el INR sin sangrado porque oculta el pronóstico; la vitamina K no revierte una falla de síntesis.

1.06.2.010 Pancreatitis aguda

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas en Chile: litiasis biliar (mujer, transaminasas y FA altas) y alcohol (varón); otras: TG >1.000 mg/dL, hipercalcemia, fármacos, post-CPRE.
- Diagnóstico con 2 de 3 criterios (Atlanta): dolor epigástrico en faja al dorso, lipasa o amilasa >3 veces el límite normal, imagen compatible. Con los dos primeros no se necesita TAC; TAC con contraste a las 72 h si hay duda o mala evolución.
- La cifra de lipasa no indica gravedad; sí predicen gravedad hematocrito y BUN en ascenso, BISAP, falla orgánica >48 h (grave).
- Manejo inicial: volumen agresivo precoz con Ringer lactato 5–10 mL/kg/h guiado por diuresis >0,5 mL/kg/h; analgesia con opioides; realimentación oral precoz (24–72 h) o enteral; sin antibióticos profilácticos.
- Estudiar causa en todos: ecografía abdominal, perfil lipídico y calcemia. Biliar con colangitis: CPRE urgente; biliar leve: colecistectomía en la misma hospitalización.
- Seguimiento: derivar; hospitalizar siempre.

PREGUNTAS (5)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 121**
> Un paciente de 45 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico se encuentra frecuencia cardiaca en 90 por minuto, presión arterial 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando, doloroso a palpación epigástrica, Blumberg negativo. Se solicitan exámenes que muestran GOT 100 U/L, GPT 110 U/L, bilirrubina total 2 mg/dL, fosfatasas alcalinas 350 U/L, lipasa 250 U/L. Ecografía abdominal que muestra vesícula de paredes delgadas, sin edema, con barro biliar visible y colédoco de 8 mm. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
> **A)** Colangitis aguda
> **B)** Pancreatitis aguda
> **C)** Coledocolitiasis
> **D)** Colecistitis aguda
> **E)** Cólico biliar simple
> Respuesta B. La lipasa está sobre 180, tres veces el límite superior normal, junto con dolor típico: cumple criterios de pancreatitis aguda. Además tiene barro biliar y un colédoco levemente dilatado, sugerentes de coledocolitiasis, pero manda la pancreatitis por ser lo más grave. Sin fiebre ni compromiso hemodinámico no es colangitis, y la vesícula de paredes delgadas sin edema descarta la colecistitis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 90

Un paciente obeso, con antecedente de hígado graso, luego de una transgresión alimentaria con abundante consumo de alcohol presenta un cuadro de dolor epigástrico irradiado a ambos costados, asociado a vómitos alimentarios, sensación febril e ictericia. Al examen físico su presión arterial es de 110/70 mmHg, con frecuencia cardíaca de 100 por minuto, y al examen abdominal presenta dolor a la palpación de forma difusa, con abolición de ruidos hidroaéreos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Isquemia mesentérica
B) Colangitis
C) Pancreatitis
D) Colecistitis
E) Coledocolitiasis

Respuesta C. Dolor epigástrico intenso irradiado en faja a ambos costados, con vómitos, tras una transgresión alimentaria y alcohol, más íleo (ruidos hidroaéreos abolidos): pancreatitis aguda. Se confirma con lipasa o amilasa sobre 3 veces el valor normal. La ictericia puede acompañarla y no basta para pensar en colangitis.

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años, bebedor intenso, con pancreatitis aguda de 20 horas de evolución (lipasa 12 veces el valor normal). Está taquicárdico, con diuresis escasa. El hematocrito subió de 44 % al ingreso a 49 %. Temperatura 37,8 °C, leucocitos 14.000/mm³. **¿Cuál es la medida que más impacta en su pronóstico?**

A) Iniciar imipenem profiláctico
B) Reposición agresiva con Ringer lactato ajustada a diuresis
C) Solicitar TAC de abdomen con contraste de inmediato
D) Iniciar nutrición parenteral total
E) Realizar CPRE urgente

Respuesta B. Hematocrito en ascenso, taquicardia y oliguria: está perdiendo volumen al tercer espacio y predice necrosis. La reposición precoz con Ringer lactato es lo que más reduce la mortalidad. No hay indicación de antibióticos profilácticos (la fiebre es inflamatoria), el TAC se pide a las 72 h, la parenteral se evita y la CPRE urgente es solo para la colangitis.

Pregunta de práctica

Paciente de 55 años con pancreatitis aguda biliar de 36 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable, afebril, con dolor en disminución y tolera líquidos. Ecografía: colelitiasis, vía biliar de calibre normal, sin cálculos en el colédoco. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?**

A) CPRE de urgencia en las próximas 24 horas
B) Colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso, una vez resuelto el episodio
C) Alta con colecistectomía programada en 6 a 8 semanas
D) Colangiorresonancia y luego CPRE si es positiva
E) Manejo médico indefinido, sin cirugía, por el riesgo quirúrgico

Respuesta B. Pancreatitis biliar leve ya resuelta: colecistectomía laparoscópica en el mismo ingreso; diferirla se asocia a alta recurrencia de pancreatitis, colecistitis o colangitis. La CPRE urgente es solo para colangitis u obstrucción persistente, y la colangiorresonancia no aporta con baja probabilidad de coledocolitiasis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 35 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente presenta dolor epigástrico muy intenso, irradiado a ambos costados, . Tiene antecedente de una transgresión alimentaria y consumo de alcohol, el día anterior. Al examen físico se aprecia adolorido, con temperatura 38 grados, abdomen difusamente doloroso a la palpación, con disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

A) Úlcera perforada
B) Isquemia mesentérica
C) Hepatitis
D) Colecistitis aguda
E) Pancreatitis aguda

Respuesta E. Diagnóstico: Pancreatitis aguda (opción E). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

1.06.2.011 Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Infección del líquido ascítico sin foco quirúrgico, monomicrobiana; agente más frecuente E. coli. Clínica puede ser mínima: fiebre, dolor abdominal o cualquier descompensación (encefalopatía, falla renal).
- Diagnóstico: paracentesis diagnóstica a todo cirrótico con ascitis que consulta o se hospitaliza; PMN ≥250/mm³ en el líquido confirma (cultivo en frascos de hemocultivo).
- Tratamiento: cefotaxima o ceftriaxona EV por 5–7 días; no usar aminoglucósidos (nefrotóxicos).
- Albúmina EV 1,5 g/kg el día 1 y 1 g/kg el día 3: previene el síndrome hepatorrenal y reduce mortalidad.
- Diferenciar de peritonitis secundaria (polimicrobiana, perforación): requiere cirugía, la PBE no.
- Profilaxis secundaria con ciprofloxacino (o norfloxacino) indefinida mientras haya ascitis; primaria si albúmina en líquido <1,5 g/dL o HDA. Seguimiento: derivar a hepatología (evaluar trasplante).

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 159

Paciente de 67 años, cirrótico por alcohol, traído por deterioro del estado general y compromiso de conciencia. Está en sopor superficial, con fetor hepático, temperatura de 38,3 y frecuencia cardíaca de 85. El abdomen muestra ascitis a tensión, con asterixis y sin focalidad neurológica. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A) Hemocultivos
B) Hemograma
C) Estudio de líquido ascítico
D) TAC de abdomen
E) Ecografía abdominal

Respuesta C. Todo cirrótico con ascitis que se descompensa debe estudiarse primero para descartar una peritonitis bacteriana espontánea, con paracentesis y recuento de polimorfonucleares en el líquido ascítico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 98

Paciente de 55 años, con daño hepático crónico por virus hepatitis C, consulta por malestar general, febrículas, confusión y aumento del perímetro abdominal. Al examen: matidez desplazable. Paracentesis diagnóstica: transudado con 300 leucocitos por mm³, 100 % polimorfonucleares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar albúmina endovenosa
B) Realizar paracentesis evacuadora
C) Observar
D) Administrar antibióticos de forma empírica
E) Iniciar terapia con furosemida y espironolactona

Respuesta D. Trescientos leucocitos, cien por ciento polimorfonucleares en el líquido ascítico: peritonitis bacteriana espontánea. También corresponde dar albúmina, pero lo prioritario y lo que define la pregunta es iniciar antibióticos empíricos de inmediato, con cefotaxima.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 129 · texto original del banco, sin revisar

Paciente cirrótico hospitalizado con ascitis en tratamiento con cefotaxima por PBE. A las 72h persiste fiebre y deterioro. Cultivo del líquido ascítico: Escherichia coli. ¿Cuál es el significado clínico?

A) E. coli es el agente más frecuente en PBE; el tratamiento es correcto si hay sensibilidad
B) Cambiar a ceftriaxona
C) Agregar metronidazol
D) Cambiar a vancomicina
E) Realizar paracentesis evacuadora urgente

Respuesta A. coli es el microorganismo más frecuente en PBE (40-50% de los casos). Si el antibiograma confirma sensibilidad a cefotaxima, el tratamiento es correcto. La falta de respuesta obliga a revisar antibiograma y buscar complicaciones.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 115 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 56 años, con antecedente de daño hepático crónico, por consumo de alcohol, consulta por obnubilación, asociado a dolor abdominal e ictericia. Al examen físico se observa quejumbroso y tiene desorientación temporoespacial, fiebre de 38,3°C, ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas y asterixis. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitos de 16.000, con recuento diferencial normal. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina total: 5,2 mg/dl, albúmina: 2,8 g/dl, protrombinemia: 60%, GOT: 110 UI/L, GPT: 90 UI/L, GGT: 88 UI/L, FA: 120 UI/L. Child-Pugh categoría C. La conducta más adecuada en este paciente es:

A) Solicitar amonemia
B) Realizar laparoscopía exploradora
C) Iniciar lactulosa oral
D) Recuento de polimorfonucleares en líquido ascítico
E) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta D. Esta es una pregunta que se ha repetido en múltiples ocasiones, con distintos enunciados y que se resumen en: "paciente con ascitis que le pasa cualquier cosa (ej. dolor, fiebre, desorientación, compromiso hemodinámico, HDA, etc.), lo primero a hacer es puncionarlo, para descartar PBE. Por tanto, la respuesta es el recuento de polimorfonucleares en la paracentesis diagnóstica (si es más de 250 por

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 117 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 55 años, alcohólico, con daño hepático crónico, es traído al servicio de urgencia por deterioro del estado general, dolor abdominal y fiebre de 38,5 grados Celsius. Al examen físico está quejumbroso, en sopor, con dolor a la palpación abdominal y ascitis severa. Se solicita un hemograma que muestra hemoglobina 15 mg/dl, blancos de 15.000 por mm3 y plaquetas de 190.000 por mm3 y sus pruebas hepáticas muestran un daño hepático crónico en etapa C de Child Pugh . ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Colangioresonancia
D) Estudio de líquido ascítico
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta D. Probablemente tiene una PBE, que lo descompensa. De todos modos, todo cirrótico descompensado, con ascitis, debe estudiarse para descartar la PBE (peritonitis bacteriana espontánea).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 39 · texto original del banco, sin revisar

Hombre con ascitis a tensión y fiebre y encefalopatía: a. Estudio liquido

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Klebsiella pneumoniae

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Staphylococcus aureus). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del pacie

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 175 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, suspendido hace algún tiempo, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo, consulta por un cuadro de 7 días de evolución, caracterizado por desorientación, dolor abdominal, vómitos e ictericia. Al examen físico, presenta desorientación y lentitud del lenguaje, tiene frecuencia cardíaca: 89x', presión arterial 100/60 mmHg y asterixis. Al examen abdominal se evidencia ascitis grado 2 y dolor a la palpación abdominal. Sus pruebas hepáticas muestran: GOT 192 U/L, GPT 107 U/L, bilirrubina total 4 mg/dL y GGT 220 U/L. La protrombinemia es del 60%. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada para continuar con el estudio?

A) Solicitar amonemia
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Solicitar endoscopía digestiva alta
D) Realizar paracentesis diagnóstica
E) Solicitar ecografía abdominal

Respuesta D. Evaluación de la Descompensación en Pacientes Cirróticos con Ascitis: En pacientes cirróticos con ascitis que experimentan cualquier tipo de descompensación, la evaluación diagnóstica debe comenzar con una paracentesis diagnóstica para descartar la peritonitis bacteriana espontánea.

1.06.2.012 Síndrome hepatorrenal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal

QUÉ HAY QUE SABER

- Falla renal funcional en cirrótico avanzado con ascitis: vasodilatación esplácnica, hipovolemia arterial efectiva y vasoconstricción renal intensa; riñón estructuralmente sano.
- Sospechar ante alza de creatinina ≥0,3 mg/dL en 48 h o ≥50 % sobre la basal, oliguria, sodio urinario muy bajo y sedimento normal; gatillado por PBE, HDA, diuréticos o paracentesis sin albúmina.
- Diagnóstico de exclusión: sin mejoría tras 48 h sin diuréticos y con albúmina 1 g/kg/día (máx. 100 g), sin shock, sin nefrotóxicos (AINE, aminoglucósidos, contraste) y sin daño parenquimatoso (proteinuria <500 mg/día, sin hematuria).
- Manejo inicial: suspender diuréticos y nefrotóxicos, expandir con albúmina y tratar el gatillante.
- Tratamiento: terlipresina + albúmina (noradrenalina + albúmina en UCI). La única terapia curativa es el trasplante hepático.
- Seguimiento: derivar a hepatología/UPC.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con cirrosis alcohólica y ascitis, usuario de espironolactona 100 mg y furosemida 40 mg/día. Consulta por astenia y oliguria. Creatinina 2,4 mg/dL (basal 0,9 hace 3 semanas), Na urinario 8 mEq/L, sedimento normal. Se suspenden los diuréticos y se administra albúmina 1 g/kg/día por 48 horas; la creatinina sube a 2,7 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento de elección en este momento?**

A) Terlipresina IV más albúmina al 20 %
B) Reiniciar furosemida en dosis altas
C) Hemodiálisis de urgencia
D) Suero fisiológico 2 litros en bolo
E) Paracentesis evacuadora de 8 litros sin reposición

Respuesta A. Cirrosis con ascitis, injuria renal aguda, sedimento normal, Na urinario bajo y sin respuesta a 48 h de albúmina tras suspender diuréticos: síndrome hepatorrenal. Tratamiento médico de elección: terlipresina + albúmina al 20 %, como puente al trasplante hepático.

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con cirrosis Child-Pugh C por virus de hepatitis C y ascitis refractaria, hospitalizado por hemorragia digestiva alta variceal resuelta con ligadura. A las 72 horas presenta oliguria con creatinina de 0,8 a 2,6 mg/dL. Se suspenden diuréticos y se infunde albúmina al 20 % a 1 g/kg/día por 48 horas; la creatinina se mantiene en 2,5 mg/dL. Sedimento sin cilindros ni proteinuria. Na urinario 6 mEq/L. PA 100/60 mmHg. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Hemodiálisis trisemanal ambulatoria
B) Terlipresina intravenosa asociada a albúmina
C) Infusión de dopamina a dosis renales vasodilatadoras (2 mcg/kg/min)
D) Bolo de furosemida de 120 mg IV
E) Paracentesis evacuadora total de 8 litros sin reposición

Respuesta B. Cirrosis con ascitis, injuria renal aguda, oliguria con Na urinario < 10, sedimento inactivo y sin respuesta a 48 h de albúmina: síndrome hepatorrenal. Primera línea: terlipresina + albúmina IV, como puente al trasplante hepático.

Conocimientos generales 6 códigos

1.06.3.001 Vacunación de hepatitis A y B

Dónde se enseña: Tema 18.3 Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatitis B: vacuna universal en el PNI, al nacer y luego en la hexavalente (2, 4, 6 y 18 meses). RN de madre AgHBs +: vacuna + inmunoglobulina anti-VHB antes de 12 h; la lactancia está permitida.
- Hepatitis B en adultos de riesgo: personal de salud, hemodiálisis, VIH, hepatopatía crónica, contactos sexuales o domiciliarios de portadores, HSH; esquema de 3 dosis (0, 1, 6 meses) y verificar anti-HBs en personal de salud.

- Hepatitis A: dosis única a los 18 meses en el PNI chileno; también en hepatópatas crónicos, viajeros y manipuladores de alimentos.
- Post exposición a hepatitis A: convivientes inmunoglobulina + vacuna; contactos extradomiciliarios (jardín, colegio) vacuna.
- Accidente cortopunzante con fuente AgHBs + en no inmunizado: inmunoglobulina + vacuna. El anti-HBs aislado indica inmunidad por vacuna.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Recién nacido de término, sano, cuya madre tiene antígeno de superficie del virus hepatitis B (HBsAg) positivo detectado en el control prenatal. **¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir la transmisión vertical?**
>
> **A)** Vacuna contra hepatitis B e inmunoglobulina anti-hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida
> **B)** Solo vacuna hexavalente a los 2 meses según el calendario habitual
> **C)** Suspender la lactancia materna
> **D)** Inmunoglobulina anti-hepatitis B a los 2 meses
> **E)** Vacuna contra hepatitis A al nacer
>
> Respuesta A. Al hijo de madre HBsAg positiva se le administra vacuna contra hepatitis B e inmunoglobulina específica dentro de las primeras 12 horas; luego completa el esquema y se controla serología posvacunal. Esto previene más del 90% de la transmisión. La lactancia no está contraindicada y esperar la hexavalente deja al niño desprotegido.

1.06.3.002 Manejo dietético en enfermos digestivos

Dónde se enseña: Tema 2.3 Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Celíaca: dieta sin gluten estricta y de por vida (sin trigo, cebada, centeno; avena con precaución por contaminación cruzada); alimentos certificados.
- Intolerancia a la lactosa: reducir lactosa según tolerancia, leche sin lactosa o lactasa; mantener aporte de calcio.
- Cirrosis: restricción de sodio (<2 g/día) si hay ascitis; no restringir proteínas (1,2–1,5 g/kg/día), colación nocturna; restricción hídrica solo con hiponatremia severa.
- Intestino irritable: dieta baja en FODMAP y fibra soluble; constipación: fibra 20–30 g/día y agua; diarrea aguda: hidratación y alimentación habitual precoz.
- Reflujo: fraccionar, evitar comidas copiosas y tardías, grasas, alcohol y café; pancreatitis: realimentación precoz; colelitiasis: régimen hipograso; pancreatitis crónica: enzimas con las comidas.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 30 años con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca, confirmada con anticuerpos antitransglutaminasa y biopsia duodenal. Consulta por orientación dietética. **¿Cuál de los siguientes alimentos puede consumir libremente?**
>
> **A)** Pan de centeno
> **B)** Arroz y maíz
> **C)** Cerveza de cebada
> **D)** Galletas de trigo integral
> **E)** Sémola de trigo
>
> Respuesta B. La enfermedad celíaca se trata con una dieta estricta y de por vida libre de gluten: se excluyen trigo, cebada y centeno, y la avena contaminada. Arroz, maíz, papa, legumbres, carnes, frutas y verduras son naturalmente libres de gluten. En productos procesados conviene buscar el logo de alimento libre de gluten.

1.06.3.003 Epidemiología de los cánceres digestivos

Dónde se enseña: Tema 1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer gástrico: 1.ª causa de muerte por cáncer en hombres y 2.ª en mujeres en Chile; asociado a H. pylori, sal, ahumados, tabaco y familiar de primer grado.
- Cáncer de vesícula: Chile tiene una de las tasas más altas del mundo, ligado a colelitiasis (mujeres, ascendencia mapuche, obesidad); por eso GES de colecistectomía preventiva de 35 a 49 años.
- Cáncer colorrectal: en aumento; factores: edad >50, dieta rica en carnes rojas y procesadas, obesidad, sedentarismo, EII, antecedentes familiares y síndromes hereditarios.

- Cáncer de esófago: escamoso (tabaco, alcohol, cáusticos) y adenocarcinoma (ERGE, Barrett, obesidad). Hepatocarcinoma: cirrosis por VHB, VHC, alcohol, NASH.
- Cáncer de páncreas: tabaco, obesidad, diabetes, pancreatitis crónica; muy mal pronóstico.
- Los cánceres digestivos dan síntomas tardíos (baja de peso, anemia, hemorragia): la clave es la endoscopía precoz y los tamizajes.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> En una reunión clínica de un CESFAM se revisa la epidemiología de los cánceres digestivos en Chile para priorizar la derivación de pacientes con epigastralgia. **¿Cuál es el cáncer digestivo que causa más muertes en hombres en Chile?**
>
> **A)** Cáncer colorrectal
> **B)** Cáncer de esófago
> **C)** Cáncer gástrico
> **D)** Cáncer de vesícula biliar
> **E)** Hepatocarcinoma
>
> Respuesta C. El cáncer gástrico es la principal causa de muerte por cáncer digestivo en hombres chilenos, con mayor incidencia en el centro-sur del país; por eso existe el GES y la endoscopía precoz ante epigastralgia en mayores de 40 años. El cáncer de vesícula es característico de mujeres chilenas y el colorrectal va en aumento.

1.06.3.004 Métodos de tamizaje para cáncer de colon y hepatocarcinoma

Dónde se enseña: Tema 2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer colorrectal en riesgo promedio: tamizaje desde los 50 años con test de sangre oculta inmunoquímico anual o bienal, o colonoscopía cada 10 años.
- Test positivo: colonoscopía, que confirma y reseca adenomas (la secuencia adenoma-carcinoma tarda ~10 años).
- Sintomático o con alarma (anemia, constipación nueva, rectorragia): colonoscopía directa, no sangre oculta.
- Alto riesgo: familiar de primer grado con cáncer colorrectal, EII de 8–10 años (colonoscopía de vigilancia), poliposis adenomatosa familiar y Lynch (vigilancia intensiva desde edades tempranas).
- Hepatocarcinoma: ecografía abdominal cada 6 meses (± alfafetoproteína) en todo cirrótico y en portadores de VHB de alto riesgo, incluso si se erradicó el VHC.
- Nódulo sospechoso en la ecografía o AFP en alza: TAC o RM trifásica.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 55 años, asintomático, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer ni de pólipos, consulta en su CESFAM para un examen preventivo. **¿Cuál es el método de tamizaje de cáncer colorrectal recomendado en este paciente?**
>
> **A)** Colonoscopía virtual por TAC cada 2 años
> **B)** Antígeno carcinoembrionario anual
> **C)** Test inmunológico de sangre oculta en deposiciones y, si es positivo, colonoscopía
> **D)** Tacto rectal anual
> **E)** Enema baritado cada 5 años
>
> Respuesta C. En población de riesgo promedio desde los 50 años, el tamizaje en Chile se hace con test inmunológico de hemorragia oculta en deposiciones; si es positivo, colonoscopía. El CEA no sirve para tamizaje, solo para seguimiento del cáncer tratado. En hepatocarcinoma, en cambio, se tamiza al cirrótico con ecografía cada 6 meses.

1.06.3.005 Antiinflamatorios no esteroidales y tracto gastrontestinal

Dónde se enseña: Tema 1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

QUÉ HAY QUE SABER

- Los AINE inhiben la COX y las prostaglandinas protectoras de la mucosa: dispepsia, erosiones, úlcera péptica (sobre todo gástrica), hemorragia y perforación; también lesiones de intestino delgado y colon.
- Factores de riesgo: edad >65 años, úlcera o HDA previa, dosis altas o varios AINE, uso conjunto de corticoides, anticoagulantes, antiagregantes o ISRS, y H. pylori.

- Prevención: usar la menor dosis por el menor tiempo; con riesgo, agregar IBP (omeprazol 20 mg/día) o usar inhibidor COX-2 (con precaución cardiovascular); erradicar H. pylori antes de AINE crónico.
- Úlcera por AINE: suspender el AINE e IBP por 8 semanas; si no se puede suspender, mantener IBP.
- Paracetamol como analgésico alternativo de menor riesgo digestivo; evitar AINE en cirróticos (falla renal) y en insuficiencia renal.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 161

Una paciente de 65 años, con antecedente de haber sido tratada de una úlcera duodenal hace 20 años, y de un infarto agudo al miocardio hace un año, utilizando aspirina 100 mg al día desde entonces, sufre un esguince de tobillo, por lo que se indica analgesia con diclofenco 100 mg cada 12 horas. En los días siguientes evoluciona con malestar general que va agravándose y se agrega disnea. Al examen físico presenta palidez mucocutánea, FC: 110x', PA: 110/66 mmHg, examen pulmonar normal y examen cardíaco que solo muestra taquicardia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,5 g/dl, hematocrito: 23% VCM: 58 ft, plaquetas: 370.000 por mm3, ferritina: 12 ng/ml. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, sin signos actuales de isquemia. **¿Cuál es el examen para proseguir el estudio etiológico?**

A) Prueba de antígeno en deposiciones para Helicobacter pylori
B) Niveles de vitamina B12
C) Biopsia de médula ósea
D) Endoscopía digestiva alta
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta D. Ferropenia (VCM 58, ferritina 12) en una posmenopáusica con antecedente de úlcera duodenal que usa aspirina y diclofenaco: la sospecha es sangrado péptico. Se estudia con endoscopía digestiva alta, que además permite tratar la lesión.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 161

Una paciente de 65 años, con antecedente de úlcera duodenal tratada hace 20 años y de infarto agudo al miocardio hace un año, usa aspirina 100 mg al día desde entonces. Por un esguince de tobillo se indica diclofenaco 100 mg cada 12 horas. En los días siguientes evoluciona con malestar general progresivo y disnea. Al examen presenta palidez mucocutánea, FC 110/min, PA 110/66 mmHg, examen pulmonar normal y solo taquicardia al examen cardíaco. Hemograma: hemoglobina 7,5 g/dL, hematocrito 23%, VCM 58 fL, plaquetas 370.000/mm3, ferritina 12 ng/mL. El ECG muestra taquicardia sinusal, sin signos actuales de isquemia. **¿Cuál es el examen para proseguir el estudio etiológico?**

A) Prueba de antígeno en deposiciones para Helicobacter pylori
B) Niveles de vitamina B12
C) Biopsia de médula ósea
D) Endoscopía digestiva alta
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta D. Anemia ferropénica en una paciente que usa aspirina más un AINE y tiene antecedente de úlcera sugiere pérdida digestiva alta por lesión péptica inducida por AINE. La endoscopía digestiva alta diagnostica, permite terapia y en ella se biopsia para Helicobacter pylori. El antígeno fecal no localiza la lesión y la sangre oculta no cambia la conducta.

1.06.3.006 Esteatopatía no alcohólica

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hígado graso metabólico (MASLD/NASH): la causa más frecuente de hepatopatía crónica, asociada a resistencia a la insulina, obesidad, DM2 y dislipidemia; sin consumo significativo de alcohol.
- Suele ser asintomático: transaminasas levemente elevadas con AST/ALT <1 y ecografía con hígado hiperecogénico ('brillante').
- Descartar otras causas: alcohol, virus B y C, fármacos, autoinmune, hemocromatosis.
- Evaluar fibrosis con índices no invasivos (FIB-4) o elastografía; la esteatohepatitis puede progresar a cirrosis y hepatocarcinoma.
- Tratamiento: bajar 7–10 % del peso con dieta y ejercicio, controlar diabetes, lípidos y PA; evitar alcohol. Las estatinas no están contraindicadas.
- Derivar si hay fibrosis avanzada o sospecha de cirrosis.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 102

Mujer con obesidad, que consume 2 a 3 copas de vino solo los fines de semana y está en tratamiento con estatinas, presenta transaminasas elevadas al doble del valor normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esteatohepatitis no alcohólica
B) Esteatohepatitis alcohólica
C) Hepatitis por fármacos
D) Hepatitis por virus C
E) Hepatitis autoinmune

Respuesta A. Obesidad con elevación leve de transaminasas y consumo de alcohol bajo el umbral de riesgo orienta a enfermedad hepática grasa no alcohólica, hoy llamada esteatosis asociada a disfunción metabólica. Las estatinas rara vez causan daño hepático relevante y no se suspenden por alzas menores a 3 veces el valor normal.

Exámenes e imagenología 15 códigos

1.06.4.001 Radiografía simple de abdomen

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 11.4 Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

QUÉ HAY QUE SABER

- Proyecciones de pie y acostado (o decúbito lateral); para buscar neumoperitoneo es mejor la radiografía de tórax de pie (aire bajo el hemidiafragma derecho).
- Obstrucción de intestino delgado: asas centrales dilatadas en escalera con válvulas conniventes y niveles hidroaéreos; colon: marco periférico dilatado con haustras que no cruzan todo el lumen.
- Vólvulo de sigmoides: asa en omega o 'grano de café' que nace de la fosa ilíaca izquierda; megacolon tóxico: colon transverso >6 cm.
- Otros hallazgos: calcificaciones (litiasis renal radiopaca, pancreatitis crónica), cuerpos extraños radiopacos, neumatosis intestinal en enterocolitis necrotizante.
- Utilidad limitada en dolor abdominal inespecífico; si no es concluyente, TAC de abdomen (zona de transición, viabilidad del asa).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 78 años, postrado y con constipación crónica, presenta distensión abdominal marcada, dolor cólico y ausencia de eliminación de gases y deposiciones de 2 días. La radiografía simple de abdomen muestra un asa colónica muy dilatada en forma de U invertida (grano de café), que nace en la pelvis y se proyecta hacia el hipocondrio derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Íleo biliar
B) Vólvulo de ciego
C) Obstrucción de intestino delgado por bridas
D) Megacolon tóxico
E) Vólvulo de sigmoides

Respuesta E. El signo del grano de café, una U invertida que nace de la pelvis, es característico del vólvulo de sigmoides, típico de adultos mayores postrados y constipados. Sin signos de isquemia se intenta la devolvulación endoscópica. El vólvulo de ciego proyecta el asa hacia el hipocondrio izquierdo y el íleo biliar muestra aerobilia.

1.06.4.002 Tránsito esófago-estómago-duodeno

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio radiológico con bario ingerido que evalúa la anatomía y el paso del contraste por esófago, estómago y duodeno.
- Indicado en disfagia alta (divertículo de Zenker: examen de elección), sospecha de acalasia ('pico de pájaro' con esófago dilatado), estenosis, anillos y hernia hiatal.
- No reemplaza a la endoscopía en disfagia lógica o sospecha de cáncer (la endoscopía permite biopsia).

- Si se sospecha perforación, usar contraste hidrosoluble y no bario (peritonitis/mediastinitis por bario).
- El médico general emplea el informe para orientar el diagnóstico y derivar.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 74 años consulta por disfagia alta de 1 año de evolución, regurgitación de alimentos no digeridos horas después de comer, halitosis y tos nocturna. Al deglutir se escucha un gorgoteo cervical. **¿Cuál es el examen inicial de elección para confirmar el diagnóstico?**
> **A)** Manometría esofágica de alta resolución
> **B)** Tránsito esófago-estómago-duodeno (esofagograma con bario)
> **C)** pH-metría de 24 horas
> **D)** TAC de cuello con contraste
> **E)** Endoscopía digestiva alta con biopsias
> Respuesta B. La clínica sugiere un divertículo de Zenker. El esofagograma baritado lo demuestra como una bolsa posterior en la unión faringoesofágica y orienta la cirugía. La endoscopía no es el examen inicial porque al intubar a ciegas puede perforar el divertículo. La manometría es clave en la acalasia, no aquí.

1.06.4.003 Enema barritada

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio radiológico del colon con bario por vía rectal; hoy reemplazado en adultos por colonoscopía y colono-TAC.
- Utilidad clásica: Hirschsprung (zona de transición entre segmento agangliónico estrecho y colon dilatado; se confirma con biopsia rectal), colon 'en tubería' sin haustras en colitis ulcerosa, estenosis, divertículos y fístulas.
- Enema (neumático o hidrostático) guiado por imagen es tratamiento de primera línea en la invaginación intestinal del lactante, si no hay perforación ni peritonitis.
- Contraindicado en sospecha de perforación, megacolon tóxico y diverticulitis aguda; usar contraste hidrosoluble si hay riesgo de perforación.
- Lesión sospechosa en el enema: completar con colonoscopía y biopsia. El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Lactante de 2 meses con constipación desde el nacimiento y eliminación de meconio después de las 48 horas de vida. Presenta distensión abdominal y, al tacto rectal, ampolla vacía con salida explosiva de deposiciones y gases. **Si se realiza un enema baritado, ¿qué hallazgo apoya el diagnóstico más probable?**
> **A)** Signo de la cuerda en íleon terminal
> **B)** Microcolon con imagen en miga de pan en íleon
> **C)** Zona de transición entre un recto estrecho y un colon proximal dilatado
> **D)** Imagen en muelle enrollado en colon transverso
> **E)** Colon completamente normal
> Respuesta C. La sospecha es enfermedad de Hirschsprung. El enema baritado muestra el segmento distal agangliónico estrecho, una zona de transición y el colon proximal dilatado, con retención del contraste a las 24 horas. Se confirma con biopsia rectal sin células ganglionares. El muelle enrollado es de invaginación y el microcolon con miga de pan, del íleo meconial.

1.06.4.004 Colangiografía endoscópica

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- CPRE: técnica endoscópica que opacifica la vía biliar y pancreática; hoy es principalmente terapéutica (papilotomía, extracción de cálculos, prótesis).
- Indicaciones: colangitis aguda (CPRE urgente para drenar), coledocolitiasis confirmada por colangiorresonancia o vista en la ecografía, pancreatitis biliar con colangitis u obstrucción persistente, paliación de ictericia

obstructiva maligna.
- Para diagnóstico de la vía biliar se prefiere la colangiorresonancia, no invasiva.
- Complicaciones: pancreatitis post-CPRE (la más frecuente), hemorragia, perforación y colangitis.
- Tras la extracción de cálculos se indica colecistectomía electiva. El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 50 años con dolor en hipocondrio derecho e ictericia de 3 días, sin fiebre. Bilirrubina total 5 mg/dL, de predominio directo. La ecografía muestra colelitiasis y un colédoco de 12 mm con un cálculo de 8 mm en su porción distal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?**
>
> **A)** Colangiorresonancia para confirmar el cálculo
> **B)** Ácido ursodesoxicólico
> **C)** Colecistectomía sola, sin tratar la vía biliar
> **D)** CPRE con papilotomía y extracción del cálculo, seguida de colecistectomía
> **E)** TAC de abdomen con contraste
>
> Respuesta D. Si la ecografía ya demuestra el cálculo en el colédoco, la sospecha es alta y no se necesita colangiorresonancia: la CPRE es diagnóstica y terapéutica, con papilotomía y extracción. Luego se realiza la colecistectomía, idealmente en el mismo ingreso. La colangiorresonancia se reserva para la sospecha intermedia, sin cálculo visible.

1.06.4.005 TAC abdominal

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de abdomen y pelvis con contraste EV: examen de elección en diverticulitis (Hinchey), complicaciones de pancreatitis, sospecha de tumor de páncreas, etapificación oncológica y abdomen agudo dudoso.
- Pancreatitis: no es necesario si hay dolor típico + lipasa >3 veces; indicado a las 72 h si hay duda o mala evolución (necrosis, colecciones).
- Obstrucción intestinal: identifica la zona de transición, la causa y signos de isquemia (gas en la pared o en la porta). Angio-TAC en isquemia mesentérica y hemorragia digestiva activa.
- Hepatocarcinoma: TAC trifásico con realce arterial y lavado portal.
- Precauciones: función renal (nefropatía por contraste), alergia al yodo, suspender metformina, radiación en embarazo. El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 45 años ingresa con dolor epigástrico intenso irradiado en cinturón, lipasa 8 veces el valor normal y ecografía con colelitiasis. A las 12 horas está hemodinámicamente estable, con buena respuesta a la analgesia y a la hidratación. **¿Cuándo está indicada la TAC de abdomen con contraste en esta paciente?**
>
> **A)** De inmediato, para confirmar el diagnóstico
> **B)** Antes de iniciar la hidratación
> **C)** Siempre a las 24 horas, para calcular el índice de Balthazar
> **D)** Nunca, porque el contraste empeora la pancreatitis
> **E)** Solo si hay duda diagnóstica o mala evolución, idealmente después de 72 horas
>
> Respuesta E. El diagnóstico ya está hecho con 2 de 3 criterios (dolor típico y lipasa sobre 3 veces lo normal), por lo que la TAC no se necesita al ingreso. Se pide ante duda diagnóstica o mala evolución, después de 72 horas, cuando la necrosis ya es evaluable y se puede calcular el índice de Balthazar.

1.06.4.006 Ecotomografía abdominal

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer examen en ictericia, dolor de hipocondrio derecho y masas hepáticas: barato, sin radiación, disponible.

- Vesícula: colelitiasis (imagen con sombra acústica), colecistitis (pared >4 mm, líquido perivesicular, Murphy ecográfico), pólipos (≥10 mm: colecistectomía).
- Vía biliar: colédoco >6–7 mm indica obstrucción (sospecha de coledocolitiasis; completar con colangiorresonancia); vía biliar dilatada sin dolor en adulto mayor sugiere tumor.
- Hígado: esteatosis (hiperecogénico), cirrosis (nodular, esplenomegalia, ascitis), lesiones focales (quiste anecogénico, hemangioma hiperecogénico); tamizaje semestral de hepatocarcinoma.
- Limitaciones: gas intestinal y obesidad; páncreas y colédoco distal mal visualizados (TAC si se sospecha masa pancreática). El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años con ictericia, coluria y prurito de 1 semana. Bilirrubina total 6 mg/dL, de predominio directo, con FA y GGT elevadas y transaminasas levemente alteradas. **¿Cuál es el primer examen de imagen que se debe solicitar?**

A) Ecografía abdominal
B) Colangiorresonancia
C) CPRE
D) TAC de abdomen con contraste
E) Cintigrafía hepatobiliar

Respuesta A. Ante una ictericia con patrón colestásico, la ecografía abdominal es el primer examen: es barata, inocua y distingue la colestasia extrahepática (vía biliar dilatada) de la intrahepática (vía no dilatada), además de mostrar cálculos. Según su resultado se decide colangiorresonancia, TAC o CPRE.

1.06.4.007 Endoscopía digestiva alta y baja

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett · Tema 1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori · Tema 2.4 Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn · Tema 5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Endoscopía alta: examen de elección con biopsias en dispepsia ≥40 años o con alarma (GES cáncer gástrico), disfagia lógica, HDA (diagnóstica y terapéutica), ingesta de cáustico (precoz, 12–24 h), cuerpo extraño esofágico y pesquisa de várices en cirróticos.
- Hallazgos clave: úlcera (duodenal erradicar; gástrica biopsiar y controlar), Barrett (metaplasia intestinal en biopsia), esofagitis, várices; HDA clasificada por Forrest (sangrado activo y vaso visible = alto riesgo).
- Colonoscopía: sintomáticos con alarma, test de sangre oculta positivo, tamizaje cada 10 años desde los 50, EII (colonoscopía con ileoscopía y biopsias) y vigilancia de pólipos.
- Contraindicadas en perforación (úlcera perforada, Boerhaave) y en diverticulitis aguda (colonoscopía a las 6–8 semanas).
- Preparación: ayuno para la alta; preparación de colon con polietilenglicol para la colonoscopía. El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS (4)

Pregunta de práctica

Hombre de 56 años con 2 años de pirosis que trata con omeprazol a demanda. Hace 2 meses siente que los sólidos se le quedan detenidos tras el esternón y ha bajado 5 kg. Hemoglobina 11,2 g/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Duplicar la dosis de omeprazol por 8 semanas
B) Radiografía de tórax
C) pH-metría esofágica de 24 horas
D) Manometría esofágica
E) Endoscopía digestiva alta con biopsias

Respuesta E. Disfagia, baja de peso, anemia e inicio después de los 50 años son signos de alarma: obligan a endoscopía digestiva alta con biopsias para descartar cáncer, Barrett o estenosis. Escalar el IBP sin estudiar retrasa el diagnóstico; la pH-metría y la manometría no muestran la mucosa.

Pregunta de práctica

Hombre de 61 años consulta por melena. La endoscopía digestiva alta muestra una úlcera gástrica de 2 cm en la curvatura menor, sin sangrado activo. Las biopsias son negativas para neoplasia y el test de ureasa es positivo. Se indica erradicación de Helicobacter pylori y omeprazol. **¿Cuál es el seguimiento más adecuado?**

A) Endoscopía digestiva alta de control con nuevas biopsias a las 8 a 12 semanas
B) Test de aire espirado como único control
C) Alta sin controles, ya que la biopsia fue negativa
D) Serología para Helicobacter pylori a las 4 semanas
E) TAC de abdomen a los 6 meses

Respuesta A. Toda úlcera gástrica se controla con endoscopía y nuevas biopsias a las 8–12 semanas hasta confirmar su cicatrización, porque una biopsia inicial negativa no descarta cáncer. Ese control permite además verificar la erradicación. La úlcera duodenal no complicada no requiere endoscopía de control.

Pregunta de práctica

Mujer de 29 años con colitis ulcerosa conocida consulta por 10 deposiciones con sangre al día, fiebre de 38,6 °C y FC 115 por minuto. Abdomen distendido y sensible. La radiografía de abdomen muestra el colon transverso dilatado a 7 cm. **Respecto de la endoscopía, ¿cuál es la conducta correcta?**

A) Colonoscopía total urgente para evaluar la extensión
B) No realizar colonoscopía; hospitalizar con corticoides endovenosos y evaluación quirúrgica precoz
C) Colonoscopía con biopsias para descartar citomegalovirus antes de tratar
D) Enema baritado de doble contraste
E) Endoscopía digestiva alta para descartar compromiso gástrico

Respuesta B. Es un megacolon tóxico: colon de más de 6 cm con toxicidad sistémica. La colonoscopía y el enema baritado están contraindicados por el alto riesgo de perforación. Se hospitaliza con régimen cero, corticoides endovenosos y evaluación quirúrgica precoz; a lo más, una rectoscopía cuidadosa con mínima insuflación.

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años, usuario de antiinflamatorios por artrosis, consulta por 2 episodios de melena. Al ingreso FC 110 por minuto y PA 100/60 mmHg; tras la reanimación con cristaloides, FC 88 por minuto y PA 120/70 mmHg. Hemoglobina 9,8 g/dL. Se inicia IBP endovenoso. **¿Cuál es el momento más adecuado para la endoscopía digestiva alta?**

A) En forma electiva a las 4 a 6 semanas
B) Inmediatamente, antes de iniciar la reanimación
C) Dentro de las primeras 24 horas, una vez estabilizado
D) Solo si vuelve a sangrar
E) Después de una colonoscopía, para descartar origen bajo

Respuesta C. En la hemorragia digestiva alta no variceal la endoscopía se realiza dentro de las 24 horas, después de estabilizar: identifica la causa, permite terapia endoscópica y estratifica el riesgo de resangrado con la clasificación de Forrest. Endoscopiar sin reanimar aumenta las complicaciones; en la sospecha variceal se busca hacerla dentro de 12 horas.

1.06.4.008 Biopsia hepática

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Estándar para evaluar inflamación (grado) y fibrosis (estadio) en hepatopatías crónicas y para diagnóstico etiológico cuando los exámenes no invasivos no son concluyentes.
- Indicaciones: hepatitis autoinmune, colestasis de causa no aclarada, sospecha de NASH con fibrosis, enfermedades de depósito; hoy la elastografía la reemplaza en muchos casos.
- Contraindicaciones de la percutánea: coagulopatía (INR alto), trombocitopenia, ascitis importante (usar vía transyugular), sospecha de quiste hidatídico o lesión vascular.
- Complicaciones: dolor, hemorragia (la más grave), neumotórax, perforación biliar.
- El médico general emplea el informe para orientar el diagnóstico y derivar.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con hepatopatía crónica de causa no precisada pese a un estudio serológico completo. Se plantea biopsia hepática. Presenta ascitis moderada, INR de 1,9 y plaquetas de 60.000/mm3. **¿Cuál es la vía más adecuada para obtener la biopsia?**

A) Percutánea guiada por ecografía
B) Percutánea a ciegas tras transfundir plaquetas
C) Laparotomía exploradora
D) No está indicada; diagnosticar solo con transaminasas
E) Transyugular

Respuesta E. La biopsia hepática percutánea está relativamente contraindicada con ascitis, INR mayor de 1,5 o plaquetas bajas, por riesgo de sangrado. En estos casos se usa la vía transyugular, que obtiene tejido desde la vena hepática sin perforar la cápsula y permite medir el gradiente de presión portal.

1.06.4.009 Sangre oculta en deposiciones

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Test inmunoquímico (FIT): detecta hemoglobina humana, sin restricción dietaria; de elección para tamizaje de cáncer colorrectal en riesgo promedio desde los 50 años (anual o bienal).
- Test de guayaco: afectado por carnes rojas, vitamina C y hierro; menor especificidad.
- Positivo: colonoscopía obligatoria; no repetir el test para 'confirmar'.
- No usar en sintomáticos o con alarma (anemia, rectorragia, cambio del hábito): ir directo a colonoscopía; tampoco para estudiar anemia ferropénica.
- Un resultado negativo no descarta cáncer: continuar el tamizaje periódico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 56 años, asintomático y sin antecedentes familiares de cáncer, participa en un programa de tamizaje de cáncer colorrectal. El test inmunoquímico de sangre oculta en deposiciones resulta positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el test en 1 año
B) Repetir el test en 3 muestras más y decidir según el resultado
C) Solicitar antígeno carcinoembrionario
D) Colonoscopía completa
E) Rectoscopía rígida

Respuesta D. Un test de sangre oculta positivo en tamizaje obliga a colonoscopía completa, que identifica pólipos o cáncer y permite resecar y biopsiar. Repetir el test o pedir CEA retrasa el diagnóstico, y el CEA no sirve para tamizaje. La rectoscopía solo explora el recto y no descarta lesiones proximales.

1.06.4.010 Estudio de perfil hepático

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Bilirrubina: ictericia visible sobre 2,5–3 mg/dL. Indirecta aislada: Gilbert (joven, resto normal, observar) o hemólisis (anemia, LDH alta). Directa >30 % del total: siempre patológica.
- Patrón hepatocelular: transaminasas (AST, ALT) predominantes; >1.000 UI/L: virus, paracetamol, isquemia. AST/ALT >2: alcohol; <1: NASH o virus.
- Patrón colestásico: FA y GGT elevadas; GGT confirma origen hepatobiliar (FA alta con GGT normal = hueso).
- Siguiente paso en colestasia: ecografía siempre primero; luego colangiorresonancia o TAC según la sospecha.
- Integrar con la clínica: colestasia con dolor = cálculo; con dolor + fiebre = colangitis; indolora en adulto mayor = cáncer.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 90

Una paciente de 26 años consulta por dispepsia de varios meses de evolución. Al examen físico se observa ictericia de piel y escleras. Tiene antecedente de alteraciones en sus pruebas hepáticas hace 2 años. Pruebas hepáticas: bilirrubina total 2,2 mg/dL, bilirrubina directa 0,3 mg/dL, GOT 26 UI/L, GPT 23 UI/L, GGT 46 UI/L, FA 65 UI/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colangitis esclerosante primaria
B) Síndrome de Gilbert
C) Colestasia intrahepática
D) Hepatitis en resolución
E) Cirrosis biliar primaria

Respuesta B. Bilirrubina total elevada a expensas de la indirecta, con transaminasas, FA y GGT normales, en forma recurrente en una joven, es típico del síndrome de Gilbert, benigno y sin tratamiento. Las colestasias elevarían FA, GGT y bilirrubina directa, y una hepatitis elevaría las transaminasas. Debe descartarse hemólisis con hemograma.

1.06.4.011 Estudio de función hepática

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Evalúa la capacidad de síntesis del hígado: tiempo de protrombina/INR, albúmina; también bilirrubina, glicemia y amonio en la falla avanzada.
- TP/INR: el mejor marcador de gravedad en hepatitis aguda (INR ≥1,5 + encefalopatía = falla hepática aguda) y criterio de derivación a trasplante.
- Albúmina baja: síntesis disminuida (vida media ~20 días), refleja cronicidad; también baja en desnutrición y síndrome nefrótico.
- Child-Pugh (bilirrubina, albúmina, INR, ascitis, encefalopatía) y MELD (bilirrubina, INR, creatinina, sodio) estiman pronóstico.
- INR alto por vitamina K (colestasis, malabsorción) corrige con vitamina K parenteral; si no corrige, es falla de síntesis. No corregir el INR de rutina en cirróticos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Paciente de 45 años con cirrosis hepática conocida presenta una descompensación aguda. Se desea evaluar precozmente la capacidad de síntesis del hígado. **¿Cuál es el parámetro que refleja más rápidamente los cambios en la función de síntesis hepática?**

A) Tiempo de protrombina o INR
B) Albúmina plasmática
C) Transaminasas (GOT y GPT)
D) Fosfatasa alcalina
E) GGT

Respuesta A. Los factores de coagulación tienen vida media de horas (el factor VII, cerca de 6 horas), por lo que el tiempo de protrombina o INR refleja precozmente la función de síntesis. La albúmina tiene vida media cercana a 20 días y cambia lentamente. Las transaminasas indican necrosis hepatocelular, y FA y GGT, colestasia.

1.06.4.012 Estudio de marcadores virales para hepatitis A, B y C

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatitis A: IgM anti-VHA = infección aguda (primer examen en toda hepatitis aguda); IgG = infección pasada o vacuna.
- Hepatitis B: AgHBs = hay virus; IgM anti-HBc = es aguda. AgHBs + con IgM anti-HBc – = crónica (GES).
- AgHBs – con IgM anti-HBc + = período de ventana (sigue siendo aguda); anti-HBs + y anti-HBc IgG + = infección resuelta; anti-HBs aislado = inmune por vacuna (la vacuna no genera anti-HBc).
- AgHBe y ADN-VHB indican replicación e infectividad (seguimiento por especialista).

- Hepatitis C: anti-VHC como tamizaje; confirmar con ARN-VHC por PCR (anticuerpo + con PCR – = infección pasada resuelta).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 119

Hombre de 50 años, asintomático, se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran SGOT 332 UI/L y SGPT 210 UI/L, con bilirrubina de 1,5 mg/dL. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo traumático en 1992, que requirió transfusiones. **¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?**

A) Antígeno de superficie
B) IgM para VHA
C) Test de HOMA
D) TAC de abdomen
E) Anticuerpos totales contra VHC

Respuesta E. Transaminasas elevadas en un paciente transfundido antes de 1996, cuando en Chile aún no se tamizaba la sangre para virus C, obligan a buscar hepatitis C con anticuerpos totales anti-VHC; si son positivos, se confirma con carga viral. La IgM anti-VHA sirve para la hepatitis aguda, no para una infección crónica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 146 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, asociado a malestar general, astenia y náuseas, a lo que recientemente se agrega ictericia. Al examen físico, destaca ictericia de escleras, pulso regular a 76x', PA: 110/70 mmHg, abdomen blando, depresible, pero con dolor a la palpación del epigastro e hipocondrio derecho, sin visceromegalia ni signos peritoneales. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran tiempo de protrombinemia: 70%, SGOT: 512 UI/L, SGPT: 356 UI/L, FA: 230 UI/l, GGT: 120 UI/L, albúmina: 3,8 g/dl, bilirrubina total: 4 mg/dl, con 35% de bilirrubina directa. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) TAC abdominal
C) Endoscopía digestiva alta
D) Colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
E) Serología para virus hepatitis

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Serología para virus hepatitis (opción E). Bilirrubina >1.1 es alta; ictericia clínica aparece sobre 2.5-3 mg/dL De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.06.4.013 Laboratorio inicial de síndrome de malabsorción

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: diarrea crónica, baja de peso con ingesta conservada, esteatorrea y carencias.
- Exámenes generales: hemograma (anemia micro o macrocítica), ferritina, B12, folato, albúmina, calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, colesterol bajo y TP prolongado (déficit de vitamina K).
- Sudán en deposiciones confirma esteatorrea; test de D-xilosa localiza: alterado = pared (celíaca, Crohn, intestino corto), normal = enzimas (pancreatitis crónica, fibrosis quística).
- Dirigidos: anti-transglutaminasa IgA con IgA total, parasitológico seriado (Giardia), elastasa fecal, test del sudor en niños con neumonías recurrentes.
- Confirmar causa con endoscopía y biopsia duodenal o imagen pancreática según el resultado.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años con 5 meses de deposiciones voluminosas, pálidas y malolientes, que flotan y cuesta eliminar del inodoro, con baja de 7 kg. Usted sospecha un síndrome de malabsorción. **¿Cuál es el examen inicial más útil para confirmar la esteatorrea?**

A) Sudán III en deposiciones o esteatocrito
B) Coprocultivo
C) Test de sangre oculta en deposiciones
D) Leucocitos fecales
E) Calprotectina fecal

Respuesta A. El primer paso ante sospecha de malabsorción es objetivar la esteatorrea con Sudán III o esteatocrito; el estándar es la grasa fecal de 72 horas. Luego se busca la causa: D-xilosa para distinguir mucosa de páncreas, serología celíaca y elastasa fecal. Calprotectina y leucocitos fecales miden inflamación, no grasa.

1.06.4.014 Determinación toxina C difficile en deposiciones

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en diarrea (≥3 deposiciones líquidas/24 h) durante o tras uso de antibióticos, hospitalización prolongada, edad avanzada o IBP; solo en deposiciones diarreicas.
- Métodos: PCR del gen de la toxina o antígeno GDH + toxina A/B por inmunoensayo; alta sensibilidad de la PCR.
- Positivo con clínica compatible: infección por C. difficile; tratar con vancomicina oral (o metronidazol en casos leves según la clase) y suspender el antibiótico gatillante.
- No pedir en deposiciones formadas ni como test de curación (no se hace PCR de control); los portadores asintomáticos no se tratan.
- Gravedad: leucocitosis >15.000, creatinina >1,5 mg/dL, colitis pseudomembranosa o megacolon tóxico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 178

Un paciente de 65 años estuvo hospitalizado por una neumonía y, al cuarto día después del alta, inicia dolor abdominal asociado a diarrea acuosa, malestar general e incontinencia fecal, que han ido empeorando en los 7 días siguientes. Al examen tiene abdomen distendido, doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos aumentados. **¿Cuál es el examen de elección para el estudio inicial de este paciente?**

A) Colonoscopía
B) Coprocultivo
C) Recuento de leucocitos fecales
D) Parasitológico de deposiciones
E) Toxinas A y B de Clostridioides difficile en deposiciones

Respuesta E. Diarrea acuosa tras una hospitalización con antibióticos sugiere Clostridioides difficile. El estudio inicial es la detección de toxinas A y B o PCR en deposiciones, a menudo junto con GDH. El coprocultivo habitual no detecta toxinas y la colonoscopía se reserva para casos dudosos o graves. El tratamiento actual es vancomicina o fidaxomicina oral.

1.06.4.015 Colangiografía por resonancia magnética

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio no invasivo de elección para visualizar la vía biliar y pancreática, sin radiación ni contraste yodado.
- Indicación: sospecha de coledocolitiasis (colédoco dilatado >6–7 mm en ecografía o patrón colestásico con dolor) cuando la ecografía no muestra el cálculo; estenosis biliares, colangitis esclerosante, tumores de la vía biliar.
- Confirma el cálculo y orienta la CPRE terapéutica; si la ecografía ya ve el cálculo o hay colangitis, se va directo a CPRE.
- Contraindicaciones: marcapasos o implantes metálicos no compatibles, claustrofobia.
- El médico general emplea el informe para derivar a cirugía o gastroenterología.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años, colecistectomizada hace 2 años, consulta por dolor intermitente en hipocondrio derecho. Afebril, sin ictericia. Exámenes: bilirrubina total 1,8 mg/dL, FA 280 UI/L, GGT 310 UI/L. La ecografía abdominal muestra un colédoco de 8 mm sin cálculos visibles. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)
B) Repetir ecografía en 6 meses
C) Colangiorresonancia
D) TAC de abdomen sin contraste
E) Exploración quirúrgica de la vía biliar

Respuesta C. Colédoco dilatado y colestasia, sin cálculo visible ni colangitis, configuran un riesgo intermedio de coledocolitiasis: corresponde colangiorresonancia, no invasiva y muy sensible. La CPRE se reserva para riesgo alto o cálculo confirmado, por su riesgo de pancreatitis. La TAC sin contraste es poco sensible para cálculos coledocianos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 96 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace 6 meses por vía laparoscópica, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 45 UI/L, GPT: 52 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L, bilirrubina de 6,4 mg/dl y TP: 88%. ¿Cuál es el examen de elección para establecer el diagnóstico?

A) TAC de abdomen
B) Ecografía abdominal
C) Resonancia magnética nuclear abdominal
D) Colangioresonancia
E) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta D. Es una pregunta difícil y discutible. El diagnóstico más probable es una coledocolitiasis. Suele iniciarse con ecografía. De elección para el diagnóstico la colangioRMN (por eso la dejamos como respuesta correcta). Sirve, además, como examen no solo diagnóstico, sino terapéutico, la CPRE (la que se pide si 1. la ecografía ve cálculos en el colédoco [no en la vesícula], 2. la CPRE confirma el diagn

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 73 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 40 años, con antecedente de colecistectomía laparoscópica hace un año por colelitiasis, consulta por cuadro de 24 horas de dolor abdominal asociado a vó- mitos e ictericia. Su perfil hepático muestra GOT: 42UI/L, FA: 450mg/dL, bilirrubina total es de 10,3mg/dL, con bilirrubina directa de 9,5 mg/dL. Se realiza una ecografía abdomi- nal que muestra dilatación de la vía biliar principal, sin visualización de cálculos. El examen de elección para continuar el estudio es:

A) Colangioresonancia
B) Colangiografía endoscópica
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Exploración quirúrgica
E) Marcadores tumorales

Respuesta A. A, B? La sospecha es una coledocolitiasis residual y la verdad es que no existe una única forma de enfrentarla. La evidencia no es clara y las recomendaciones son muy variables. Por un lado, la conlangioresonancia da mucha información y en el algún mo- mento, la sociedad chilena de cirugía la recomendó antes que la CPRE, por tener menos efectos adversos y poder diferencias aquellos pacientes que s

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 1 códigos

1.06.5.001 Paracentesis

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstica: a todo cirrótico con ascitis de reciente inicio, que se hospitaliza o descompensa (fiebre, dolor, encefalopatía, falla renal). Evacuadora: ascitis a tensión o refractaria.
- Técnica: paciente en decúbito, punción en fosa ilíaca izquierda (unión del tercio externo y medio de la línea ombligo–espina ilíaca anterosuperior), asepsia, aguja fina en técnica en Z; evitar cicatrices y vasos epigástricos.

- Estudio del líquido: recuento celular (PMN ≥250/mm³ = PBE), albúmina para GASA (≥1,1 g/dL = hipertensión portal), proteínas, cultivo en frascos de hemocultivo, citología si se sospecha cáncer.
- Evacuadora >5 L: reponer albúmina ~8 g por litro extraído para evitar disfunción circulatoria; siempre hacer primero la diagnóstica para descartar PBE.
- La coagulopatía del cirrótico no la contraindica de rutina; evitar en CID o fibrinólisis franca. Complicaciones: filtración de líquido, hematoma de pared, perforación intestinal (rara).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 61 años con cirrosis y ascitis presenta dolor abdominal difuso, fiebre de 38 °C y leve confusión. Se realiza paracentesis diagnóstica. **¿Qué hallazgo del líquido ascítico confirma peritonitis bacteriana espontánea?**

A) Recuento de polimorfonucleares de 250/mm3 o más
B) Proteínas mayores de 2,5 g/dL
C) Gradiente de albúmina suero-ascitis mayor de 1,1 g/dL
D) Glucosa menor de 50 mg/dL con múltiples gérmenes en el Gram
E) Recuento de glóbulos rojos mayor de 10.000/mm3

Respuesta A. La PBE se define por 250 o más polimorfonucleares por mm3 en el líquido ascítico, sin foco quirúrgico. Se trata con cefotaxima o ceftriaxona y albúmina. Un GASA mayor de 1,1 indica hipertensión portal, no infección. Glucosa baja con flora polimicrobiana sugiere peritonitis secundaria por perforación, que requiere TAC y cirugía.